



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN SEPTEMBER
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi..... 2

2.3 Motto..... 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 5

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)..... 5

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 5

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO..... 5

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut..... 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 5

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 5

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 5

3.3.2 Rawat Inap 5

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)..... 5

3.3.4 Maternitas..... 5

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)..... 5

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO)..... 5

3.4 Kinerja Bidang Penunjang..... 7

3.4.1 Instalasi Farmasi 7

3.4.2 Laboratorium 7

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 7

3.4.4 Radiologi..... 7

3.4.5 Gizi 7

3.4.6 CSSD - Laundry 7

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan 8

3.5.1 MFK dan K3RS..... 7

3.5.2 Security..... 7

3.5.3 Parkir..... 7

3.5.4 Humas Marketing 7

3.5.5 Penjaminan 7

3.5.6 PIPP – MOD - MPP..... 7

3.5.7 *Cleaning Service* 7

3.6 Komite dan Tim 7

3.6.1 Komite Mutu..... 7

3.6.2 Komite PPI 7

3.6.3 Tim PKRS 7

3.6.5 Tim Prognas..... 7

3.7 Klaim Pending 10

3.7.1 Analisis..... 10

3.7.2 Tindak Lanjut.....	10
3.8 Permasalahan Rumah Sakit.....	44
3.9 Profil SDM	48
3.9.1 Komposisi dan Distribusi SDM	48
3.9.2 Update STR/SIP.....	51
3.10 Kemajuan Piutang	52
3.10.1 Data Piutang yang Belum Terbayar.....	52
3.10.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang	53
3.10.3 Update IKS.....	54
Bab V Kesimpulan dan Saran	104
Bab VI Penutup	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan September Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

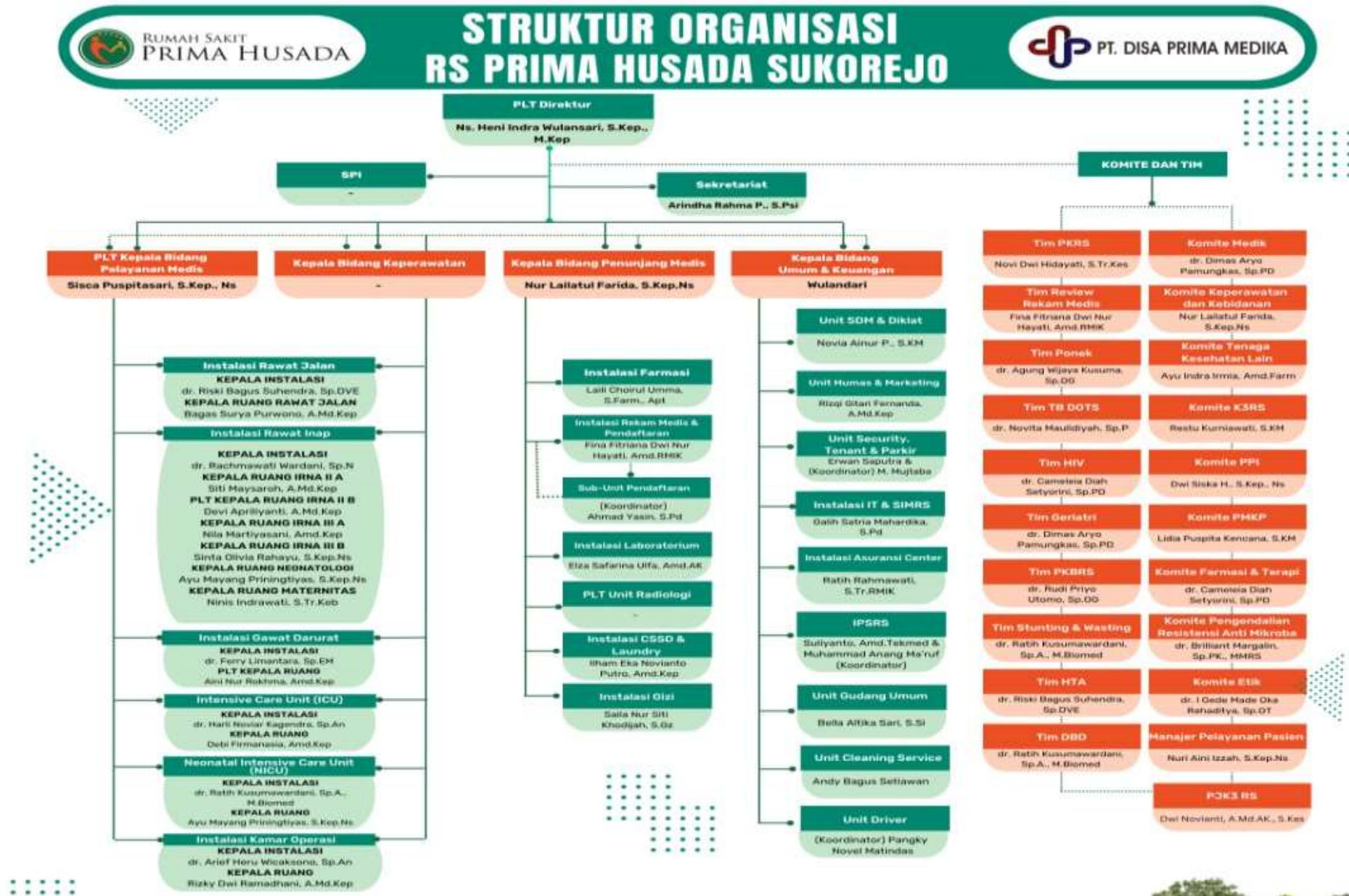
Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Dipercaya
3. Tanggung Jawab
4. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

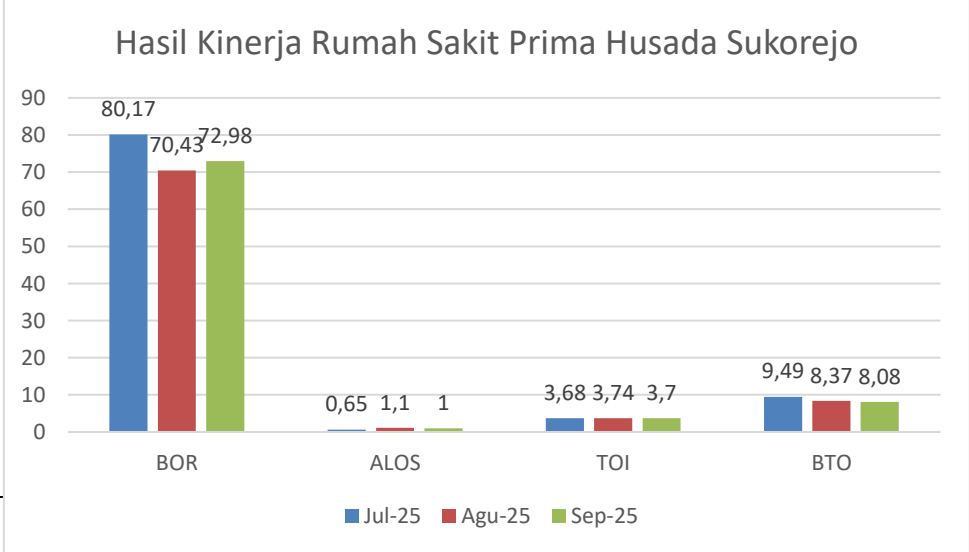
Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai berikut :



BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT,BOR,ALOS,BTO,TOI)

3.1.1 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO



3.1.2 Analisa dan Tindak Lanjut

Berikut adalah analisis kinerja indikator pelayanan rawat inap Rumah Sakit RSPHS untuk bulan 2025, berdasarkan empat indikator utama: BOR, LOS, TOI, dan BTO

Indikator	Juli 2025	Ags 2025	Sept 2025	Standar Ideal	Evaluasi Umum
BOR (Bed Occupancy Rate)	80%	70%	73%	60–85%	Semua dalam standar, turun di Bulan Juni, naik kembali di Juli
LOS (Length of Stay)	4 hari	4hari	4 hari	BPJS: 3 Umum: 6–12	Stabil, tidak sesuai untuk BPJS
TOI (Turn Over Interval)	1 hari	1 hari	1 hari	1–3 hari	Stabil
BTO (Bed Turn Over)	9 kali	8 kali	8 kali	4–5 kali	Konsisten tinggi mengalami penurunan di Bulan Juli, di atas standar

a. Analisis Tren Per Bulan

- 1) BOR (Bed Occupancy Rate)
- Juli : 80% → terjadi kenaikan
 - Agustus : 70% → terjadi penurunan
 - September : 73% → terjadi kenaikan
- Tren: Adanya penurunan dan kenaikan sejak bulan Juli,

Beberapa faktor terjadinya kenaikan nilai BOR di Bulan September

- Jumlah kenaikan jumlah pasien yang masuk di Bulan September, rata-rata pasien masuk di Bulan Agustus 50 pasien per hari, sedangkan pasien masuk di September 52 pasien per hari
- Selain jumlah pasien yang masuk lebih tinggi, faktor lain yaitu jumlah hari yang lebih sedikit menjadi faktor BOR naik walaupun jumlah pasien keluar lebih sedikit.
- Faktor internal
 - Fasilitas dan sarana prasarana yang baik menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar

- Sikap tenaga medis dan staf yang membuat nyaman konsumen dengan adanya pembenahan jika ada kendala yang terjadi
- Faktor eksternal
- Adanya kepercayaan dan citra yang baik di lingkungan masyarakat terkait RS Prima Husada Sukorejo
- Adanya perubahan kebijakan terkait lama dirawat pasien BPJS kesehatan yang harus dirawat minimal 3 hari.

1) LOS (Length of Stay)

- Stabil di angka 4 hari untuk tiga bulan berturut-turut.
- Tidak sesuai SE PT.DPM untuk pasien BPJS, tetapi terlalu rendah untuk pasien umum (standar: 6–12 hari).
- Sedangkan pada Bulan September Dengan lama dirawat 1-3 hari = 727 = 51,2%, dengan lama dirawat 4-15 hari = 693 = 48,8%
- Adanya pasien yang dirawat melebihi SE dari PT DPM, perlu dikaji terkait indikasi dirawat pasien
- Adanya perubahan kebijakan terkait lama dirawat pasien BPJS kesehatan yang harus dirawat minimal 3 hari

Tren: Konsisten, tetapi perlu audit LOS pasien.

2) TOI (Turn Over Interval)

- Stabil di angka 1 hari untuk tiga bulan berturut-turut.

Tren: Konsisten, tetapi perlu adanya penggantian fasilitas kamar dan menjaga kebersihan ketika akan pergantian pasien sehingga infeksi nosocomial dapat diminimalisir

3) BTO (Bed Turn Over)

- Juli : 9 kali
- Agustus : 8 kali
- September : 8 kali

Tren: Terlalu tinggi dari standar ideal (4–5 kali), yang bisa menandakan rotasi pasien sangat cepat → perlu dievaluasi dari aspek beban kerja, mutu layanan, dan risiko infeksi nosocomial.

a. Permasalahan yang Muncul

Isu	Penjelasan
Fluktuasi BOR	Bisa mencerminkan ketidakteraturan alur pasien atau perbedaan kebijakan antar bulan.
LOS terlalu singkat untuk pasien umum LOS terlalu lama untuk pasien BPJS	- Risiko pemulangan dini, kemungkinan readmisi meningkat. - Risiko meningkatkan penggunaan BMHP dan penggunaan kamar yang lebih lama
BTO tinggi secara konsisten	Potensi beban kerja berat bagi tenaga medis, penurunan mutu perawatan, dan tekanan administratif.
TOI rendah	Efisien, tetapi dalam konteks BTO tinggi → bisa berarti pasien terlalu cepat digantikan.

b. Rekomendasi Tindak Lanjut

- 1) Evaluasi Manajemen Pelayanan Rawat Inap
 - Tinjau alur pasien dan penyebab fluktuasi BOR.
 - Koordinasi antar unit untuk menjaga kestabilan utilisasi tempat tidur.
 - Rotasi pasien masuk dan keluar yang sangat cepat, kebutuhan kamar sangat tinggi.
- 2) Audit LOS Berdasarkan Jenis Pasien
 - Pisahkan analisa LOS pasien BPJS dan umum.
 - Cek outcome klinis untuk mendeteksi risiko pemulangan terlalu dini.
 - Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya untuk memonitor pasien BPJS yang sudah melebihi lama rawat 3 hari, perlu dikaji kembali terkait kondisi dan indikasi medis pasien.
- 3) Kaji Kembali Beban Kerja SDM
 - Lakukan survei kepuasan dan kelelahan staf medis akibat BTO tinggi.
 - Pertimbangkan redistribusi staf atau perekrutan tambahan jika diperlukan.
- 4) Implementasi Sistem Bed Management
 - Gunakan sistem digital untuk manajemen tempat tidur real-time dan efisiensi ruang rawat inap.
- 5) Monitoring Mutu Layanan
 - Pantau indikator mutu lain seperti readmisi, komplain pasien, dan kepuasan pasien pasca rawat inap.

c. Kesimpulan Akhir

RSPHS menunjukkan kinerja indikator rawat inap secara umum dalam standar, tetapi:

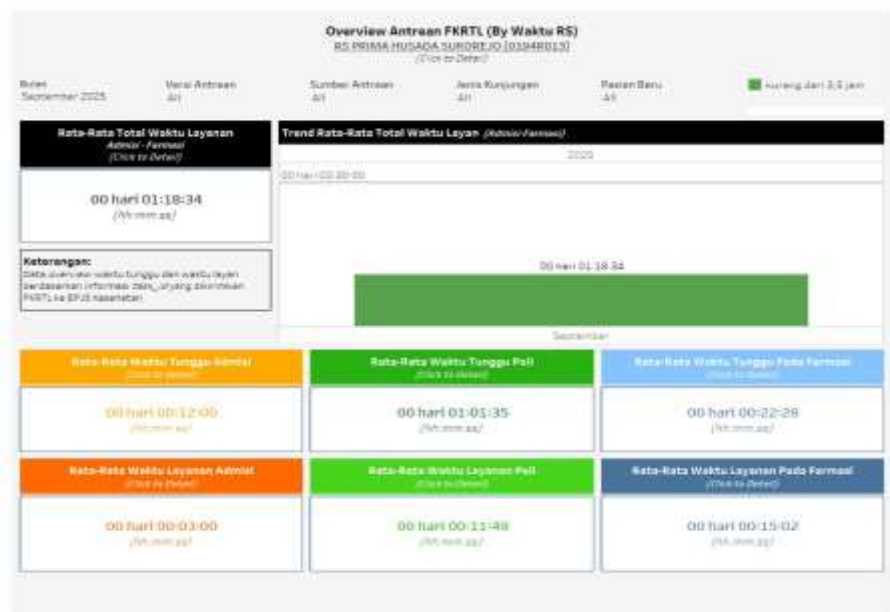
- Ada fluktuasi BOR yang perlu distabilkan.
- BTO terlalu tinggi secara konsisten, bisa berdampak pada mutu dan beban kerja.

LOS tetap 4 hari, tidak ideal bagi pasien BPJS maupun umum dan asuransi

3.1.3 Antrian Online BPJS Kesehatan

A. Profil Pelayanan Antrian Online

Update Pemanfaatan Antrean Online FKRTL



B. Kendala

Belum ada kendala dalam pelaksanaan

C. Rencana Tindak Lanjut

- 1. Monev pelaksanaan alur antrian online oleh karu dan kabid
- 2. Evaluasi oleh kabid Ketika ada waktu antrian online yg panjang

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

No	Recana Pengembangan	Keterangan		Konfirmasi
		Tercapai	Belum Tercapai	
1	Penambahan unit dialisis	√		Ijin operasional per tanggal 1 Juli 2025 dan bisa melayani pasien Umum per tanggal 17 September 2025
2	Penambahan depo farmasi di IGD	√		Berjalan mulai Bulan Januari dengan 1 staf per sift
3	Penambahan microfon pengeras suara untuk pemanggilan keluarga pasien di IGD	√		
4	Penambahan ruang isolasi ICU	√		
5	Pelayanan doa bersama seminggu 2x	√		Pembimbing doa dari staf internal dan dari pengajian sirotul jannah
6	Penambahan fasilitas pada ruang anggrek (handuk, sabun, cantolan baju)	√		Pasien VIP sudah diberi fasilitas sandal, sabun dan sikat gigi
7	Penambahan mainan edukasi untuk pasien anak		√	
8	Penambahan hiasan pada dinding disetiap ruang anak dan nurse station		√	
9	Nursecall intercom untuk komunikasi dengan pasien isolasi		√	

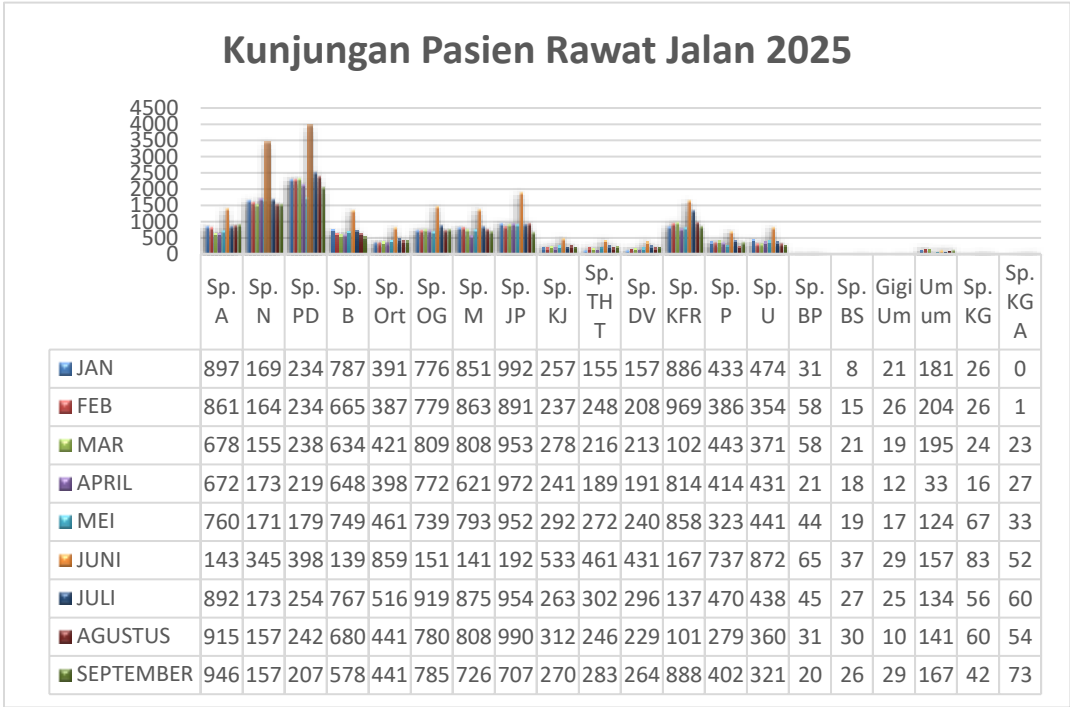
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

A. Tabel Kunjungan Pasien Rawat Jalan 2025

Nama POLIKLINIK	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025	%
Anak	760	800	892	915	946	↑ 0,03%
Bedah Umum	749	668	767	680	578	↓ 0,17%
Bedah Plastik	44	753	45	31	20	↓ 0,55%
Bedah Syaraf	19	37	27	30	26	↓ 0,15%
Gigi Umum	17	81	25	10	27	↑ 1,7%
Konservasi Gigi	67	47	56	60	42	↓ 0,42%
Gigi Anak	33	52	60	54	73	↑ 0,26%
Jantung	952	783	954	990	707	↓ 0,40%
Jiwa	292	267	263	312	270	↓ 0,15%
Kandungan	739	797	919	780	785	↑ 0.006%
Klinik Kulit dan Kelamin	240	244	296	229	264	↑ 0.13%
Mata	793	775	875	808	726	↓ 0.11%
Orthopedi	461	458	516	441	441	Tetap
Paru	323	415	470	279	402	↑ 3%
Penyakit Dalam	1791	1782	2548	2426	2075	↓ 0,16%
Klinik Rehab Medik	858	940	1376	1017	888	↓ 0,14%
Syaraf	1715	1684	1736	1578	1578	Tetap
THT	272	267	302	246	283	↑ 0,13%
Klinik Umum/MCU	124	72	134	141	167	↑ 0,15%
Urologi	441	426	438	360	321	↓ 0,12%
Klinik Komplementer	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10690	10717	12699	11487	10621	↓ 0,081%

B. Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan 2025



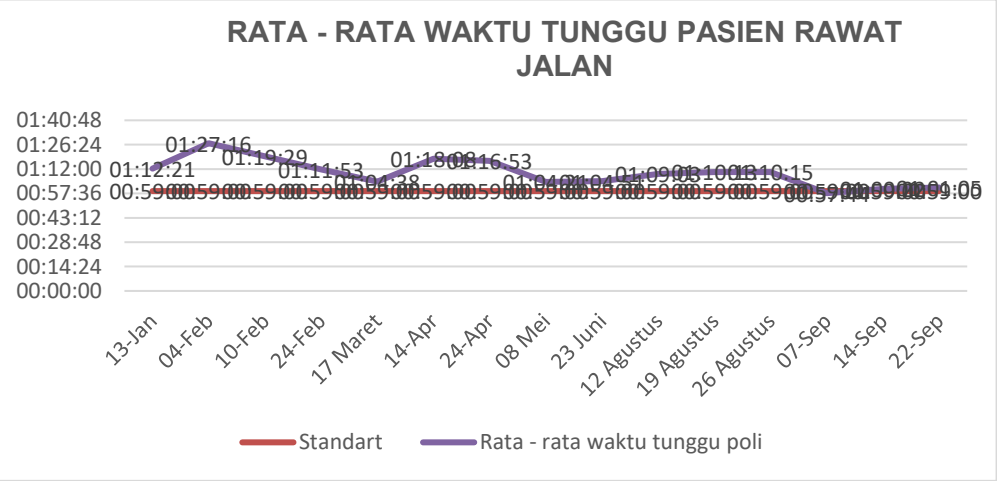
C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan Grafik 3.2 diatas menunjukkan terdapat penurunan kunjungan pasien pada bulan September 2025, yang tercermin dari jumlah poliklinik yang mengalami penurunan (11 poli) dibandingkan yang mengalami kenaikan (8 poli) dan tetap (2 poli). Ini mengindikasikan adanya tren negatif dalam pemanfaatan layanan rawat jalan di fasilitas kesehatan tersebut.

Tabel Waktu Tunggu Pasien Rawat Jalan

NO	Bulan	Rata-rata Waktu Tunggu Poli
1	13 Januari	01:12:31
2	4 Februari	01:27:16
3	10 Februari	01:19:29
4	24 Februari	01:11:53
5	17 Maret	01:04:38
6	14 April	01:18:08
7	24 April	01:16:53
8	08 Mei	01:04:21
9	23 Juni	01:04:51
10	12 Agustus	01:09.03
11	19 Agustus	01:10.13
12	26 Agustus	01:10.15
13	7 September	00:57:44
14	14 September	01:00:22
15	22 September	01:01:05

Grafik Waktu Tunggu Pasien Rawat Jalan



a. Analisa

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan adanya waktu tunggu poli lebih dari 60 menit sehingga tidak sesuai dengan standart waktu tunggu sesuai BPJS. Lamanya waktu tunggu poli disebabkan karena

- 1. Adanya poli yang mendaftarkan pasien lebih dari H- 1 jam buka Hfis DPJP
- 2. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan lebih awal jauh sebelum jam praktek dokter
- 3. Tindakan ESWL dan Katarak yang dilakukan (didaftarkan) jauh sebelum jam buka Hfis DPJP

b. Masalah

Problem	Tingginya waktu tunggu pasien rawat jalan > 60 menit yaitu 01:10:15
Step	Menurunkan waktu tunggu pasien rawat jalan menjadi < 60 menit
Plan	1. Rencana: a. Melakukan breakdown apa saja penyebab dari waktu tunggu yang lama b. Membuat alur baru setelah semua kendala ada c. Koordinasi dengan programmer untuk memilah inputan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang di SIMRS 2. Harapan Waktu tunggu layanan lebih pendek sesuai dengan standart yaitu kurang 59 menit 3. Tindakan a. Membuat aturan dan pemberitahuan untuk pelayanan pasien di Poli dengan pembayaran BPJS Kesehatan harus H-30 m3nit b. Mensosialisasikan kepada pasien dengan membuat flyer terkait kedatangan pasien c. Mensosialisasikan kepada pendfataran untuk pasien BPJS bisa dilayani H-30 menit d. Pasien dengan pemeriksaan penunjang, dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dilakukan pendaftaran e. Membuat flowchart alur baru f. Membuat alur baru terkait pelayanan pasien Tindakan ESWL dan Katarak
Do	1. Terapkan loket khusus untuk pengecekan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang dan Tindakan ESWL dan Katarak 2. Lakukan briefing langsung ke perawat, pendaftaran, dan satpam tentang alur baru
Study	1. Bandingkan waktu tunggu rata- rata sebelum dan sesudah intervensi 2. Kumpulkan data umpan balik pasien melalui survey singkat 3. Apakah perubahan menunjukkan penurunan waktu tunggu
Action	1. Review alur yang sudah berjalan 2. Cek berkala kendala yang terjadi di lapangan dan dokumentasikan

c. Rencana Tindak Lanjut

	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
	Tingginya waktu tunggu pasien rawat jalan > 60 menit yaitu 01:10:15	Waktu tunggu poli < 60 menit	Seluruh Poliklinik dan dokter spesialis	1. Buat alur baru terkait hal yang membuat waktu tunggu semakin lama 2. Review alur yang sudah berjalan 3. Cek berkala kendala yang terjadi di lapangan dan dokumentasikan	1. Pendaftaran 2. Perawat 3. Satpam	1 Bulan
	Adanya pembatasan rujukan dari Faskes 1 dengan jaminan BPJS PBI / UHC ke FKRTL	1. Mencegah adanya penurunan pasien BPJS yang drastic di Rawat Jalan	Seluruh poliklinik DPJP Pendaftaran CSO Pasien	1. Melakukan rapat dengan unit terkait 2. Membuat spreadsheet laporan pasien-pasien yang memiliki BPJS PBI / UHC namun menggunakan Umum 3. Membuat alur jika ada pasien dengan kondisi ini 4. Tunjuk 1 PIC untuk mengawasi alur baru ini	1. Pendaftaran 2. Perawat 3. Satpam 4. CSO	Bulan
	masih belum maksimal terisi untuk DPJP tertentu	Agah adanya penurunan pasien pada DPJP tertentu	Seluruh poliklinik DPJP Humas Marketing Pasien	1. Melakukan promosi baik digital maupun secara langsung oleh tim Humas dan Marketing kepada DPJP terkait 2. Share di semua media RS secara berulang 3. Tunjuk PIC untuk memonitoring promosi	1. Perawat 2. DPJP 3. Humas Marketing	n

Tabel Rekap data keterlambatan DPJP

NAMA DOKTER	JUMLAH KEHADIRAN	TERLAMBAT	TIDAK TERLAMBAT	% TERLAMBAT
dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG	21	5	16	25%
dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG	25	3	22	12%
dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG	17	3	14	18%
dr. Muhammad Irawan, Sp.A	21	1	20	5%
dr. Esti Purwaningrum, Sp.A	16	11	5	73%
dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed	24	22	2	105%
dr. Qashastia Sukma Paripurna Sp.A	21	12	9	71%
dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD	17	15	2	88%
dr. Heriyatmo, Sp.PD	21	1	20	5%
dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	24	0	24	0%
dr. Aditya Purwaka, Sp.PD	24	10	14	42%
dr. Ardityo Rahmat Ardhan, Sp.PD-KGH	9	6	3	75%
dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	21	3	18	14%
dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp.B	33	19	14	59%
dr. Zaki Yamani, Sp.B	13	4	9	40%
dr. Djanuar Fitriadi, Sp.B	21	18	3	106%
dr. Arianto Prabowo, Sp.OT	4	0	4	0%
dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT	9	0	9	0%
dr. Fiski Purantoro, Sp.OT	12	0	12	0%
dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp. BS	5	5	0	125%
dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	29	15	14	52%
dr. Aan Dwi Prasetio, Sp.N	18	10	8	67%
dr. Akhmad Zainul Arifin, Sp.N., M.Kes	21	9	12	43%
dr. Rachmawati Wardani Sp.N	12	3	9	25%
dr. Badariyatud Dini, Sp.BP-RE(K)	8	3	5	75%
drg. Normayanti, Sp. KG	7	1	6	14%
drg. Syafrini Farrahdebi	9	0	9	0%
drg. Dimas Surya Saputra. Sp.KGA	4	4	0	100%
dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	21	14	7	67%
dr. Novita Maulidiyah,	9	5	4	56%

Sp.P				
dr. Fitri Indahyanti, Sp.P., MMRS	9	3	6	33%
dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	12	7	5	58%
dr. Dion Setiawan, Sp. JP	7	6	1	100%
dr. Nurhadhi Sutanto, Sp.M	24	15	9	63%
dr. N. Indra Bayu, Sp.M	18	5	13	29%
dr. Latifah, Sp.M	21	7	14	35%
dr. Julian Hertawan, Sp.T.H.T.K.L	24	16	8	67%
dr. Fuad Fauzi, Sp.T.H.T.K.L.	13	12	1	92%
dr. Citra Dwi Harningtyas, Sp.DV., M.Ked.Klin	12	1	11	8%
dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE	21	15	6	71%
dr. Yekti Mumpuni, Sp.KJ	4	2	2	67%
dr. Andika Widiati, Sp.KJ	12	10	2	83%
dr. Erinda Rahma Mulia, Sp.KFR	13	2	11	17%
dr. Eko Nugroho, Sp.KFR	24	24	0	100%

Rekapan data Ijin DPJP

NAMA DOKTER	JUMLAH KEHADIRAN	TANGGAL IJIN	JUMLAH IJIN	KETERANGAN
dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG	21	9 Sept	1	Audit BPJS RS Sheila Sidoarjo
dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG	25		0	
dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG	17		0	
dr. Muhammad Irawan, Sp.A	21		0	
dr. Esti Purwaningrum, Sp.A	16	13 Sept	1	Kegiatan di RSUD
dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed	24	4-6 Sept	3	Kepentingan keluarga
dr. Qashastia Sukma Paripurna Sp.A	21	16 Sept 18 Sept 22-23 Sept	4	Acara Maulid Kepentingan keluarga Kepentingan keluarga
dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD	17		0	
dr. Heriyatmo, Sp.PD	21		0	
dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	24	9-10 Sept	2	Rapat dosen UNTAG
dr. Aditya Purwaka, Sp.PD	24		0	
dr. Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.PD-KGH	9	23 Sept	1	Kepentingan keluarga
dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	21		0	
dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp.B	33	19 Sept	1	Seminar
dr. Zaki Yamani, Sp.B	13	16-18 Sept	3	Seminar

dr. Djanuar Fitriadi, Sp.B	21	16-19 Sept	4	Seminar
dr. Arianto Prabowo, Sp.OT	4	10 Sept	1	Kepentingan keluarga
dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT	9		0	
dr. Fiski Purantoro, Sp.OT	12	6 Sept	1	Kepentingan keluarga
dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp. BS	5	9 Sept	1	Kepentingan keluarga
dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	29		0	
dr. Aan Dwi Prasetio, Sp.N	18	9 Sept 16 Sept 23 Sept	3	Kepentingan keluarga Rapat Dinkes Anak MRS
dr. Akhmad Zainul Arifin, Sp.N., M.Kes	21		0	
dr. Rachmawati Wardani Sp.N	12		0	
dr. Badariyatud Dini, Sp.BP-RE(K)	8	6 Sept 13 Sept 20 Sept 24 Sept	4	Kepentingan keluarga Sakit Kepentingan keluarga Kepentingan keluarga
drg. Normayanti, Sp. KG	7		0	
drg. Syafrini Farrahdebi	9		0	
drg. Dimas Surya Saputra. Sp.KGA	4		0	
dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	21		0	
dr. Novita Maulidiyah, Sp.P	9		0	
dr. Fitri Indahyanti, Sp.P., MMRS	9		0	
dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	12		0	
dr. Dion Setiawan, Sp. JP	7	27 Sept	1	Seminar
dr. Nurhadhi Sutanto, Sp.M	24		0	
dr. N. Indra Bayu, Sp.M	18	15 Sept	1	Kepentingan keluarga
dr. Latifah, Sp.M	21	24 Sept	1	Sakit
dr. Julian Hertawan, Sp.T.H.T.K.L	24		0	
dr. Fuad Fauzi, Sp.T.H.T.K.L.	13		0	
dr. Citra Dwi Harningtyas, Sp.DV., M.Ked.Klin	12		0	
dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE	21		0	
dr. Yekti Mumpuni, Sp.KJ	4	13 Sept	1	Sakit
dr. Andika Widiанти, Sp.KJ	12		0	
dr. Erinda Rahma Mulia, Sp.KFR	13	23 Sept	1	Sakit
dr. Eko Nugroho, Sp.KFR	24		0	

A. Analisa

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas menunjukkan adanya dokter spesialis yang terlambat dengan prosentasi > 50% yaitu dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed dengan prosentase 105%, dr. Esti Purwaningrum, Sp. A dengan prosentase 73%, dr. Qashastia Sukma Paripurna Sp.A dengan prosentase 71%, dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD dengan prosentase 88%, dr. Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.PD-KGH dengan prosentase 75%, dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp. B dengan prosentase 59%, dr. Djnuar Fitriadi, Sp. B dengan prosentase 106%, dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp. BS dengan prosentase 125%, dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N dengan prosentase 52%, dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp. N dengan prosentase 67%, dr. Badariyatud Diini, Sp. BP-RE (K) dengan prosentase 75%, drg. Dimas Surya Saputra, Sp. KGA dengan prosentase 100%, dr. Novita maulidiyah, Sp. P dengan prosentase 56%, dr. Maria valentina Evelyn, Sp. JP dengan prosentase 58%, dr. Dion Setiawan, Sp. JP dengan prosentase 100%, dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp. U dengan prosentase 67%, dr. Nurhadi Sutanto, Sp. M dengan prosentase 63%, dr. Julian Hertawan, SP. THT KL dengan prosentase 67%, dr. Fuad Fauzi Sp. THT KL dengan prosentase 92%, dr. Riski Bagus Suhendra, Sp. DVE dengan prosentase 71%, dr. Andika Widiyanti, Sp. KJ dengan prosentase 83%, dr. yekti Mumpuni, Sp. KJ dengan prosentase 67%, dan dr. Eko Nugroho, Sp. KFR dengan prosentase 100%.

B. Masalah

Problem	Angka keterlambat dokter spesialis > 50%
Step	Menurunkan angka keterlambatan dokter spesialis < 50 %
Plan	1. Rencana: Menurunkan keterlambatan dokter spesialis di rawat jalan 2. Harapan Tidak ada dokter spesialis yang terlambat 3. Tindakan a. Monitoring keterlambatan dokter spseialis di rawat jalan b. Ganti Hfis dokter sesuai jam kedatangan c. Membuat sistem pengingat ke DPJP setiap 15 menit sebelum praktek setiap dokter belum datang. d. Berikan raport kepada DPJP yang terlambat dan surat komitmen dalam kedisiplinan
Do	1. Ingatkan dokter 15 menit sebelum jadwal praktik 2. Sosialisasi Kembali kebijakan disiplin waktu praktek dokter spesialis 3. Memberi teguran secara tertulis (raport) kepada dokter spesialis yang terlambat > 50 %
Study	1. Terdapat 23 dokter spesialis dengan angka keterlambatan > 50% 2. Keterlambatan ke 23 dokter spesialis
Action	1. Ganti jadwal Hfis dokter spesialis yang sering terlambat sesuai jam kedatangan 2. Lakukan reward dan punishment bagi dokter terkait ketepatan waktu 3. Lakukan monitoring Bersama Komite Mutu dan Komite medik

C. Rencana Tindak Lanjut

Tabel Rencana Tindak Lanjut

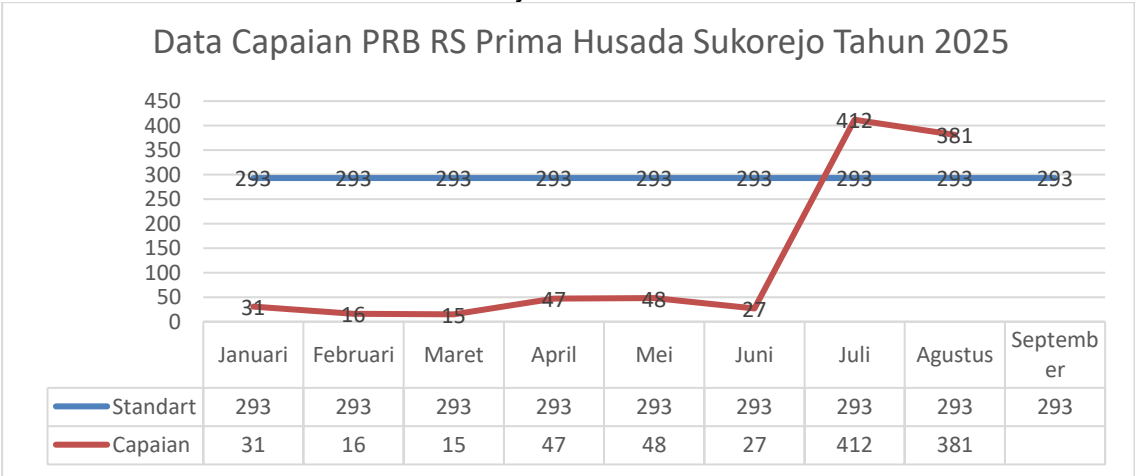
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
	Menurunkan angka keterlambatan dokter spesialis di rawat jalan	Meningkatkan kepuasan pasien dan mutu pelayanan	Seluruh dokter spesialis	1.Ganti jadwal Hfis dokter spesialis yang sering terlambat sesuai jam kedatangan	1.Dokter spesialis 2.Komite komdik 3.Komite Mutu	Bulan

				2.Lakukan reward dan punishment bagi dokter terkait ketepatan waktu 3.Lakukan monitoring Bersama Komite Mutu dan Komite medik		
--	--	--	--	--	--	--

Tabel Data PRB RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

NO	TARGET PRB	BULAN	JUMLAH PRB	KEKURANGAN
1	3.517	Januari	31	2.540
2		Februari	16	
3		Maret	15	
4		April	47	
5		Mei	48	
6		Juni	27	
7		Juli	412	
8		Agustus	381	
9		September		

Grafik Data PRB Rs Prima Husada Sukorejo



A. Analisa
 Berdasarkan Grafik 3.5 diatas menunjukkan bahwa capaian PRB belum mencapai standart. Dikarenakan pada pertengahan tahun ini untuk capaian PRB meningkat drastis 3.517 dari 192, dari yang semula target per bulan adalah 16 sekarang menjadi 293.

Tabel Pengisian Dokumen Rekam Medis Elektronik oleh DPJP Rawat Jalan September

NO	NAMA DOKTER	Σ DRM ALL	PAM			CPPT			KELENGKAPAN			
			Σ DRM	L	TL	Σ DRM	L	TL	PAM		CPPT	
									%L	%TL	%L	%TL
1	dr. Muhammad Irawan Sp.A.	455	106	71	35	349	349	0	67%	33%	100%	0%
2	dr. Esti Purwaningrum Sp.A.	125	43	22	21	82	82	0	51%	49%	100%	0%
3	dr. Ratih	304	109	95	14	195	194	1	87%	13%	99%	1%

NO	NAMA DOKTER	Σ DRM ALL	PAM			CPPT			KELENGKAPAN			
			Σ DRM	L	TL	Σ DRM	L	TL	PAM		CPPT	
									%L	%TL	%L	%TL
	Kusumawardani Sp.A, M.Biomed											
4	dr. Rossy Zaki Abdillah Sp.B	327	97	97	0	230	230	0	100%	0%	100%	0%
5	dr Badariyatud Dini Sp.BP-RE	20	11	11	0	9	9	0	100%	0%	100%	0%
6	dr Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS	26	9	9	0	17	17	0	100%	0%	100%	0%
7	dr Maria Valentina Evelyn Sp. JP	563	26	26	0	537	537	0	100%	0%	100%	0%
8	dr Yekti Mumpuni Sp.KJ.	55	2	2	0	53	53	0	100%	0%	100%	0%
9	dr. Andika Widiанти Sp.K.J	215	15	15	0	200	199	1	100%	0%	100%	1%
10	dr. Rudi Priyo Utomo Sp.OG	401	106	104	2	295	295	0	98%	2%	100%	0%
11	dr. Santoso Rahardjo Sp.OG.	299	92	91	1	207	207	0	99%	1%	100%	0%
12	dr. Citra Dwi Harningtyas Sp.DV., M.Ked.Klin	152	28	21	7	124	124	0	75%	25%	100%	0%
13	dr. Nyoman Indra Bayu Sp.M	149	29	29	0	120	120	0	100%	0%	100%	0%
14	dr Nurhadhi Sutanto Sp. M	342	48	48	0	294	294	0	100%	0%	100%	0%
15	dr Arianto Prabowo Sp. OT	43	9	9	0	34	34	0	100%	0%	100%	0%
16	dr. I Gede Made Oka Rahaditya Sp. OT	188	38	38	0	150	150	0	100%	0%	100%	0%
17	dr. Fiski Purantoro Sp.OT	210	53	53	0	157	156	1	100%	0%	99%	1%
18	dr. Fitri Indahyanti Sp.P., MMRS	185	66	66	0	119	118	1	100%	0%	99%	1%
19	dr. Novita Maulidiyah Sp.P	217	50	49	1	167	167	0	98%	2%	100%	0%
20	dr Cameleia Diah Setyorini Sp.PD	399	40	40	0	359	359	0	100%	0%	100%	0%
21	dr. Heriyatmo Sp. PD	656	48	48	0	608	608	0	100%	0%	100%	0%
22	dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD	585	92	92	0	493	492	1	100%	0%	100%	0%
23	dr. Aan Dwi Prasetio Sp.N	290	33	33	0	257	257	0	100%	0%	100%	0%
24	dr. Ahmad Farid Wajdi Sp.N.	846	102	102	0	744	743	1	100%	0%	100%	0%
25	dr. Fuad Fauzi Sp.T.H.T.K.L.	66	25	22	3	41	41	0	88%	12%	100%	0%
26	dr Ferdyan Rachmat Efendi Sp.U	321	85	84	1	236	236	0	99%	1%	100%	0%
27	dr. Zaki Yamani, Sp. B	131	43	42	1	88	88	0	98%	2%	100%	0%
28	dr. Aditya Purwaka Sp.PD	204	59	59	0	145	145	0	100%	0%	100%	0%
29	dr. Erinda Rahma Mulia Sp. FKR	360	55	55	0	305	302	3	100%	0%	99%	1%
30	dr. Eko Nugroho	528	33	33	0	495	494	1	100%	0%	100%	0%

NO	NAMA DOKTER	Σ DRM ALL	PAM			CPPT			KELENGKAPAN			
			Σ DRM	L	TL	Σ DRM	L	TL	PAM		CPPT	
									%L	%TL	%L	%TL
	Sp. FKR											
31	dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	377	25	25	0	352	352	0	100%	0%	100%	0%
32	dr. Ardityo Rahmat Ardhanay Sp.PD-KGH	115	18	18	0	97	97	0	100%	0%	100%	0%
33	dr. Latifah Sp.M	235	67	67	0	168	168	0	100%	0%	100%	0%
34	dr. Rachmawati Wardani Sp. N.	65	21	21	0	44	44	0	100%	0%	100%	0%
35	dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	120	55	55	0	65	64	1	100%	0%	98%	2%
36	dr. Agung Wijaya Kusuma, Sp.OG	85	33	33	0	52	52	0	100%	0%	100%	0%
37	dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	116	39	38	1	77	77	0	97%	3%	100%	0%
38	dr. Julian Hartawan Wijaya Sp. T.H.T.B.K.L	217	91	89	2	126	126	0	98%	2%	100%	0%
39	dr. Dion Setiawan, Sp.JP	144	25	21	4	119	119	0	84%	16%	100%	0%
40	dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE	112	41	38	3	71	69	2	93%	7%	97%	3%
41	dr. Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A	62	37	28	9	25	24	1	76%	24%	96%	4%
TOTAL		10310	2004	1899	105	8306	8292	14	94.8%	5.5%	99.8%	0.2%

A. Analisa
 Berdasarkan Tabel 3.10 diatas menunjukkan adanya pengisian ERM yang belum lengkap di pengkajian medis DPJP bagian tanda tangan pasien, tolak ukur dan tanda tangan dokter. Angka ketidaklengkapan pada bulan ini terbanyak adalah dr. Esti Purwaningrum Sp.A. yaitu sebanyak 49%.

B. Masalah

Problem	klengkapan pengisian ERM rawat jalan di pengkajian medis DPJP bagian tanda tangan pasien, tolak ukur dan tanda tangan dokter.
Step	Perbaiki kualitas pengisian rekam medis elektronik (ERM)
Plan	1. Rencana: Perbaiki kualitas pengisian rekam medis elektronik 2. Harapan Kelengkapan pengisian ERM 100 % 3. Tindakan a. Lakukan audit harian ERM acak untuk DPJP b. Sosialisasi kembali standart pengisian ERM c. Koordinasi dengan IT PT agar pengisian yang tidak lengkap tidak dapat menuju pengisian step berikutnya
Do	1. Kirim daftar temuan tidak lengkap kepada DPJP setiap minggu 2. Koordinasi dengan perawat untuk bantu memastikan tanda tangan pasien terisi sebelum pasien meninggalkan ruang rawat
Study	1. Bandingkan data kelengkapan ERM minggu ke 0 dan minggu ke 2 2. Evaluasi feed back dari dokter terkait kendala sistem atau teknis
Action	1. Terapkan reminder dan pelaporan rutin ke semua dokter 2. Adakan pelatihan ulang pengiisan ERM 3. Masukkan ke dalam evaluasi kinerja terkait ketidak lengkapan ERM irja

C. Rencana Tindak Lanjut

Tabel Rencana Tindak Lanjut

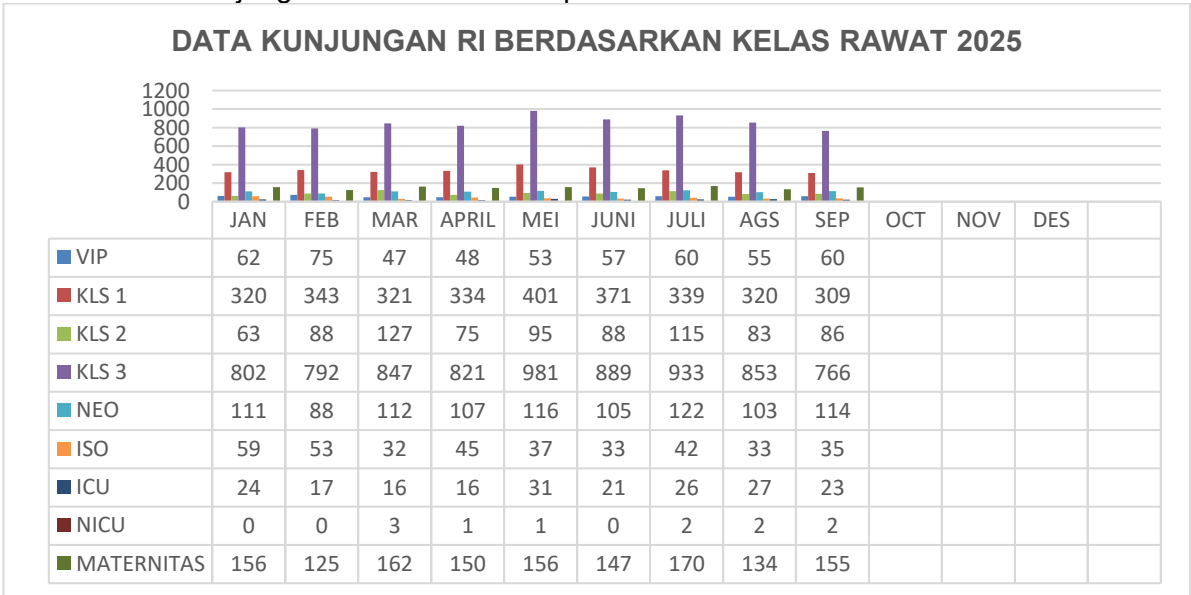
Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
Meningkatkan kelengkapan ERM dr. Esti Purwaningrum Sp.A.	Meningkatkan kelengkapan pengisian ERM menjadi ≥90% dalam waktu 1 bulan	Seluruh dokter spesialis	1. Terapkan reminder dan pelaporan rutin ke semua dokter 2. Adakan pelatihan ulang pengisian ERM 3. Masukkan ke dalam evaluasi kinerja terkait ketidak lengkapan ERM irja	1. Dokter spesialis 2. RM	1 Bulan

3.3.2 Rawat Inap

A. Tabel Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar 2025

No	Kelas Perawatan	Jumlah Pasien								
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	JR	PT	BPJS Iktut Ibu	Total	%
1	VIP	14	19	0	13	0	14	0	60	3,87%
2	Kelas 1	2	297	0	6	4	0	0	309	19,94%
3	Kelas 2	8	44	28	3	2	1	0	86	5,55%
4	Kelas 3	18	737	0	0	11	0	0	766	49,42%
5	ICU	1	22	0	0	0	0	0	23	1,48%
6	Maternitas	2	152	0	1	0	0	0	155	10,00%
7	Neonatologi	1	21	0	0	0	0	92	114	7,35%
8	NICU	1	1	0	0	0	0	0	2	0,13%
9	Isolasi	1	34	0	0	0	0	0	35	2,26%
TOTAL		48	1327	28	23	17	15	92	1550	100%

Grafik Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Kelas Rawat 2025



- A. Analisa
- Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah pasien di bulan September. Penurunan terjadi pada seluruh kunjungan pasien rawat inap berdasarkan kelas rawat.
- B. Masalah
- | | |
|---------|---|
| Problem | Penurunan jumlah pasien seluruh ruang kelas rawat inap |
| Step | Meningkatkan jumlah pasien rawat inap berdasarkan kelas |

	rawat
Plan	1. Rencana: Meningkatkan jumlah pasien rawat inap 2. Harapan Meningkatkan jumlah pasien rawat inap > 20 % dalam 1 – 2 bulan kedepan 3. Tindakan - Perbaiki fasilitas dasar ruangan rawat inap yang rusak - Buat materi promosi layanan rawat inap yang dimiliki dan kirim ke mitra faskes - Tingkatkan kecepatan layanan admisi dan respon dokter jaga
Do	1. Luncurkan promosi layanan melalui media social atau WA 2. Kunjungan marketing tiap minggu atau kontak faskes
Study	1. Bandingkan data sebelum bulan Juli dan bulan Agustus, cek kunjungan yang masuk dari mitra 2. Evaluasi kunjungan pasien rawat inap
Action	1. Evaluasi berkala kepuasan pasien isolasi 2. Buat program kunjungan mitra dan promosi layanan 3. Evaluasi layanan dokter dan kecepatan respon

C. Rencana Tindak Lanjut
Tabel Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
Penurunan pasien rawat inap	Meningkatkan jumlah pasien rawat inap > 20 % dalam 1 – 2 bulan	Humas dan marketing Dokter spesialis Perawat Mitra rumah sakit	1. Evaluasi berkala kepuasan pasien rawat inap 2. Buat program kunjungan mitra dan promosi layanan 3. Evaluasi layanan dokter dan kecepatan respon	1. Humas dan marketing 2. Dokter spesialis 3. Perawat	1 – 2 Bulan

Data Pasien APS
Tabel Pasien APS

No	UNIT	BULAN JANUARI-DESEMBER											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	IGD	3	4	5	6	6	16	5	10	13			
2	IRNA 2A	5	5	3	7	4	5	7	4	4			
3	IRNA 2B	7	0	2	2	2	0	2	4	3			
4	IRNA 3A	1	2	2	2	2	0	0	0	0			
5	IRNA 3B	1	0	1	3	1	3	2	0	0			
6	ICU	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
7	NICU	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	MATERNITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Tabel Jumlah Kunjungan IRNA Bulan September Tahun 2025

NAMA SMF	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	%
Anak			436	390	484	416	387	366	383				↑ 0.04%
Bedah Umum			172	175	240	228	247	200	181				↓ 0.10%
Bedah Plastik			26	11	21	13	25	13	18				↑ 0,27%

Bedah Syaraf			25	20	24	25	23	24	12				↓ 1%
Jantung			45	50	64	38	57	54	38				↓ 0.42%
Jiwa			3	1	0	0	0	0	0				0,00%
Kandungan			162	151	156	147	171	135	156				↑ 0.13%
Kulit Dan Kelamin			2	2	3	1	4	2	3				↑ 0.3%
Mata			16	6	25	19	31	31	20				↓ 0.55%
Orthopedi			84	67	72	67	93	84	77				↓ 0.09%
Paru			112	111	79	98	106	88	89				↑ 0.01%
Penyakit Dalam			373	385	451	422	398	350	318				↓ 0.1%
Syaraf			144	141	152	146	150	145	143				↓ 0.01%
Urologi			60	71	17	75	97	95	87				↓ 0.09%
THT			13	16	83	16	20	23	25				↑ 0.08%
TOTAL			1673	1597	1871	1711	1809	1.610	1.550				↓ 0.03%

Jumlah Kunjungan IRNA Berdasarkan DPJP Bulan Setember Tahun 2025

No	SMF	Nama DPJP	September	Persentase
1	Anak	dr. Ratih Kusumawardani Sp.A, M.Biomed	135	
2		dr. Muhammad Irawan, Sp. A	131	
3		dr. Esti Purwaningrum, Sp. A	76	
4		dr. Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A	41	
5	IPD	dr. Cameliea Diah Setyorini, Sp. PD	58	
6		dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD	56	
7		dr. Heriyatmo Sp. PD	53	
8		dr. Aditya Purwaka Sp.PD	51	
9		dr. Adhya Aji Pratama Sp.PD	51	
10		dr. Ardityo Rahmat Ardhany Sp.PD-KGH	49	
11	Syaraf	dr. Ahmad Farid Wajidi, Sp. N	75	
12		dr. Aan Dwi Prasetyo Sp.N	39	
13		dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	17	
14		dr. Rachmawati Wardani Sp.N	12	
15	Obgyn	dr. Rudi Priyo Utomo Sp.OG	84	
16		dr. Santoso Rahardjo, Sp. OG	43	
17		dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG	29	
18	Bedum	dr. Rossy Zaki Abdillah Sp.B	99	
19		dr. Zaki Yamani Sp.B	41	
20		dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	41	
21	Paru	dr. Fitri Indahyanti Sp.P., MMRS	48	
22		dr. Novita Maulidiyah, Sp. P	41	
23	Orthopedi dan Traumatologi	dr. Fiski Purantoro Sp.OT	36	
24		dr. I Gede Oka Rahaditya, Sp. OT	35	
25	Jantung Pembuluh Darah	dr. Arianto Prabowo Sp. OT	6	
26		dr. Dion Setiawan Sp.JP	23	
27		dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	15	
28	Urologi	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp. U	87	
29	Bedah Plastik	dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE	18	
30	Bedah Syaraf	dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS	12	
31	THT	dr. Julian Hartawan Wijaya Sp.T.H.T.B.K.L	16	
32		dr. Fuad Fauzi Sp.T.H.T.K.L.	9	
33	Mata	dr. Latifah Sp.M	17	
34		dr. Nyoman Indra Bayu Sp.M	2	
35		dr. Nurhadhi Sutanto Sp. M	1	
36	DVE	dr. Riski Bagus Suhendra Sp.DVE	2	
37		dr. Citra Dwi Harningtyas Sp.DV., M.Ked.Klin	1	

Analisis :

- a. Kunjungan IRNA terbanyak di Bulan September 2025 adalah Anak sejumlah 383 pasien dengan DPJP terbanyak yaitu dr. Ratih Kusumawardani Sp.A, M.Biomed dengan jumlah 135 pasien.
- b. Kunjungan IRNA secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 0.03%
- c. Kunjungan IRNA dengan kenaikan tertinggi adalah spesialis Mata sebesar 0.55%

Data Pasien Rawat Inap Rujuk
Tabel Data Pasien Rawat Inap Rujuk Bulan September 2025

No	Indikator RS	Bulan JANUARI-DESEMBER											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	IGD	29	16	34	29	29	15	20	33	43			
2	IRNA 2A	12	6	5	6	9	19	11	6	4			
3	IRNA 2B	20	10	19	7	5	7	7	10	9			
4	IRNA 3A	3	4	2	2	3	2	3	3	6			
5	IRNA 3B	6	10	5	7	4	10	8	3	7			
6	ICU	5	6	3	5	7	6	5	4	7			
7	NICU	2	3	4	0	7	1	5	3	5			
8	MATERNITAS	1	1	1	0	0	1	1	0	0			

Pasien Meninggal di Rawat Inap
Tabel Pasien Meninggal di Rawat Inap Bulan September 2025

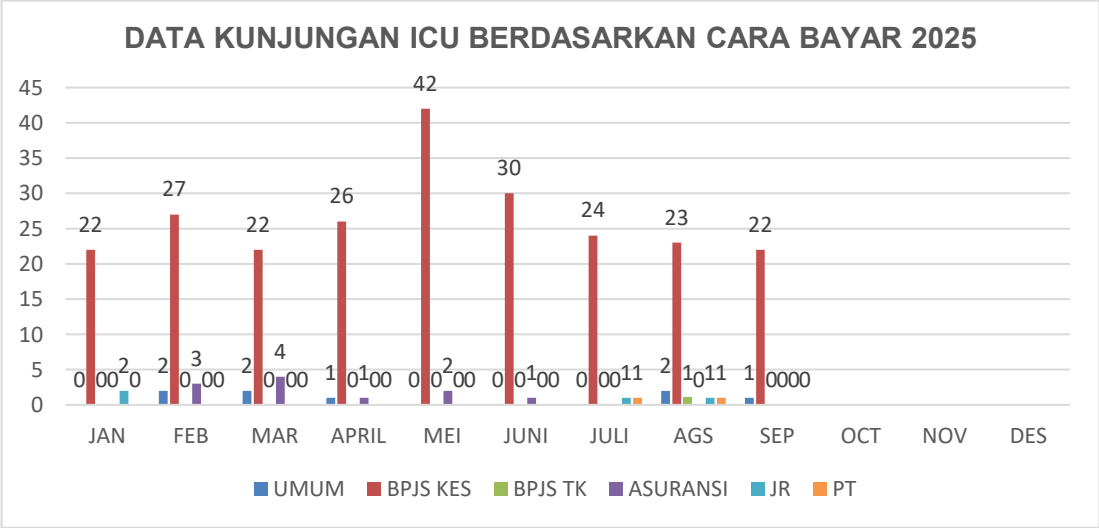
No	Indikator RS	Bulan JANUARI-DESEMBER											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	IGD	13	17	16	20	20	24	23	11	19			
2	IRNA 2A	16	6	9	16	9	7	9	12	6			
3	IRNA 2B	10	6	14	20	12	8	8	10	9			
4	IRNA 3A	1	0	2	1	0	2	2	1	2			
5	IRNA 3B	1	0	9	4	7	8	5	1	1			
6	ICU	20	11	13	11	23	15	21	22	16			
7	NICU	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	MATERNITAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0			

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

A. Tabel Kunjungan Pasien ICU Berdasarkan Cara Bayar 2025

No	Cara Bayar	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	%
1	Umum	4	0	2	2	1	0	0	0	2	1				↓ 1%
2	BPJS Kes	20	22	27	22	26	42	30	24	23	22				↓ 1%
3	BPJS TK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0				↓ 1%
4	Asuransi Swasta	1	0	3	4	1	2	1	0	0	0				0
5	JR	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0				↓ 1%
6	Perusahaan	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0				↓ 1%
TOTAL		28	24	32	28	28	45	31	26	27	23				↓ 0.17%

B. Grafik Kunjungan Pasien ICU Berdasarkan Cara Bayar 2025



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan pasien pada bulan September 2025 sebanyak 0.17% jika dibandingkan dengan pasien di bulan Agustus 2025.

Masalah :

Problem	Penurunan jumlah pasien ICU sebanyak 0.17%
Step	Meningkatkan jumlah pasien ICU
Plan	1. Rencana: Meningkatkan jumlah pasien ICU 2. Harapan Jumlah kunjungan pasien ICU meningkat 3. Tindakan a. Meningkatkan deteksi dini kondidi memburuh melalui EWS b. Melakukan pelatihan staf medis untuk menangani kondisi kritis di ruang perawatn reguler c. Berkoordinasi dengan Ka Ins ICU terkait kriteria keluar masuk ICU terutama pro intubasi
Do	1. Pelatihan tenaga medis tentang penanganan awal kegawatan dan EWS 2. Implementasi EWS disetiap ruangan
Study	1. Waktu respon terhadap kondisi memburuk lebih cepat 2. Tidak ada peningkatan angka mortalitas, menunjukkan pasien tetap tertangani dengan baik meskipun tidak masuk ICU
Action	1. Standarisasi implementasi EWS ke seluruh unit 2. Lanjutkan pelatihan refreshment untuk staf lama 3. Evaluyasi berkala setiap 3 bulan terhadap jumlah pasien ICU dan outcome klinis

Rencana Tindak Lanjut :

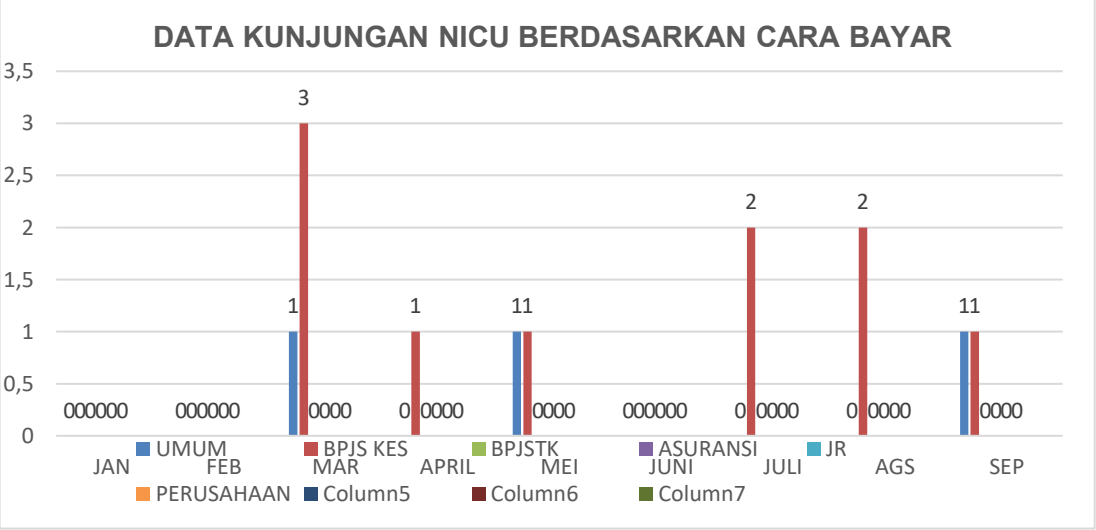
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Penurunan jumlah pasien ICU sebanyak 0.17%	Meningkatkan jumlah pasien ICU > 20 % dalam 1 – 2 bulan	SDM Dokter spesialis Perawat	1. Standarisasi implementasi EWS ke seluruh unit 2. Lanjutkan pelatihan refreshment untuk staf lama 3. Evaluasi berkala setiap 3 bulan terhadap jumlah apsiien ICU dan outcome klinis	1. SDM 2. Dokter spesialis 3. Perawat	1 – 2 Bulan

3.3.4 NICU

A. Tabel Kunjungan Pasien NICU Berdasarkan Cara Bayar 2025

N o	Cara Bayar	Tar get	Ja n	Fe b	Ma r	Apri l	Me i	Ju n	Jul	Ag s	Sep	Oct	Nov	De s	Jum lah	Prosentase
1	Umum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					↑ 1%
2	BPJS Kes	5	0	0	3	1	1	0	2	2	1					↓ 1%
3	BPJS TK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
4	Asuran si Swasta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
5	JR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
6	Perusa haan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
TOTAL		10	0	0	3	1	1	0	2	2	2					Tetap

B. Grafik Kunjungan Pasien NICU Berdasarkan Cara Bayar 2025



A. Analisa

Berdasarkan hasil rekap kunjungan NICU dibulan September tetap dibandingkan dengan Agustus sebanyak 2.

B. Masalah

Problem	Jumlah pasien pasien NICU tetap dan tidak ada peningkatan
Step	Meningkatkan jumlah pasien NICU
Plan	1. Rencana: Meningkatkan jumlah pasien NICU 2. Harapan Jumlah kunjungan pasien ICU meningkat 3. Tindakan a. Meningkatkan kualitas ANC b. Edukasi ibu hamil risiko tinggi dan intervensi sejak trimester ke dua c. Pelatihanresusitasi neonatal untuk bidan dan tenaga di ruang bersalin
Do	1. Implementasi pelatihan resusitasi neonatal bagi petugas neonatologi 2. Penyuluhan ibu hamil dengan risiko di rumah sakit 3. Peningkatan kolaborasi dokter anak, obgin dan perawat neonatal
Study	Jumlah pasien tetap dibanding dengan bulan sebelumnya
Action	1. Koordinasi system rujukan agar lebih cepat dan tepat 2. Pelatihan resusitasi neonatal untuk bidan dan tenaga neonatal 3. Edukasi ibu hamil resiko tinggi di poliklinik

C. Rencana Tindak Lanjut

Tabel Rencana Tindak Lanjut

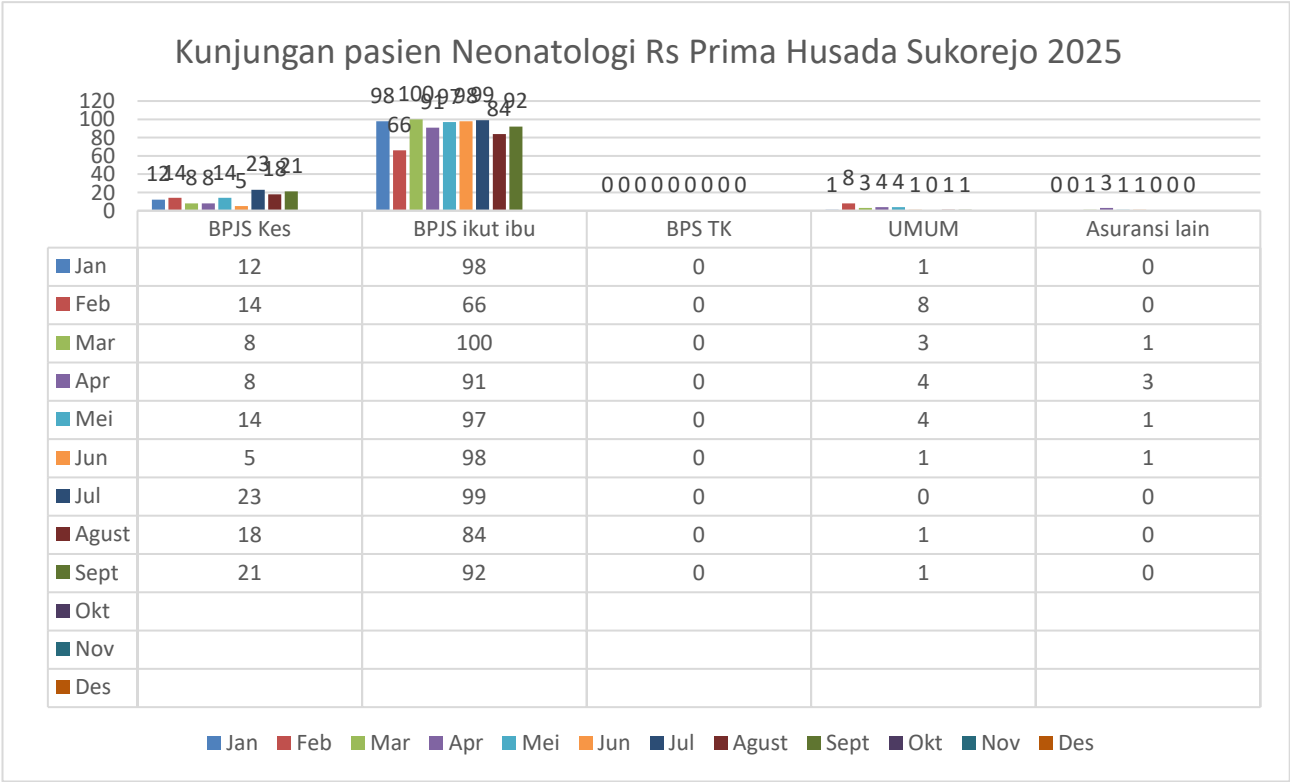
	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
	Jumlah pasien tetap	Meningkatkan jumlah pasien NICU > 20 % dalam 1 – 2 bulan	SDM Dokter spesialis Perawat Bidan Ibu hamil trimester 2	1. Koordinasi system rujukan agar lebih cepat dan tepat 2. Pelatihan resusitasi neonatal untuk bidan dan tenaga neonatal 3. Edukasi ibu hamil resiko tinggi di poliklinik	1. SDM 2. Dokter spesialis anak dan obgin 3. Bidan 4. Perawat 5. Ibu hamil trimester 2	1 – 2 Bulan

3.3.5 Neonatologi

Tabel Kunjungan Pasien Neoatologi Berdasarkan Cara Bayar 2025

Cara BAYAR	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Prese
BPJS Kes	80	12	14	8	8	14	5	23	18	21				↑ 0.14%
BPJS ikut Ibu	80	98	66	100	91	97	98	99	84	92				↑ 0.08%
JKK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Tetap
Umum	10	1	8	3	4	4	1	0	1	1				Tetap
Asuransi Lain	10	0	0	1	3	1	1	0	0	0				Tetap
Total	100	111	88	112	107	116	105	122	103	114				↑ 0.09%

Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar di Unit Neonatologi RSPH bulan September 2025



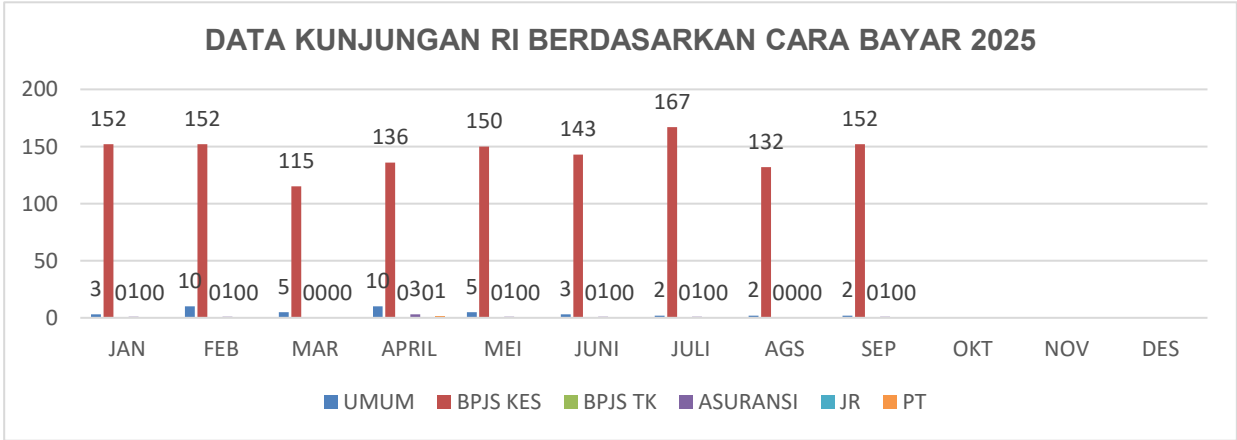
- A. **Analisa**
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa rerkap kunjungan neonatologi dibulan September Terjadi kenaikan sebanyak 11 pasien.

3.3.6 Maternitas

A. Tabel Kunjungan Pasien Maternitas Berdasarkan Cara Bayar 2025

No	Cara Bayar	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Prosentase
1	Umum	4	3	10	5	10	5	3	2	2	2				Tetap
2	BPJS Kes	150	152	115	155	136	150	143	167	132	152				↑ 0.131%
3	BPJS TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Tetap
4	Asuransi Swasta	5	1	0	2	3	1	1	1	0	1				↑ 1%
5	JR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Tetap
6	Perusahaan	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0				Tetap
TOTAL		167	156	25	162	150	156	47	170	134	155				↑ 0.135%

B. Grafik Kunjungan Pasien Maternitas Berdasarkan Cara Bayar 2025



Analisa

Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pasien di bulan September sebanyak 21 pasien dibandingkan dengan bulan Agustus 2025 dengan jumlah total pasien 134.

Masalah

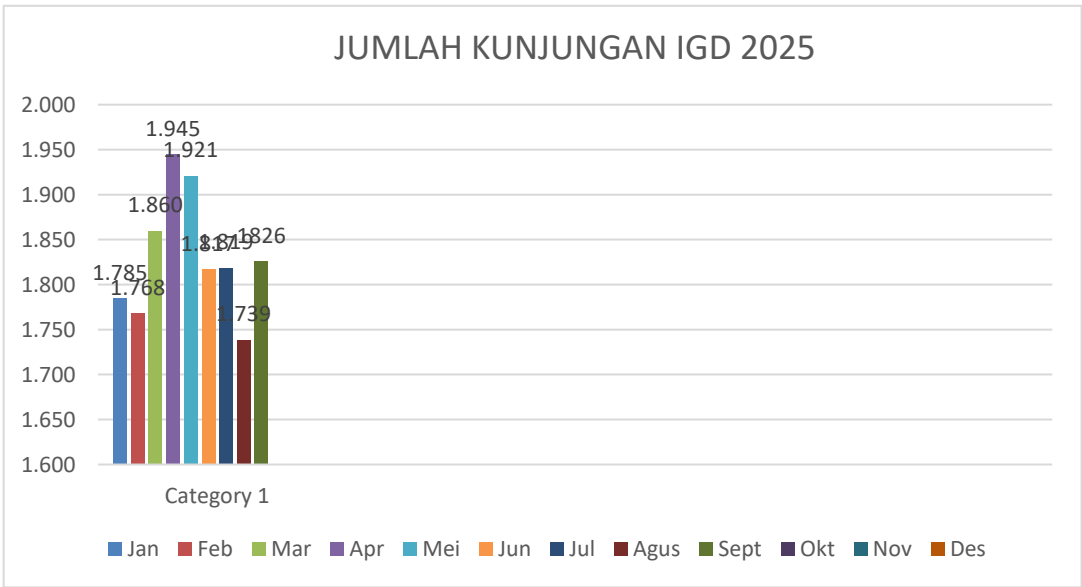
Problem	Kenaikan pasien sebanyak 0,135% yang tidak berdampak signifikan
Step	Meningkatkan jumlah pasien Maternitas
Plan	1. Rencana: Meningkatkan jumlah pasien Maternitas 2. Harapan Jumlah kunjungan pasien Maternitas meningkat > 20 % 3. Tindakan a. Lakukan survey kepuasan pasien dengan wawancara b. Identifikasi factor internal lain misalnya adanya dpjp ijin haji c. Kampanye promosi layanan maternitas di media social dan FKTP
Do	1. Promosi layanan maternitas di media social dan FKTP 2. Minta umpan balik dari pasien baru dan yang kembali 3. Identifikasi factor internal lain missal adanya dpjp ijin haji
Study	Penurunan terjadi 0,36 % dibanding bulan sebelumnya
Action	1. Promosi layanan maternitas melalui media social dan FKTP 2. Menambah DPJP Obgin agar tidak hanya 1 dokter saja 3. Survey kepuasn pasien baru dan lama

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
Kenaikan pasien sebanyak 0,135% yang tidak berdampak signifikan	Meningkatkan jumlah pasien Maternitas > 20 % dalam 1 – 2 bulan	1. Humas dan marketing 2. PKRS	1. Promosilayanan maternitas melalui media social dan FKTP 2. Menambah DPJP Obgin agar tidak hanya 1 dokter saja 3. Survey kepuasn pasien baru dan lama	1. Humas dan marketing 2. PKRS	1 – 2 Bulan

3.3.7 Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Tabel jumlah kunjungan IGD Tahun 2025

Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	%
IGD	1.785	1.768	1.860	1.945	1.921	1.817	1.819	1.739	1826				↑ 0.04%



Jumlah Kunjungan IGD Bulan September
Kunjungan Pasien IGD berdasarkan Cara Rawat Bulan September 2025

No	Bulan	Target	Jumlah	Keterangan					Prosentase
				RJ	RI	APS	Meninggal	Rujuk	
1	Jan	1200	1785	550	1215	3	18	29	↑ 1,41%
2	Feb	1200	1768	170	1598	4	17	16	↓ 1,4
3	Mar	1200	1860	335	1525	5	16	34	↑ 0,05%
4	April	1200	1945	203	1683	7	25	27	↑ 0,04%
5	Mei	1200	1921	339	1404	6	23	29	↓ 7%
6	Juni	1200	1817	342	1379	15	24	15	↓ 5,4%
7	Juli	1200	1819	410	1361	5	23	20	↑ 0,02%
8	Agustus	1200	1739	524	1183	10	11	33	↓ 0.8%
9	September	1200	1826	557	1194	13	19	43	↑ 0.04%
10	October	1200							
11	November	1200							
12	Desember	1200							

A. Analisa

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan kenaikan pasien di bulan September sebanyak 0.04% dibanding dengan bulan Agustus yaitu sebanyak 1739 pasien

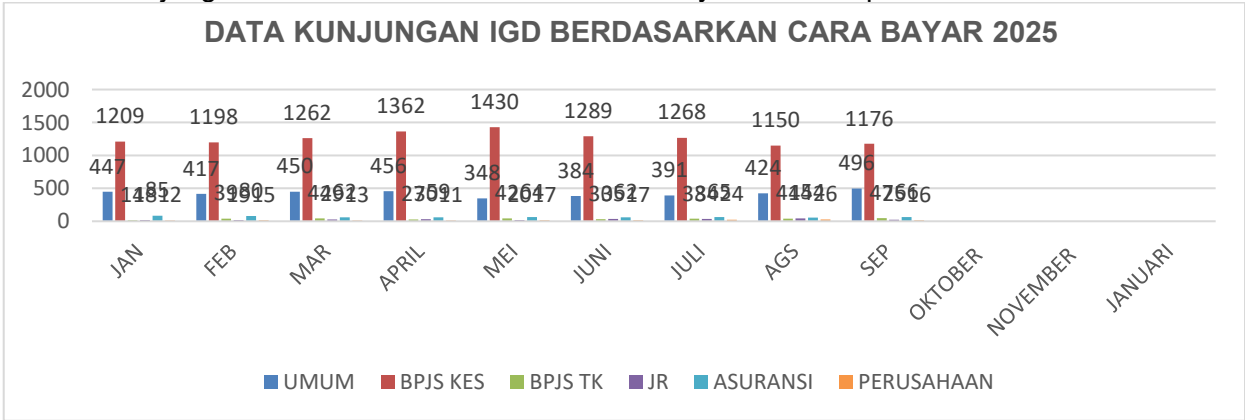
Tabel Jumlah Kunjungan IGD Bulan September Tahun 2025

Nama Dokter	Juni	Juli	Agustus	September	%
dr. Mohammad Helmi Wibisono	306	274	10	0	0
dr. Doddy Adi Nugroho	106	-	-	0	0
dr. Achmad Fauzan Aliani	140	110	177	160	↓ 0.10%
dr. Tania Calista	184	235	194	172	↓ 0.12%
dr. Fina Jazilah Rizkiyah	217	211	223	229	↑ 0.02%
dr. Nejoa Ermaq Fatreciano	197	183	187	203	↑ 0.07%
dr. Wahyu Firmansyah	281	289	306	195	↓ 0.56%
dr. Mohammad Ilyas Febri	196	280	216	235	↑ 0.80%
dr. Moch. Dicky Wahyu Irawan	190	238	207	206	↓ 0.004%
dr. Nurdiana Rahmadani	-	-	178	186	↑ 0.04%
dr. Ahmad Akbar Ridho Mustawa		-	42	240	↑ 0.82%
Total	1.817	1.819	1.739	1.826	↑ 0.04%

Tabel Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Cara Bayar Bulan September 2025

Cara Bayar	Targe t	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu s	Sept	Ok t	No v	De s	%
Umum	1200	447	417	450	456	348	351	391	424	496				↑ 0.14%
BPJS Kes	1200	1209	1198	1262	1362	1430	1355	1268	1.150	1176				↑ 0.02%
BPJS TK	1200	14	39	44	27	42	23	38	41	47				↑ 0.12%
JR	1200	18	19	29	30	20	14	34	44	25				↓ 0.76%
Asuransi	1200	85	80	62	59	64	62	65	54	66				↑ 0.18%
Perusahaa n	1200	12	15	13	11	17	12	24	26	16				↓ 0.62%
Total	1200	1.785	1.768	1.860	1945	1.921	1.817	1.819	1.739	1.826				↑ 0.04%

Grafik Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Cara Bayar Bulan September 2025



A. Analisa

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan pada bulan September mengalami kenaikan pasien sejumlah 1.826 dibandingkan dengan bulan Agustus 2025 sebanyak 1.739

B. Permasalahan Unit

Tabel Permasalahan IGD September 2025

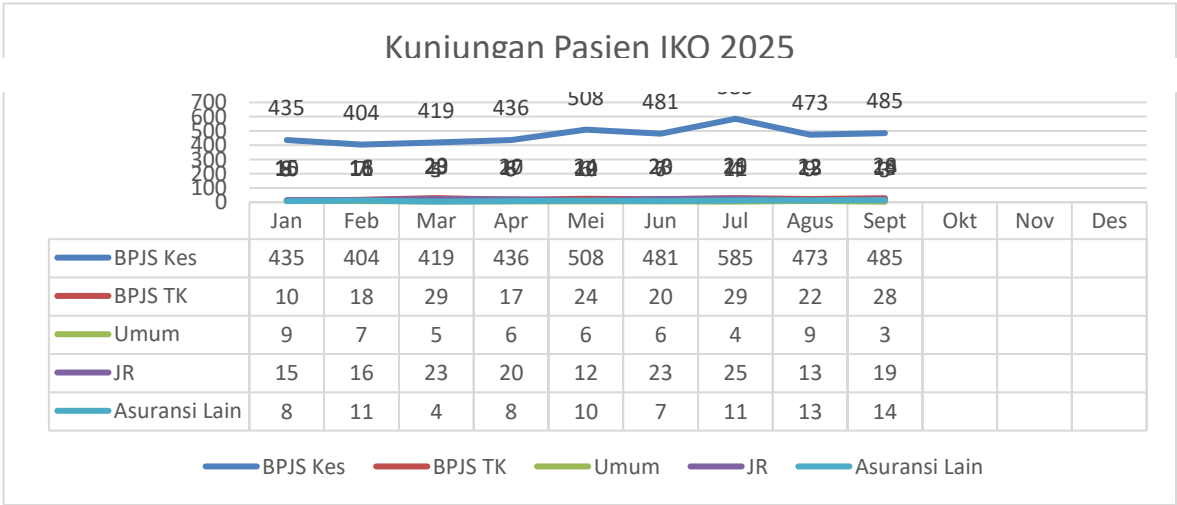
IGD	
Problem	Ketidaklengkapan pengisian anamnesa dokter IGD dan perawat IGD sesuai kondisi pasien secara terperinci
Step	Meningkatkan kepatuhan staf IGD dalam melakukan anamnesa sesuai kondisi pasien terperinci dan terdokumentasi dalam ERM
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan staf IGD dalam melakukan anamnesa di IGD 2. Harapan Tidak ada anamnesa yang tidak terdokumentasi di dalam ERM yang sesuai dengan kondisi pasien saat masuk sampai dengan keluar dari IGD 3. Tindakan a. Lakukan sosialisasi terhadap dokter IGD b. Terapkan checklist kelengkapan pengisian dan kesinkronan keluhan pasien dengan kondisi c. Lakukan pengecekan saat pasien di transfer di rawat inap
Do	Terapkan checklist yang dibuat
Study	Ada perubahan anamnesa di IGD saat pasien sudah di rawat inap oleh DPJP
Action	1. Review checklist yang dibuat 2. Meningkatkan kepatuhan dokter dan perawat IGD dalam melakukan kelengkapan anamnesa sesuai kondisi secara terperinci dan terdokumentasi

3.3.8 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

A. Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Cara Bayar 2025

Bulan	Target	Jumlah	Keterangan					Prosentase
			BPJS Kes	BPJS TK	Umum	JR	Asuransi Lain	
Jan	400	477	435	10	9	15	8	0,62%
Feb	400	456	404	18	7	16	11	0,14%
Mar	400	480	419	29	5	23	4	1,2%
April	400	487	436	17	6	20	8	14%
Mei	400	558	508	24	6	12	10	1,6
Juni	400	537	481	20	6	23	7	↓3,7
Juli	400	654	585	29	4	25	11	↑1,17%
Agustus	400	537	473	22	9	13	13	↓1,17%
September	400	548	485	28	3	19	14	↑0,02%
October	400							

B. Grafik Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Cara Bayar Bulan September 2025



Tabel Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Klasifikasi Pembedahan Bulan September 2025

Bulan	Target	Jumlah	Keterangan						Prosentase
			Khusus	Besar	Sedang	Kecil	ESWL	Phaco	
Jan	400	477	8	328	86	9	9	30	↓0,06 %
Feb	400	456	23	312	65	15	11	30	↓0,21%
Mar	400	480	19	321	92	8	10	30	↑1,2 %
April	400	487	13	338	91	3	12	30	↑1,2 %
Mei	400	558	14	397	91	11	15	30	↑0,71%
Juni	400	539	11	398	77	10	13	30	↓3,7%
Juli	400	654	12	486	103	12	11	30	↑1.15%
Agustus	400	537	26	370	128	16	9	31	↓1.17%
September	400	548	25	378	90	11	13	31	↑0,02%
October	400								
November	400								
Desember	400								

A. Analisa

Berdasarkan grafik dan tabel didapatkan kenaikan jumlah pasien operasi pada Bulan September jika dibandingkan dengan bulan Agustus. Jumlah pasien operasi pada Bulan Agustus sejumlah 537 pasien dan Bulan September sejumlah 548 pasien. Kenaikan jumlah operasi terjadi 0,02%. kenaikan ini juga merupakan dampak dari pembatasan pasien FKTP dengan BPJS PBI / UHC yang di rujuk ke RS Prima Husada Sukorejo

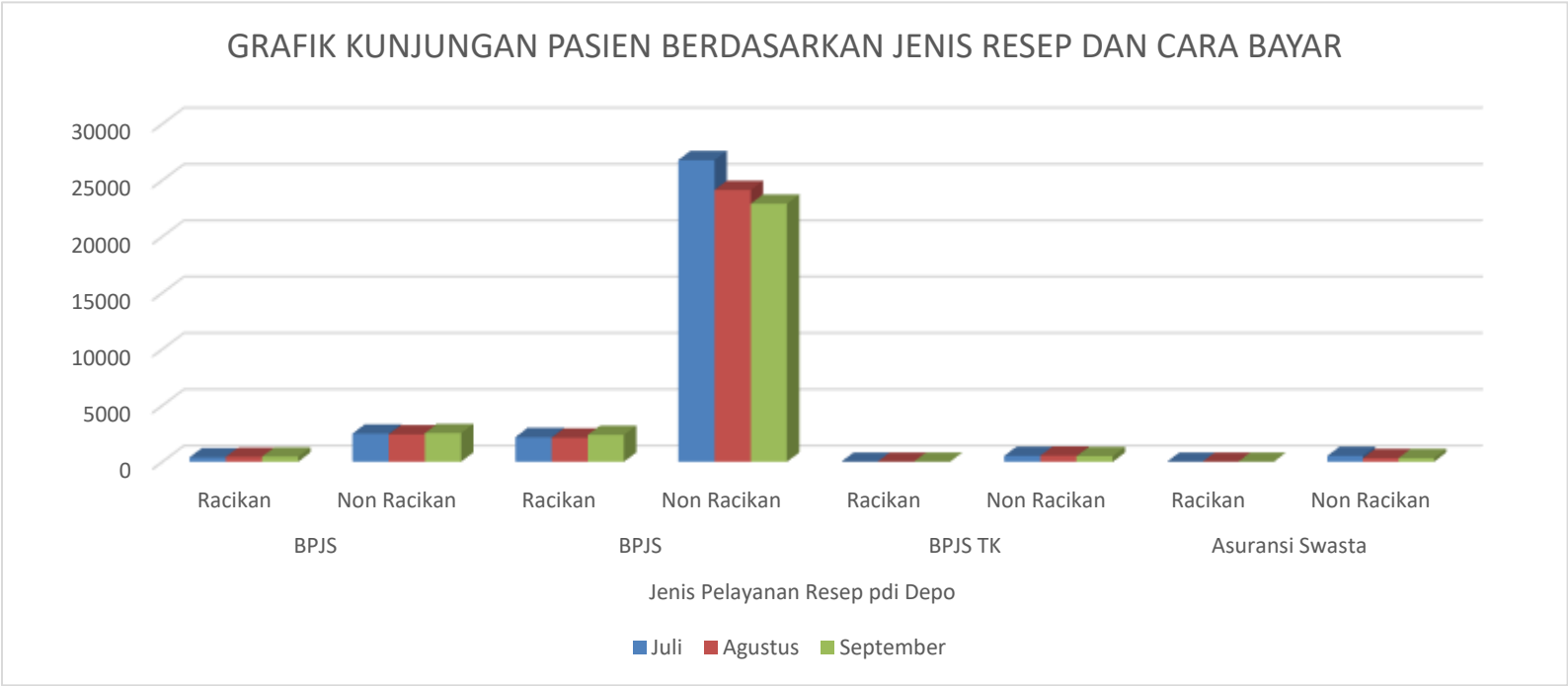
3.4 Kinerja Bidang Penunjang

3.4.1 Instalasi Farmasi

Rekap Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar & Jenis Resep 2025

No	Bulan	Jenis Pelayanan Resep pdi Depo												Total Resep
		Umum			BPJS			BPJS TK			Asuransi Swasta			
		Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah	
1	Juli	401	2501	2902	2189	26793	28982	4	520	524	4	520	524	32932
2	Agustus	438	2446	2884	2145	24135	26280	2	540	542	0	324	324	2585
3	September	455	2549	3004	2398	22915	25313	1	494	495	1	331	332	29144

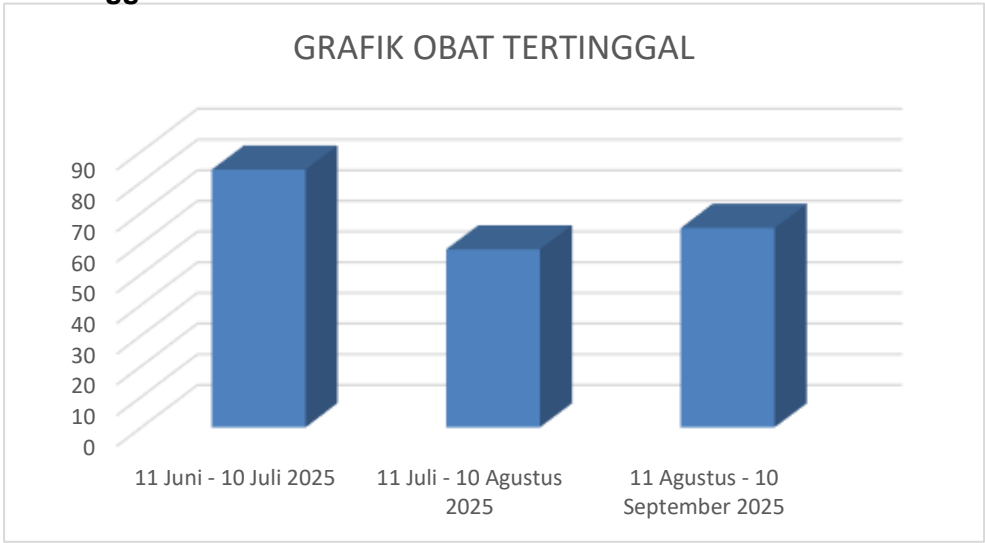
Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Jenis Resep dan Cara Bayar



3.4.2. Rekap Obat tertinggal

No	Periode	Jumlah Resep
1	11 Juni 2025 – 10 Juli 2025	84
2	11 Juli 2025 – 10 Agustus 2025	58
3	11 Agustus 2025 – 10 September 2025	65

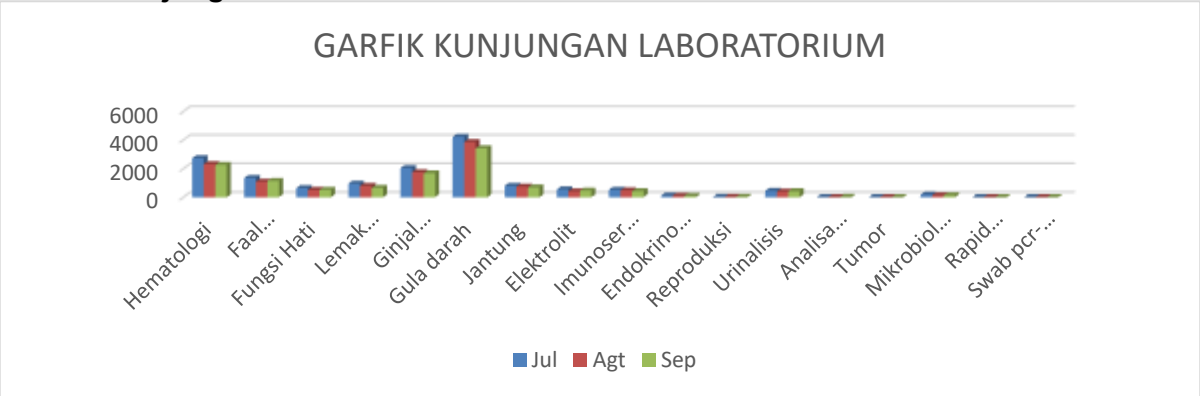
Grafik Obat Tertinggal



1.4.2. LABORATORIUM
Tabel Kunjungan Pasien Laboratorium 2025

No	Jenis Pelayanan	Jul	Agt	Sep	Prosentase Terhadap Bulan Sebelumnya	% thd bulan sebelumnya
1	Hematologi	2725	2308	2258	↓2.16%	97.83362218
2	Faal Hemostasis	1338	1084	1134	↑4.61%	104.6125461
3	Fungsi Hati	629	502	504	↑0.39%	100.3984064
4	Lemak darah	945	788	651	↓17.38%	82.6142132
5	Ginjal Hipertensi	2030	1745	1675	↓4.01%	95.98853868
6	Gula darah	4212	3861	3416	↓11.52%	88.47448847
7	Jantung	788	729	682	↓6.44%	93.55281207
8	Elektrolit	543	407	453	↑11.3%	111.3022113
9	Imunoserologi	512	471	425	↓9.76%	90.23354565
10	Endokrinologi	107	97	79	↓18.55%	81.44329897
11	Reproduksi	23	20	32	↑60%	160
12	Urinalisis	435	383	414	↑8.09%	108.0939948
13	Analisa Feses	10	6	16	↑166%	266.6666667
14	Tumor	3	2	1	↓50%	50
15	Mikrobiologi	175	126	124	↓1.58%	98.41269841
16	Rapid Cvd-19	0	0	0		#DIV/0!
17	Swab pcr-19	0	0	0		#DIV/0!
18	Jumlah	14475	12529	11864	↓5.3%	94.69231383

Grafik Kunjungan Pasien Laboratorium 2025



Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
Kunjungan Laboratorium di bulan September mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya	Plan : - Meningkatkan koordinasi dengan poli rawat jalan dan rawat inap untuk memastikan pemeriksaan rutin tetap berjalan. - Kolaborasi dengan Humas Marketing terkait MCU yang berhubungan dengan pemeriksaan lab. - Review tarif paket MCU terkait pemeriksaan laboratorium Do : - Kolaborasi dengan Humas Marketing terkait MCU yang berhubungan dengan pemeriksaan lab. - Review tarif paket MCU terkait pemeriksaan laboratorium Study : - Jenis pemeriksaan yang meningkat signifikan: - Endokrinologi nail 18,55% - Urinalisis naik 8,09%

	➤ Analisa feses naik 20,67% ➤ Tumor marker naik 150% (meski jumlah absolut kecil) • Jenis pemeriksaan yang menurun: Sebagian besar pemeriksaan rutin dengan volume tinggi, misalnya hematologi, faal hemostasis, lemak darah, gula darah. Action: • Memastikan stok reagen dan kesiapan alat • Melakukan koordinasi dengan unit rawat jalan/ rawat inap agar pemeriksaan laboratorium tercatat dan tidak ada yang tertunda. • Mengembangkan paket pemeriksaan untuk menarik lebih banyak pasien.
--	---

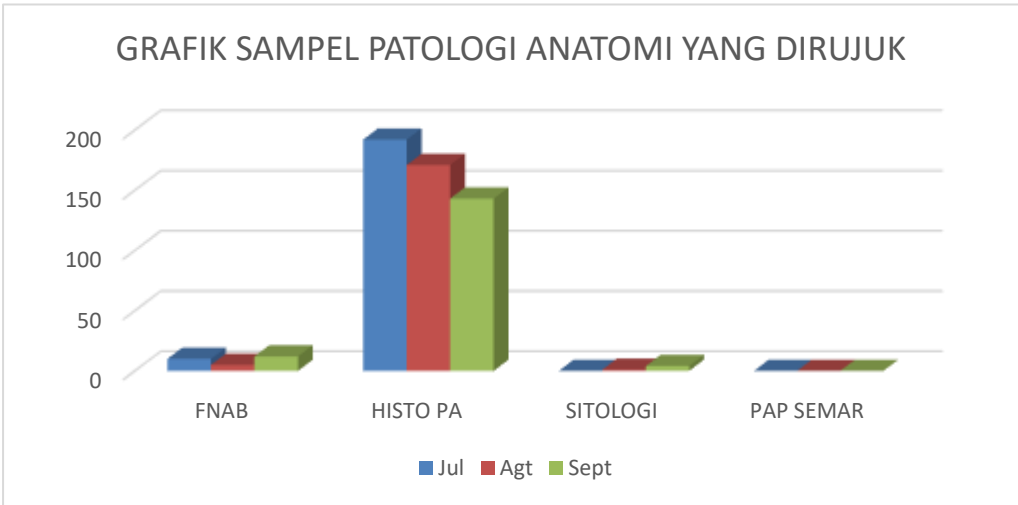
a. Rujukan Patologi Anatomi

1) Jenis Sampel Patologi Anatomi

Tabel 3.4.2.2 Data Jenis Sampel Patologi Anatomi yang Dirujuk

No	Jenis Pemeriksaan	Jul	Agt	Sept
1	FNAB	10	5	12
2	HISTO PA	192	171	143
3	SITOLOGI	0	1	4
4	PAP SEMAR	0	0	0
JUMLAH		202	177	159

Grafik Jenis Sampel Patologi Anataomi yang Dirujuk



Tabel 3.4.2.3 Analisa Data

Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
Jumlah pemeriksaan patologi anatomi dibulan September menurun dibandingkan bulan sebelumnya	Plan : • Mengoptimalkan kembali pengiriman sampel dan koordinasi dengan poliklinik. Do : • Koordinasi dengan kamar bedah dan unit terkait untuk memastikan setiap tindakan bedah/ tindakan FNAB menghasilkan pengiriman sampel ke PA. • Evaluasi Rantau logistic dan administrasi rujukan PA. Study : • Penurunan HISTO PA secara bertahap menunjukkan tren berkelanjutan, bukan

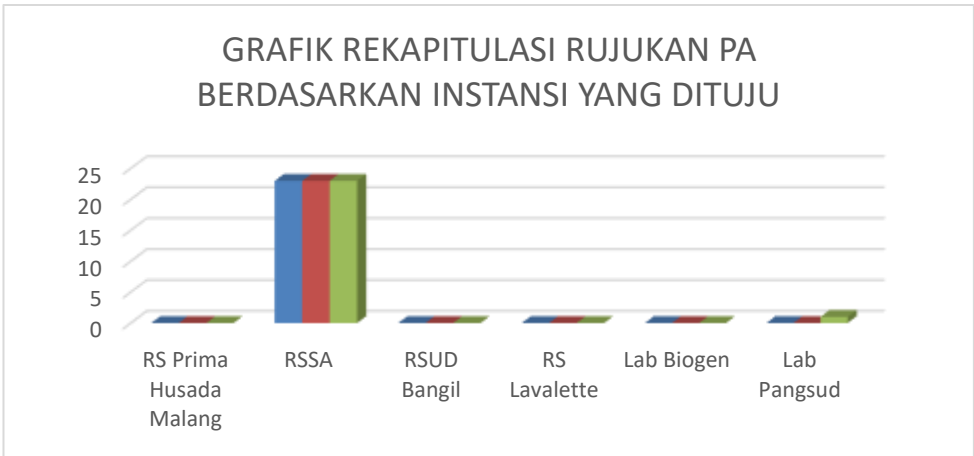
	fluktuasi musiman. • FNAB stabil → menunjukkan pelayanan berjalan konsisten. • Sitologi mulai muncul pada September • Penurunan HISTO PA berkaitan dengan penurunan tindakan bedah elektif, adanya hambatan logistic pengiriman Action: • Kolaborasi dengan Humas Marketing untuk MCU dalam pemasaran pemeriksaan PAP SMEAR yang saat ini masih belum bergerak.
--	---

2) Instansi Rujukan Patologi Anatomi

Tabel 3.4.2.4 Rekapitulasi Rujukan PA Berdasarkan Instansi yang Dituju

No	Nama Rumah Sakit	Juli	Agt	Sept
1	RS Prima Husada Malang	0	0	0
2	RSSA	23	23	23
3	RSUD Bangil	0	0	0
4	RS Lavalette	0	0	0
5	Lab Biogen	0	0	0
6	Lab Pangsud	0	0	1
JUMLAH		23	23	24

Grafik Rekapitulasi Rujukan PA Berdasarkan Instansi yang Dituju



Tabel 3.4.2.5 Analisa Data

Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
Rujukan PA di bulan September mengalami kenaikan	Plan : • Melakukan kerjasama dengan RS lain untuk rujukan PA Do : • Menjalin komunikasi dengan RS lain dan menjalin kerjasama rujukan • Monitoring logistic transportasi sampel agar lebih efisien instansi selain RSSA Study: • RSSA menjadi satu – satunya tujuan dominan. Action:

	• Mempertahankan kerjasama dengan RSSA sebagai tujuan utama • Monitoring rutin distribusi rujukan per bulan
--	--

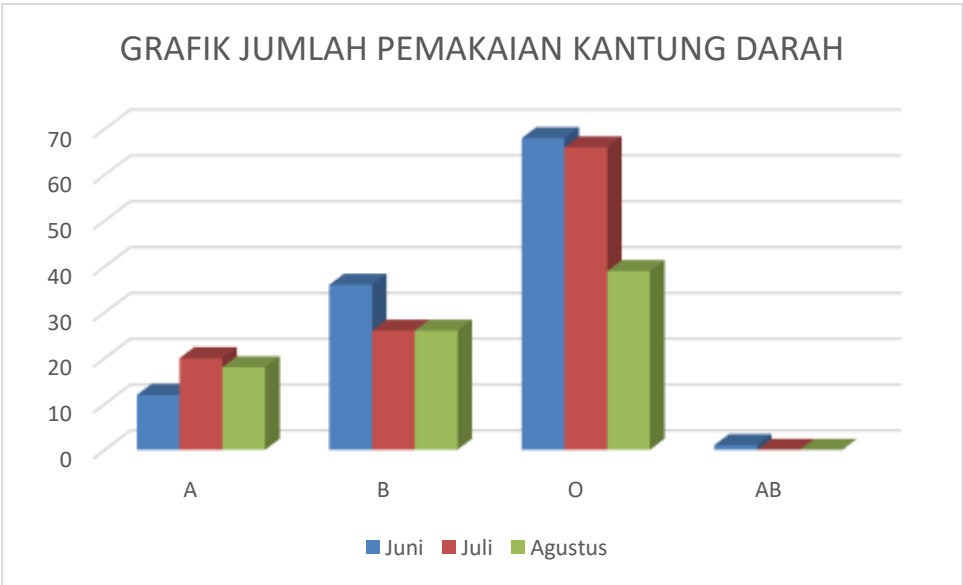
b. Bank Darah

1) Pemakaian Kantong Darah

Tabel 3.4.2.6 Jumlah Pemakaian Kantong Darah

Jenis Golda	Juli	Agt	Sep	Jumlah
A	20	18	25	63
B	26	26	33	85
O	66	39	39	144
AB	0	0	0	0
Jumlah	112	83	97	292

Grafik Jumlah Pemakaian Kantong Darah



Tabel 3.4.2.7 Analisa Data Pemakaian Kantung Darah

Analisa	Reviw Hasil Berdasarkan PDSA
Kebutuhan kantong darah di bulan September meningkat dibandingkan bulan sebelumnya	Plan: • Memastikan ketersediaan stok darah, khususnya golongan O • Menjaga stabilisasi pemakain dengan prediksi kebutuhan yang lebih akurat Do : • Melakukan monitoring harian terhadap pemakaian darah berdasarkan golongan • Membuat perencanaan stok darah • Koordinasi lebih intens dengan PMI atau bank darah lain untuk antisipasi kebutuhan mendadak atau jik ada permintaan golongan darah khusus. Study :

	• Jumlah pemakaian darah meningkat • Golongan O tetap mendominasi • Golongan AB tidak terpakai sama sekali dalam 2 bulan terakhir • Perlu perencanaan stok dinamis sesuai kebutuhannya • Perlu optimalisasi distribusi agar darah golongan AB tidak menumpuk tanpa pemakaian. Action : • Menjaga stok golongan O minimal 50% dari total persediaan • Mengurangi stok golongan AB agar tidak kedaluwarsa • Membuat system prediksi kebutuhan darah berbasis data bulanan untuk menentukan target stok optimal
--	---

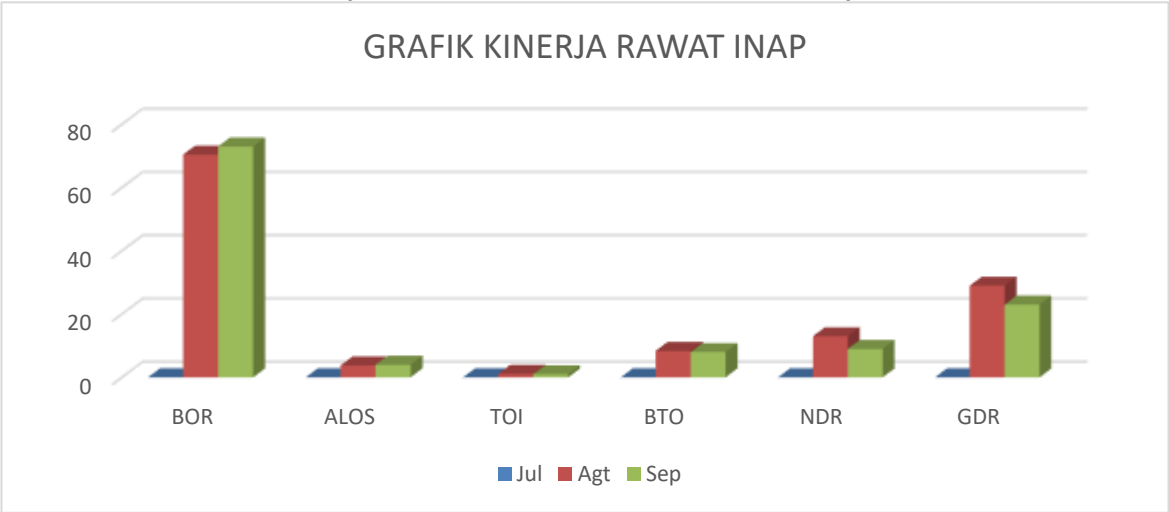
1.4.3. RM – PENDAFTARAN

Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang					Total	Ruang	Total Keseluruhan
						IRNA	MATER	ISOLASI	ICU	NICU		NEONATOLOGI	
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60%	Juli	101	92	25	30	4	84	42	80.17
				- 85%	Agustus	93	66	13	14	3	74	46	70.43
					September	93	84	17	21	4	76	45	72.98
ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	Juli	4	3	4	4	3	3	4	3.68
					Agustus	4	3	4	4	5	4	3	3.74
					September	4	3	4	4	3	4	3	4
TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	Juli	0	0	10	5	48	1	3	0.65
					Agustus	0	1	16	9	80	1	3	1.1
					September	0	0	16	9	58	1	2	1
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	Jumlah pasien. Jumlah TT	40 - 50 kali	Juli	11	15	2	4	1	10	7	9.49

	periode				Agustus	10	12	2	6	0	9	6	8.37
					September	10	14	2	3	1	8	7	8
NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ Mati} > 48 \text{ jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25%	Juli	4	0	0	122	0	13	0	12.77
					Agustus	4	0	0	152	0	14	0	13
					September	3	0	0	143	0	9	0	9
GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45%	Juli	28	0	23	429	200	28	16	27.66
					Agustus	17	0	30	667	0	30	9	28.97
					September	16	0	0	271	0	24	8	23

Grafik Hasil Kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2025



Tabel 3.4.3.2 Analisa Data

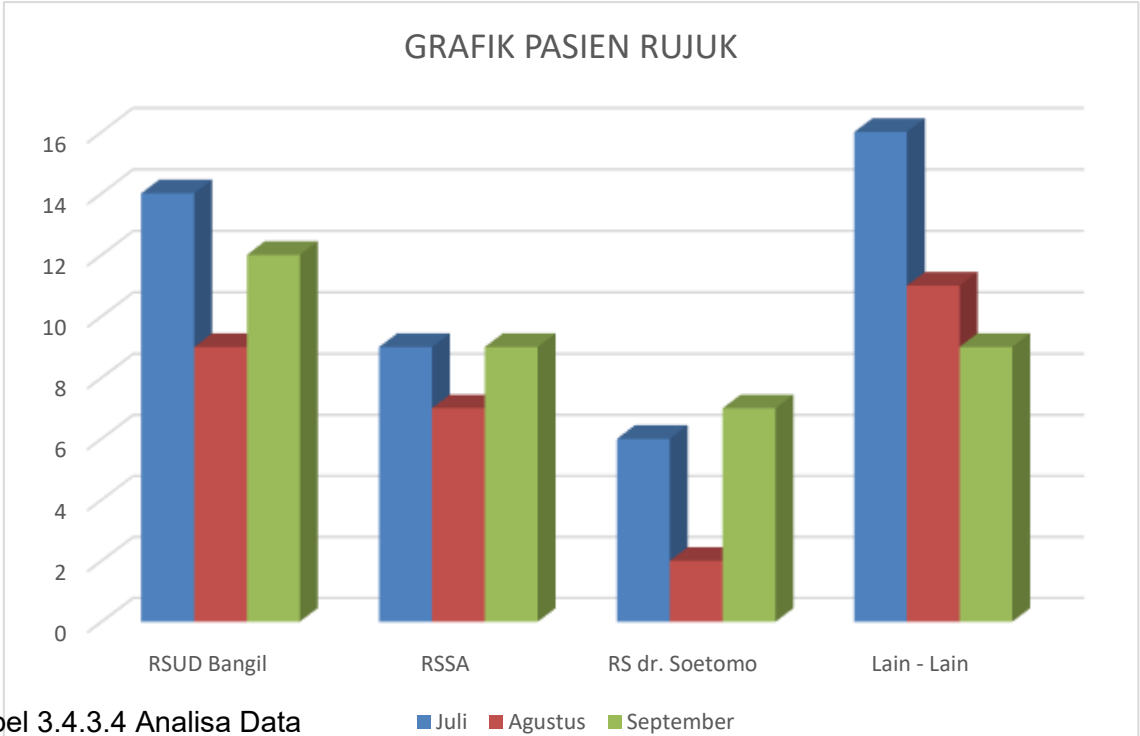
Analisis	Review Hasil
1. BOR menurun dari 80.17% (Juli) menjadi 70.43% (Agustus) dan 72.98% (September). 2. ALOS berada pada kisaran 3-4 hari, sesuai standar (6-9 hari), namun ini menunjukkan pasien pulang lebih cepat dari target → kemungkinan kasus ringan, efisiensi tinggi. 3. TOI meningkat pada Agustus – September (dari 0,65 → 1,1 hari). Nilai ideal 1-3 hari, artinya masih dalam batas. 4. BTO cukup stabil 8-10 kali, masih dalam rentang normal 40 – 50 per tahun 5. NDR 0 – 13, masih <25%, sehingga dalam batas aman.	Plan : - Menjaga BOR tetap stabil ≥ 75% sebagai target efisiensi penggunaan tempat tidur. - Memastikan mutu pelayanan tidak menurun seiring penurunan BOR Do : - Melakukan evaluasi kapasitas tempat tidur dan kecepatan rotasi pasien Study : - BOR menurun signifikan pada bulan Agustus – September, disebabkan: - Penurunan jumlah pasien masuk (rujukan menurun) - ALOS lebih pendek dari standar. Hal ini bisa menunjukkan pelayanan efisien, tetapi juga bisa berarti banyak kasus ringan atau pasien pulang cepat. - TOI naik → ada jeda waktu lebih lama sebelum tempat tidur terisi kembali. - BTO stabil → frekuensi pemakaian tempat tidur normal - NDR tetap dibawah standar → tidak ada peningkatan angka kematian Action : - Meningkatkan promosi pelayanan dan edukasi dokter - Meninjau distribusi tempat tidur dan pemanfaatan tiap ruang - Mengoptimalkan manajemen pasien masuk dan keluar

a. Rujukan Pasien

Tabel 3.4.3.3 Data Pasien Dirujuk

Bulan	JML P-Rujuk	RS Penerima Rujukan				Alasan Rujuk				Dx		
	Eksternal	RSUD	RSSA	RS dr Soetomo	lain2	HD	Picu	Cat Lab	lain2	Anemia	Pneumoni	Lain2
Juli	45	14	9	6	16	8	1	2	34	3	1	41
	2.49%	31.11%	20%	13.33%	35.55%	17.77%	2.22%	4.44%	75.55%	6.66%	2.22%	91.11%
Agustus	29	9	7	2	11	4	3	0	22	1	0	28
	1.80%	31%	24%	7%	38%	14%	10%	0	76%	3%	0	97%
September	37	12	9	7	9	8	1	0	28	2	1	34
		32.43%	24.32%	18.92%	24.32%	21.62%	2.70%	0	75.68%	5.41%	2.70%	91.89%

Grafik Data Pasien Dirujuk



Tabel 3.4.3.4 Analisa Data

Analisis	Review Hasil
1. Jumlah pasien rujukan tetap tinggi di bulan September 2. Rujukan ke RSUD Bangil dan RSSA mendominasi	Plan : - Meningkatkan ketepatan klasifikasi alasan rujukan untuk mendukung analisis mutu klinis. - Memastikan rujukan pasien dilakukan sesuai indikasi medis dan prosedur rujukan - Memantau tren rujukan k erumah sakit tujuan utama untuk memastikan kapasitas dan Kerjasama rujukan berjalan optimal. Do : - Memonitoring pola rujukan ke RS eksternal - Koordinasi dengan unit pelayanan IGD, rawat inap dan rekam medis untuk memastikan kelengkapan data rujukan. Study : - Terjadi penurunan jumlah pasien rujukan dari 45 → 37 pasien dalam 3 bulan, menunjukkan

	tren menurun. • RS penerima utama tetap konsisten ke RSUD dan RSSA, menunjukkan pola rujukan yang jelas Action : • Meningkatkan kompetensi klinis tenaga medis dalam manajemen kasus • Melakukan audit rujukan • Memperluas RS jejaring
--	---

b. LOS Pasien BPJS Kesehatan Berdasarkan DPJP

Tabel 3.4.3.5 Data Lama Rawat Pasien BPJS Kesehatan Berdasarkan DPJP Bulan September Tahun 2025

Nama DPJP	Lama Rawat (Hari)											Grand Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
dr. Aan Dwi Prasetyo Sp.N	0	0	13	20	3	1	0	0	0	0	0	37
dr. Adhya Aji Pratama Sp.PD	0	3	6	12	13	10	4	0	0	0	0	48
dr. Aditya Purwaka Sp.PD	0	0	14	17	14	1	2	0	0	0	0	48
dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG	0	7	16	5	0	0	0	0	0	0	0	28
dr. Ahmad Farid Wajdi Sp.N.	1	4	12	18	16	16	4	0	0	1	0	72
dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	0	0	5	6	4	1	0	0	0	0	0	16
dr. Ardityo Rahmat Ardhany Sp.PD-KGH	1	2	16	14	7	5	1	1	0	0	0	47
dr. Arianto Prabowo Sp. OT	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
dr. Badariyatud Dini Sp.BP-RE	0	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	10
dr. Cameleia Diah Setyorini Sp.PD	1	2	10	18	10	7	1	0	1	0	0	50
dr. Citra Dwi Harningtyas Sp.DV., M.Ked.Klin	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD	0	0	2	28	12	9	3	0	0	0	0	54
dr. Dion Setiawan Sp.JP	0	1	12	6	1	1	1	0	0	0	1	23
dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	0	0	30	7	2	1	0	0	0	0	0	40
dr. Esti Purwaningrum Sp.A.	0	3	23	20	14	7	0	0	0	1	0	68
dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS	0	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	7
dr. Ferdyan Rachmat Efendi Sp.U	0	1	51	20	4	1	2	0	0	0	0	79
dr. Fiski Purantoro Sp.OT	0	1	15	2	0	0	0	0	0	0	0	18
dr. Fitri Indahyanti Sp.P., MMRS	1	1	6	21	13	2	2	1	0	0	0	47
dr. Fuad Fauzi Sp.T.H.T.K.L.	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	9
dr. Heriyatmo Sp. PD	0	0	11	17	13	5	3	0	0	0	1	50
dr. I Gede Made Oka Rahaditya Sp. OT	0	0	13	4	0	1	0	0	0	0	0	18

dr. Julian Hartawan Wijaya Sp.T.H.T.B.K.L	0	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	16
dr. Latifah Sp.M	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
dr. Maria Valentina Evelyn Sp. JP	1	1	5	4	2	1	0	0	0	0	0	14
dr. Muhammad Irawan Sp.A.	0	8	55	36	14	6	2	0	0	0	0	121
dr. Novita Maulidiyah Sp.P	1	0	5	28	6	0	0	1	0	0	0	41
dr. Nurhadhi Sutanto Sp. M	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
dr. Nyoman Indra Bayu Sp.M	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
dr. Qashastia Sukma Paripurna Sp.A	0	5	21	9	3	1	0	0	0	0	0	39
dr. Rachmawati Wardani Sp.N	0	0	1	6	2	1	1	0	0	0	0	11
dr. Ratih Kusumawardani Sp.A, M.Biomed	1	24	52	37	6	4	3	0	1	0	1	129
dr. Riski Bagus Suhendra Sp.DVE	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
dr. Rossy Zaki Abdillah Sp.B	0	1	78	10	7	1	1	0	0	0	0	98
dr. Rudi Priyo Utomo Sp.OG	0	14	65	4	1	0	0	0	0	0	0	84
dr. Santoso Rahardjo Sp.OG.	0	10	31	0	0	0	0	0	0	0	0	41
dr. Zaki Yamani Sp.B	0	0	21	10	3	0	0	0	0	0	0	34
Grand Total	7	90	630	396	174	82	30	4	2	2	3	1420

c. KELENGKAPAN PENGISIAN E-RM

Tabel 3.4.3.6 Data Kelengkapan Pengisian E-RM

NO	NAMA DOKTER	Σ DRM ALL	PAM			CPPT			KELENGKAPAN			
			Σ DRM	L	TL	Σ DRM	L	TL	PAM		CPPT	
									%L	%TL	%L	%TL
1	dr. Muhammad Irawan Sp.A.	455	106	71	35	349	349	0	67%	33%	100%	0%
2	dr. Esti Purwaningrum Sp.A.	125	43	22	21	82	82	0	51%	49%	100%	0%
3	dr. Ratih Kusumawardani Sp.A, M.Biomed	304	109	95	14	195	194	1	87%	13%	99%	1%
4	dr. Rossy Zaki Abdillah Sp.B	327	97	97	0	230	230	0	100%	0%	100%	0%
5	dr Badariyatud Dini Sp.BP-RE	20	11	11	0	9	9	0	100%	0%	100%	0%
6	dr Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS	26	9	9	0	17	17	0	100%	0%	100%	0%
7	dr Maria Valentina Evelyn Sp. JP	563	26	26	0	537	537	0	100%	0%	100%	0%
8	dr Yekti Mumpuni Sp.KJ.	55	2	2	0	53	53	0	100%	0%	100%	0%

9	dr. Andika Widiarti Sp.K.J	215	15	15	0	200	199	1	100%	0%	100%	1%
10	dr. Rudi Priyo Utomo Sp.OG	401	106	104	2	295	295	0	98%	2%	100%	0%
11	dr. Santoso Rahardjo Sp.OG.	299	92	91	1	207	207	0	99%	1%	100%	0%
12	dr. Citra Dwi Harningtyas Sp.DV., M.Ked.Klin	152	28	21	7	124	124	0	75%	25%	100%	0%
13	dr. Nyoman Indra Bayu Sp.M	149	29	29	0	120	120	0	100%	0%	100%	0%
14	dr Nurhadhi Sutanto Sp. M	342	48	48	0	294	294	0	100%	0%	100%	0%
15	dr Arianto Prabowo Sp. OT	43	9	9	0	34	34	0	100%	0%	100%	0%
16	dr. I Gede Made Oka Rahaditya Sp. OT	188	38	38	0	150	150	0	100%	0%	100%	0%
17	dr. Fiski Purantoro Sp.OT	210	53	53	0	157	156	1	100%	0%	99%	1%
18	dr. Fitri Indahyanti Sp.P., MMRS	185	66	66	0	119	118	1	100%	0%	99%	1%
19	dr. Novita Maulidiyah Sp.P	217	50	49	1	167	167	0	98%	2%	100%	0%
20	dr Cameleia Diah Setyorini Sp.PD	399	40	40	0	359	359	0	100%	0%	100%	0%
21	dr. Heriyatmo Sp. PD	656	48	48	0	608	608	0	100%	0%	100%	0%
22	dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD	585	92	92	0	493	492	1	100%	0%	100%	0%
23	dr. Aan Dwi Prasetyo Sp.N	290	33	33	0	257	257	0	100%	0%	100%	0%
24	dr. Ahmad Farid Wajdi Sp.N.	846	102	102	0	744	743	1	100%	0%	100%	0%
25	dr. Fuad Fauzi Sp.T.H.T.K.L.	66	25	22	3	41	41	0	88%	12%	100%	0%
26	dr Ferdyan Rachmat Efendi Sp.U	321	85	84	1	236	236	0	99%	1%	100%	0%
27	dr. Zaki Yamani, Sp. B	131	43	42	1	88	88	0	98%	2%	100%	0%
29	dr. Aditya Purwaka Sp.PD	204	59	59	0	145	145	0	100%	0%	100%	0%
30	dr. Erinda Rahma Mulia Sp. FKR	360	55	55	0	305	302	3	100%	0%	99%	1%
31	dr. Eko Nugroho Sp. FKR	528	33	33	0	495	494	1	100%	0%	100%	0%
32	dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	377	25	25	0	352	352	0	100%	0%	100%	0%
33	dr. Ardityo Rahmat Ardhany Sp.PD-KGH	115	18	18	0	97	97	0	100%	0%	100%	0%
34	dr. Latifah Sp.M	235	67	67	0	168	168	0	100%	0%	100%	0%
35	dr. Rachmawati Wardani Sp. N.	65	21	21	0	44	44	0	100%	0%	100%	0%
36	dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	120	55	55	0	65	64	1	100%	0%	98%	2%
37	dr. Agung Wijaya Kusuma, Sp.OG	85	33	33	0	52	52	0	100%	0%	100%	0%
38	dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	116	39	38	1	77	77	0	97%	3%	100%	0%
39	dr. Julian Hartawan Wijaya Sp. T.H.T.B.K.L	217	91	89	2	126	126	0	98%	2%	100%	0%
40	dr. Dion Setiawan, Sp.JP	144	25	21	4	119	119	0	84%	16%	100%	0%
41	dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE	112	41	38	3	71	69	2	93%	7%	97%	3%

42	dr.Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A	62	37	28	9	25	24	1	76%	24%	96%	4%
Total		10310	2004	1899	105	8306	8292	14	94.80%	5.50%	99.80%	0.20%
				2004			8306					

Tabel 3.4.3.7 Analisa Data

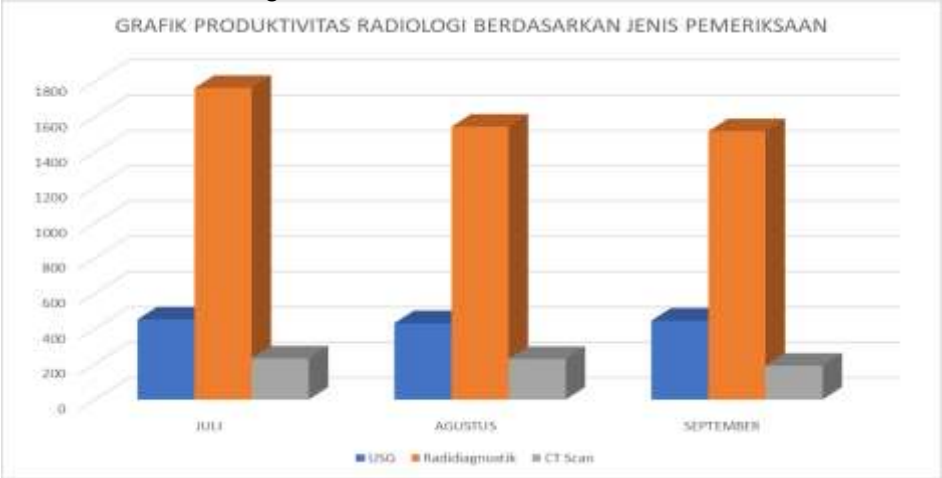
Analisa	Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Adanya pengisian ERM yang belum lengkap, di pengkajian medis DPJP dibagian tolak ukur, tanda tangan pasien, tanda tangan dokter	Ketidaklengkapan pengisian ERM untuk pasien umum dan asuransi yang harus membuka billing, akses hanya dimiliki oleh kasir	Koordinasi dengan kepala unit/ kepala aruang terkait untuk supervisi pengisian DRM dengan lengkap

1.4.4. RADIOLOGI

Tabel Kinerja produktivitas Radiologi berdasarkan jenis pemeriksaan

PEMERIKSAAN	JENIS PEMERIKSAAN	BULAN		
		Juli	Agustus	September
USG	ABDOMEN/UROLOGI	401	366	383
	ABDOMEN CITO	2	3	3
	THORAX	2	8	7
	MAMMAE	8	8	11
	THYROID/COLLI	24	20	22
	TESTIS	8	17	14
	PAROTIS	0	0	0
	VASKULER	6	10	3
	ANKLE	0	0	0
	FEMUR	0	0	0
	KEPALA	2	0	2
	MUSKULOSKELETAL	0	1	2
	MANDIBULA	1	0	0
	TOTAL	454	433	447
RADIO DIAGNOSTIK	SKULL	7	6	6
	THORAX	1116	943	988
	EXTERMITAS ATAS	192	150	134
	EXTERMITAS BAWAH	168	174	151
	KUB/BN0	134	115	107
	PELVIS	29	31	24
	BABYGRAM	14	16	20
	CERVICAL	19	10	12
	THORACOLUMBAL	11	9	7
	LUMBOSACRAL	68	83	64
	LUMBAL	0	1	0
	IVP + KONTRAS	0	0	0
	URETROGRAFI	0	0	0
	COLON IN LOOP	0	0	0
	PANORAMIC	6	7	7
	WATERS	1	1	0
	TOTAL	1765	1546	1520
CT SCAN	KEPALA	154	152	129
	KEPALA DENGAN KONTRAS	5	6	8
	KEPALA TRAUMA	56	56	38
	BRAIN SINUS DAN MATOID NON KONTRAS	3	7	8
	THORAX	5	0	1
	THORAX DENGAN KONTRAS	0	0	1
	ABDOMEN	5	4	3
	ABDOMEN DENGAN KONTRAS	1	2	1
	PELVIS	0	0	1
	VERTEBRAE	0	0	1
	CERVICAL VERTEBRAE	0	0	0
	LUMBOSACRAL	0	0	0
	THORACAL VERTEBRAE NON KONTRAS	1	2	0
	THORAX VERTEBRAE	1	0	0
	CRURIS	0	0	0
	LUMBOSACRAL VERTEBRAE	1	1	0
	EKSTERMITAS LAIN	1	0	1
	TOTAL	233	230	192
	TOTAL PEMERIKSAAN	2452	2209	2159

Grafik Produktivitas Radiologi Berdasarkan Jenis Pemeriksaan



Tabel 3.4.1.2 Analisa Data

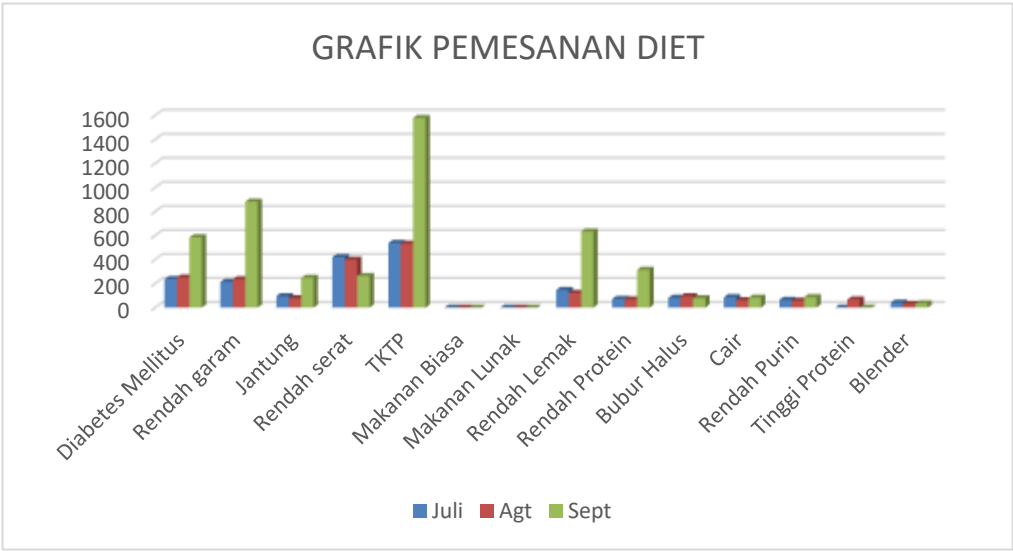
Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
Kunjungan radiologi dibulan September menurun dibandingkan bulan sebelumnya	Plan : - Meningkatkan jumlah kunjungan dan pemeriksaan radiologi melalui optimalisasi pelayanan dan alur rujukan. - Meningkatkan pemasaran di bagian radiologi terutama terkait dengan MCU. Do : - Meningkatkan pemasaran terkait radiologi melalui program MCU Study - Dari data tiga bulan, penurunan volume terbesar berasal dari USG dan pemeriksaan radiodiagnostik dasar (Thorax, Abdomen) - Pemeriksaan spesifik seperti CT Scan cenderung stabil, meskipun volumenya kecil - Dugaan penyebab penurunan antara lain: ➤ Adanya perubahan pola rujukan pasien dengan pembatasan jumlah pasien Action: - Kolaborasi dengan Humas Marketing dalam penawaran MCU

1.4.5. GIZI

A. Tabel Kinerja Produktivitas Gizi Berdasarkan Jenis pemesanan diet Pasien

No	Nama Diet	Juli	Agt	Sept
1	Diabetes Mellitus	237	250	584
2	Rendah garam	214	235	881
3	Jantung	95	77	248
4	Rendah serat	419	398	263
5	TKTP	538	531	1577
6	Makanan Biasa	0	0	0
7	Makanan Lunak	0	0	0
8	Rendah Lemak	147	121	633
9	Rendah Protein	72	68	313
10	Bubur Halus	81	95	78
11	Cair	86	62	82
12	Rendah Purin	64	57	86
13	Tinggi Protein	0	68	0
14	Blender	41	30	35
TOTAL		1994	1992	4780

Grafik Pemesanan Diet Pasien



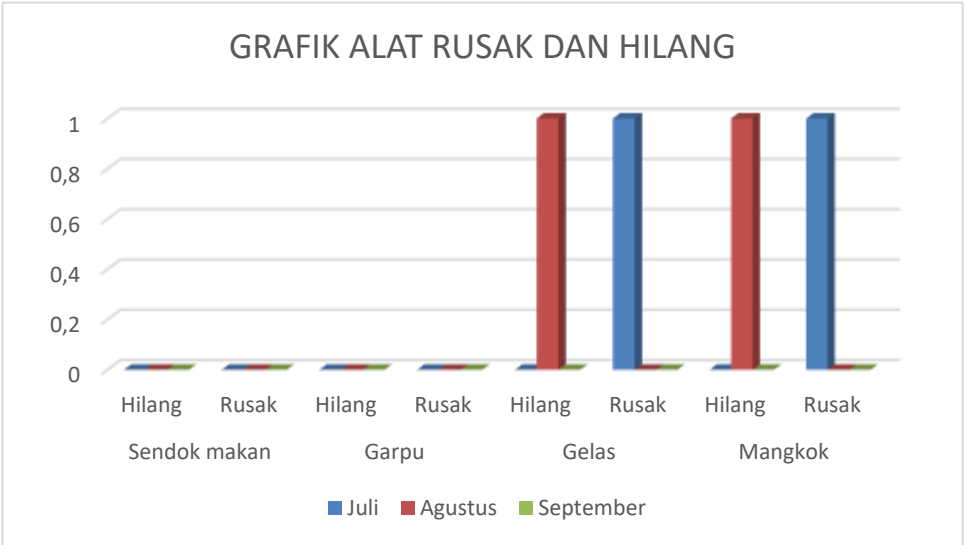
Tabel Analisa Data

Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
Ada ketidakseimbangan permintaan diet dan jenis diet tertentu tidak digunakan sama sekali	Plan : - Memastikan ketersediaan diet sesuai kebutuhan klinis pasien - Melakukan monitoring harian pemesanan diet. Do : - Melakukan monitoring bulanan terhadap permintaan diet - Koordinasi dengan DPJP untuk kesesuaian diet klinis - Memastikan SDM instalasi gizi mampu menyediakan diet dengan variasi lengkap Study - Diet TKTP meningkat tajam di bulan September - Diet rendah garam dan diabetes melitus juga meningkat konsisten

	Action : - Menyediakan stok bahan makanan sesuai tren diet terbanyak - Meninjau ulang diet yang tidak terpakai, apakah perlu tetap dipertahankan dalam daftar standar
--	--

Data Alat Rusak dan Hilang

Bulan	Sendok makan		Garpu		Gelas		Mangkok	
	Hilang	Rusak	Hilang	Rusak	Hilang	Rusak	Hilang	Rusak
Juli	0	0	0	0	0	1	0	1
Agustus	0	0	0	0	1	0	1	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0



Analisa Data

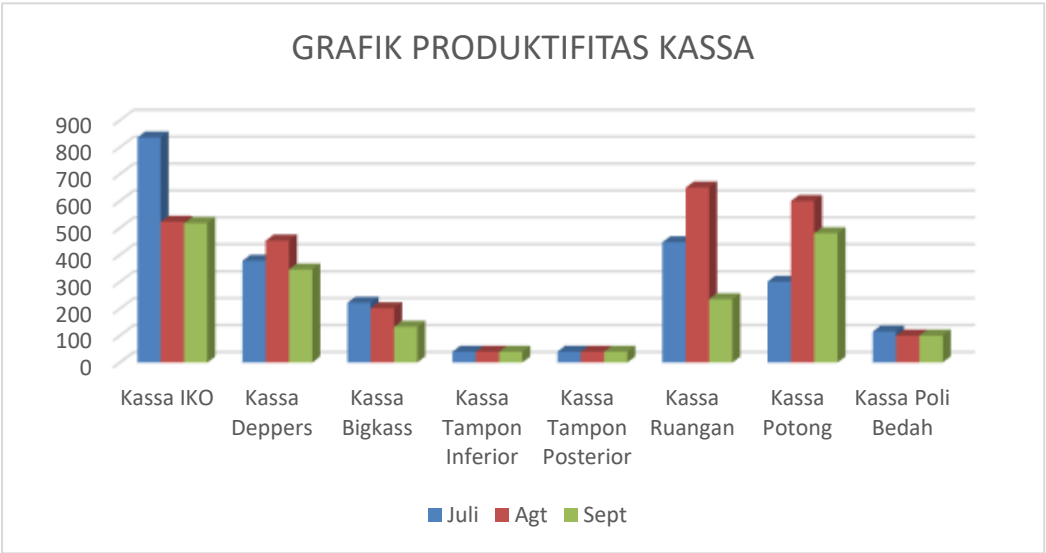
Analisa	Review Hasil
	Plan : - Meningkatkan kontrol dan pengawasan penggunaan peralatan Do: - Melakukan pencatatan harian jumlah alat yang digunakan dan dikembalikan - Membuat checklist pengelolaan alat makan Study: - Terjadi penurunan jumlah alat rusak/hilang secara bertahap - Sistem pengontrolan dan penacatatan alat berjalan baik Action - Memperketat pengawasan distribusi dan pengumpulan gelas/mangkok - Melakukan audit berkala inventaris

1.4.6. Instalasi CSSD

Tabel Kinerja Produktivitas CSSD Berdasarkan Produksi Kassa 2025

No	Jenis Kassa	Juli	Agustus	September
	Bahan BJ			
1	Kassa IKO	836	523	518
2	Kassa Deppers	378	453	346
3	Kassa Bigkass	222	202	133
4	Kassa Tampon Inferior	40	40	40
5	Kassa Tampon Posterior	40	40	40
	Bahan Hidrofil			
1	Kassa Ruangan	447	650	235
2	Kassa Potong	300	600	480
3	Kassa Poli Bedah	115	100	100

Grafik Produktivitas Kassa



Tabel 3.6.1.2 Analisa Data

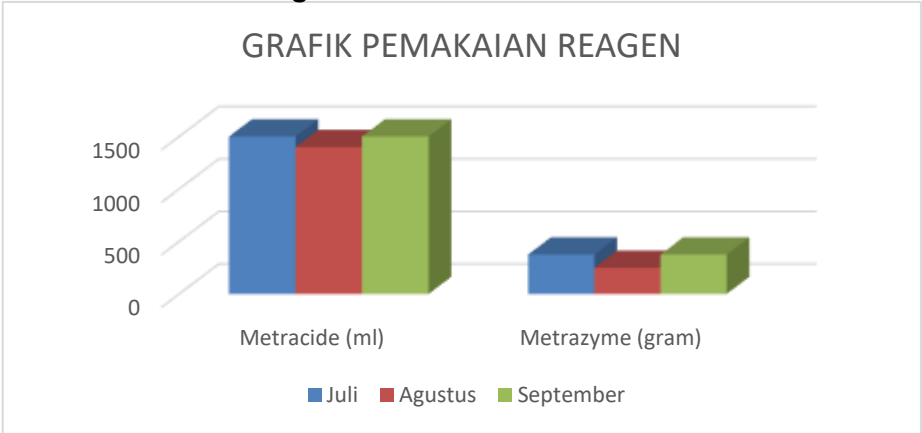
Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
Penggunaan jenis kassa mengalami penurunan di beberapa jenis	Plan : - Mengevaluasi permintaan unit pengguna - Memantau produksi internal Do : - Memonitoring pemakaian kassa setiap minggu - Pendistribusian ulang stok kassa berdasarkan permintaan unit layanan Study - Kassa IKO mengalami fluktuasi namun stabil tinggi - Kassa deppers dan kassa potong menunjukkan penurunan - Penurunan kassa ruangan dan deppers dikarenakan penurunan permintaan dan perubahan aktivitas layanan Action - Menyesuaikan perencanaan pengadaan dengan tren - Membuat buffer stok untuk jenis yang mengalami lonjakan mendadak - Melakukan monitoring bulanan berbasis data konsumsi

3.6.1 Reagen

Tabel 3.6.2.1 Pemakaian Reagen

Bulan	Metracide (ml)	Metrazyme (gram)
Juli	1500	375
Agustus	1400	350
September	1500	375

Grafik Pemakaian Reagen

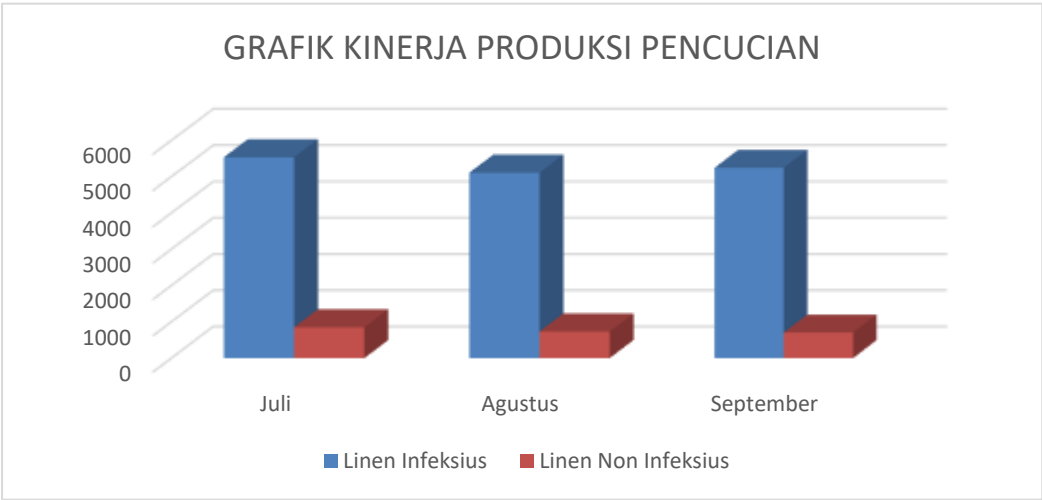


1.4.7. LAUNDRY

Tabel Kinerja Produktivitas Laundry Berdasarkan Jenis Linen 2025

No	Jenis Linen	Juli	Agustus	September
		Dalam Kg		
1	Linen Infeksius	5536,6	5112	5243,5
2	Linen Non Infeksius	848	732,5	702
	JUMLAH	6384,6	5844,5	5945,5

Grafik produktivitas linen



Analisis	Review Hasil Berdasarkan PDCA
Kinerja pencucian di bulan Agustus mengalami peningkatan	Plan : - Mengevaluasi produktivitas pencucian linen Do : - Proses pencucian dijalankan secara rutin setiap bulan sesuai dengan SPO - Pemisahan linen infeksius dan non infeksius dilakukan dengan benar untuk menghindari kontaminasi silang - Meningkatkan koordinasi antar unit untuk memastikan kelancaran pengumpulan linen dan kesiapan alat - Memantau penggunaan alat bantu cuci agar efisien dan tidak overload Study : - Penurunan linen non infeksius konsisten, karena lebih banyak pasien dengan kondisi infeksius - Penurunan di Agustus tetap lebih tinggi dari Juni karena jumlah pasien menurun

Tabel Stok Linen di Unit

No	Ruangan	Keterangan Linen	Stok Sebelumnya	September			Stok Akhir
				rusak	hilang	Pergantian Linen Rusak	
1	IRNA 3A	Sprei	74	0	0	0	74
		Selimut Hijau	62	0	0	0	62
		Sarung Bantal	86	0	0	0	86
		Selimut Coklat	45	0	0	0	45
		Selimut VIP	25	0	0	0	25
2	Maternitas	Sprei	58	0	0	0	58
		Selimut Hijau	46	0	0	0	46
		Sarung Bantal	27	0	0	0	27
		Selimut Coklat	6	0	0	0	6
3	IRNA 2A	Sprei	44	0	0	0	44
		Selimut Hijau	56	0	0	0	56
		Sarung Bantal	84	0	0	0	84
4	IRNA 2B	Sprei	57	0	0	0	57
		Selimut Hijau	50	0	0	0	50
		Sarung Bantal	64	0	0	0	64
		Selimut Coklat	7	0	0	0	7
5	IRNA 3B	Sprei	49	0	0	0	49

		Selimut Hijau	80	0	0	0	80
		Sarung Bantal	71	0	0	0	71
6	ICU	Sprei	12	0	0	0	12
		Selimut Hijau	13	0	0	0	13
		Baju px	11	0	0	0	11
7	PERIN	Sprei	20	0	0	0	20
		Selimut Hijau	20	0	0	0	20
		Sarung Bantal	20	0	0	0	20
8	REHAB	Sprei	24	0	0	0	24
		Selimut	23	0	0	0	23
		Sarung Bantal	19	0	0	0	19
9	IKO	Gown	100	0	0	0	100
		Baju Pasien	34	0	0	0	34
		Baju Tim	36	0	0	0	36
		Alas Meja Operasi	66	0	0	0	66
		Duk Kaki	4	0	0	0	4
		Duk Lubang (B)	25	0	0	0	25
		Meja Mayo	43	0	0	0	43
		Duk Kecil	150	0	0	0	150
		Duk Doble	25	0	0	0	25
		Duk Sedang	70	0	0	0	70
		Duk Lubang (K)	42	0	0	0	42
		Duk Buntu	25	0	0	0	25
		Selimut Hijau	10	0	0	0	10
		Handuk	40	0	0	0	40
10	IGD	Selimut Hijau	28	0	0	0	28
11	Poli	Selimut Coklat	22	0	0	0	22
		Sarung Bantal	11	0	0	0	11
12	IRNA 2D	Sprei	27	0	0	0	27
		Selimut Hijau	29	0	0	0	29
		Sarung Bantal	30	0	0	0	30

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan

3.5.1 IPSRS

Data Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes Tahun 2025

Bulan	Jumlah Alkes	Jumlah Pemeliharaan Alkes / Prosentase	Jumlah Perbaikan Alkes / Prosentase	Jumlah Kalibrasi Alkes /Prosentase	Jumlah Recall Alkes	Keterangan
Januari	378	242 (64.02%)	6 (1.58%)	296 (78.31%)	0	0
Februari	378	232 (61.37%)	7 (1.85%)	296 (78.31%)	0	0
Maret	383	215 + 133 = 348 (90.86%)	5 (1.31%)	296 (77.28%)	0	0
April	383	119 + 90 = 209 (54.56%)	4 (1.04%)	296 (77.28%)	0	0
Mei	382	156 + 184 = 340 (89%)	9 (2.36%)	296 (77.49%)	0	0
Juni	382	119 + 238 = 357 (93.46%)	7 (1.83%)	296 (77.49%)	0	0
Juli	382	260 (68.06%)	10 (2.62%)	296 (77.49%)	0	0
Agustus						
September						
Oktober						
November						
Desember						
Total						
Rata-Rata /Bulan						

A. Sistem Utilitas

1. Listrik

a. Kegagalan Listrik

Kegagalan Listrik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Kegagalan Listrik	Tanggal Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
Januari	1	01/01/2025 PLN off , Genset On 13.30 PLN on, Genset off 14.44	1. Seluruh area (PLN off dan Genset tidak bisa nyala)	1. Accu genset waktunya penggantian	1. Penggantian accu genset
Februari	2	15/02/2025	1. Seluruh	1. PLN Off	Memastikan

Bulan	Jumlah Kegagalan Listrik	ian Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
		pukul 12.05 N off , Genset On 14.10 PLN on, Genset off 15.16	area (PLN off dan Genset on).		genset ready to use
		02/2025 PLN off , Genset On 09.38 PLN on, Genset off 10.54	1. Seluruh area (PLN off dan Genset on).	1. PLN Off	Memastikan genset ready to use
Maret	0	-	-	-	-
April	3	04/2025 PLN off , Genset On 13.22 N off lagi 14.00 N ON 14.25	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		04/2025 N off , Genset On 10.07 N on, Genset off 10.36	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		04/2025 N off , Genset On 16.38 N on, Genset off 18.07	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
Mei	1	09/05/2025 PLN off, Genset On 13.30 PLN on, Genset off = 19.04	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
Juni	1	07/06/2025 PLN off, Genset On 09.05 PLN on, Genset off 09.16	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use

Bulan	Jumlah Kegagalan Listrik	Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
Juli	2	07/07/2025 PLN off, Genset On 09.05	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		PLN on, Genset off 09.16			
		14/07/2025 PLN off, Genset On 15.08	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		PLN on, Genset off 15.10			
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Rata-Rata					

B. Pemeliharaan dan Perbaikan Listrik
 Pemeliharaan dan Perbaikan Panel Listrik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Panel Listrik	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
Januari	29	0	0	-
Februari	32	32	0	alam kondisi baik
Maret	32	32	0	alam kondisi baik
April	32	0	0	-
Mai	32	0	0	-
Juni	32	0	0	-
Juli	32	0	0	-
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Rata-Rata				

C. Pengaduan Billing IPSRS
 Pengaduan Billing IPSRS Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
Januari	63 (100%)	49 (77.78%)	14 (22.22%)	0	Tukang = 14 AC = 31 Alkes = 2 Bed = 2 Bel = 2 Diswashing =1 Kursi = 2 Lampu = 4 Listrik = 1 Mesin Pengering = 1 Tiang Infus = 2 Trolis = 1
Februari	80 (100%)	44 (55%)	36 (45%)	0	Tukang = 36 IT = 0 AC = 23 Alkes = 5 Lampu = 4 Kursi = 1 Dispenser = 1 Bell = 4 Roda Nakas =1 Roda Standar Infus = 2 Televisi = 2 Kulkas = 1
Maret	76 (100%)	60 (78.95%)	16 (21.05%)	0	Tukang = 16 IT = 1 AC= 24 Alkes = 8 Lampu dan Listrik = 7 Diswashing Pantry = 1 Dispenser=3 Exhaust = 2 Kursi = 3 Bell = 5 Handrail = 2 Nursecall= 2 Bed = 2
April	72 (100%)	37 (51.39%)	35 (48.61%)	0	Tukang = 35

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
					IT = 0 AC= 22 Alkes = 1 Heater = 1 Dispenser=3 Lampu dan Stop Kontak =7 Trolis/ Solo= 2 Nursecall = 1
Mei	68 (100%)	22 (32.35%)	45 (66.18%)	1 (1.47%)	kang = 22 = 1 mpu =7 = 24 es = 3 ng dan Roda = 4 lkas = 1 sin cuci dan pengering = 3 rsi = 1 =1 Exhaust = 1
Juni	75 (100%)	51 (68%)	23 (30.67%)	1 (1.33%)	kang = 23 = 1 = 26 es = 4 d + Handrail = 4 mpu + Listrik = 10 rsecall = 2 sin Cuci = 1 ect Killer = 1 penser = 1 haust = 1 Kursi = 1
Juli	101 (100%)	67 (66.34%)	34 (33.66%)	0 (0%)	kang = 34 es = 7 = 29 d = 4 rse call = 4 trik = 9 penser = 1 rsi = 1 = 3 gulator = 2

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
					da = 3 ddle Tempat Sampah = 1 = 2 Kulkas = 1
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Total/ Tahun					
Rata-Rata/ Bulan					

Terdapat total 75 pengaduan yang telah diselesaikan oleh IPSRS, Tukang dan IT pada Juni 2025. Terdapat 51 (68%) pengaduan yang diselesaikan oleh IPSRS dan 23 (30.67%) pengaduan yang diselesaikan oleh tukang bangunan, serta 1 (1.33%) pengaduan yang telah diselesaikan IT.

D. Pemeliharaan dan Perbaikan AC
 Pemeliharaan dan Perbaikan AC

Bulan	Jumlah AC	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
Januari	172	0	31 (18.02 %) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	-
Februari	172	0	23 (13.37%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Maret	172	50 (29.07%)	24 (13.95%)	
April	172	0	22 (12.79%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Mei	172	0	66 (38.37%) Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Juni	172	0	26 (15.12%) Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Juli	172	0	29 (16.86%) Berdasarkan billing SIM	

Bulan	Jumlah AC	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
			IPSRs)	
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total/Tahun				
Rata-Rata / Bulan				

3.5.2 Pemeriksaan Mutu Air Bersih dan Air Limbah

Bulan	Suhu (30 °C)	pH (6-9)	BOD (30mg/L)	COD (80mg/L)	TSS (30mg/L)	NH3-N (0.1 mg/L)	PO4 (2 mg/L)	Total Coliform (10000 MPN/ 100mL)
Januari	28.0	7.06	13.54	41.13	22.4	0.0346	0.0918	940
Februari (Inlet)	27.0	7.62	72.08	217.2	29.3	0.1816	1.072	790000
Februari (Outlet)	26.0	7.49	9.54	26.08	5.86	0.0319	<0.035 2	630
Maret	27	7.32	15.09	40.80	5.26	0.0207	0.1164	920
April	28	7.20	8.53	35.70	5.72	0.0006	0.6734	540
Mei	27	7.30	14.75	41.10	9.88	0.0713	9.970	1200
Juni	27	7.50	11.26	35.94	11.6	0.0166	8.860	2200
Juli	28	7.55	9.53	38.92	7.20	0.0184	1.318	1700
Agustus								
September								
Oktober								
November								
Desember								
Rata-Rata								

3.5.3 PIPP – MOD – MPP

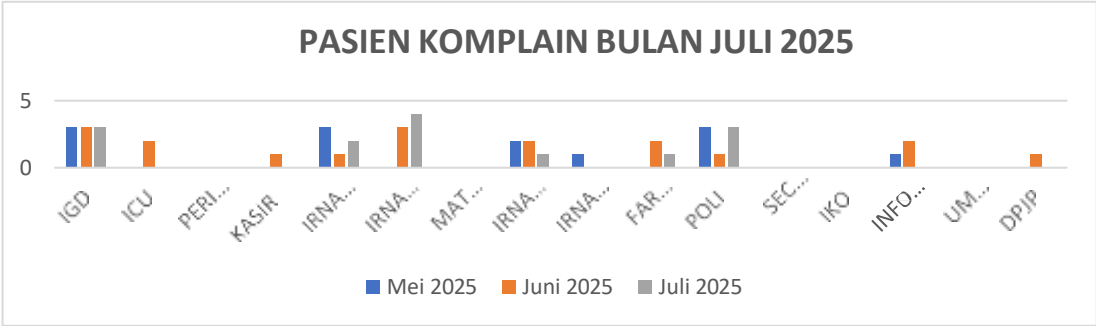
A. Angka Kepuasan Pasien

Distribusi Laporan Komplain Pasien per unit bulan Juli 2025 di RS Prima Husada Sukorejo

PASIENT KOMPLAIN	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
IGD	3	3	3
ICU	0	2	0
PERINATOLOGI	0	0	0
KASIR	0	1	0
IRNA 3A	3	1	2
IRNA 3B	0	3	4
MATERNITAS	0	0	0
IRNA 2A	2	2	1
IRNA 2B	1	0	0
FARMASI	0	2	1
POLI	3	1	3

SECURITY	0	0	0
IKO	0	0	0
INFORMASI/PDF	1	2	0
UMUM (dapur ipsrs)	0	0	0
DPJP	0	1	0
TOTAL	13	18	14

Grafik Laporan Kompalin Pasien per unit bulan Juli 2025 di RS Prima Husada Sukorejo



Jumlah pasien komplain selama Bulan Juli 2025 mengacu pada komplain pasien secara tatap muka langsung dan pesan melalui chatt seperti whatsapp..

- Komplain terbanyak bulan Juli 2025 yaitu dari IGD, POLI dan IRNA 3b sebanyak 4 kasus yang disampaikan secara WA maupun tatap muka langsung terkait pelayanan dokter, proses pemindahan pasien ke rawat inap dan komunikasi ppa sudah koordinasi dengan yang bersangkutan seperti ppa dan pihak management.

Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dan komunikasi kepada karu agar lebih disiplin terhadap perawat

3.5.4 Penjaminan

3.5.4.1 Tabel Data Klaim Pending

Bulan	Klaim Pending RJ	Jumlah Berkas Klaim RJ	Klaim Pending RI	Jumlah Berkas Klaim RI
Januari	0	9.549	0	1.376
Februari	0	9.252	0	1.373
Maret	0	9.263	0	1.448
April	0	8.958	0	1.383
Mei	0	8.991	0	1.637
Juni	0	8.741	8	1.486
Juli	11	10.429	160	1.568
Agustus	10	9.375	147	1.400
September		8.516		1.339
Oktober				
November				
Desember				

kasus pending

- resource terbanyak selama perawatan khususnya pada kasus diagnosa utama kronis dan diagnosa sekunder kasus acute
- pasien sudah ada indikasi di rujuk sejak awal sehingga di tagihkan rawat jalan
- tindakan operatif TURP dimana terdapat diagnosa ISK maka diagnosa ISK merupakan satu rangkaian dengan diagnosa utam
- kasus CVA trombo dan CVA emboli disertai dengan hemiplegia maka hemiplegia include dengan diagnosa utama (temuan audit SPI)
- kode tindakan endoskopy menggunakan 21.21

tindak lanjut

1. koordinasi dengan DPJP terkait reseleksi diagnosa berdasarkan resource terbanyak
2. koordinasi dengan dokter IGD apabila terdapat indikasi rujuk sejak awal maka tidak perlu diterbitkan surat perintah rawat inap
3. koordinasi dengan DPJP untuk kondisi ISK bukan merupakan satu kesatuan dengan diagnosa utamanya sehingga di pertahankan
4. regrouping diagnosa hemiplegia
5. cek kembali kodefikasi tindakan sesuai ICD 9 CM

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Tabel Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	≥80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepuasan Pasien	≥76.61%

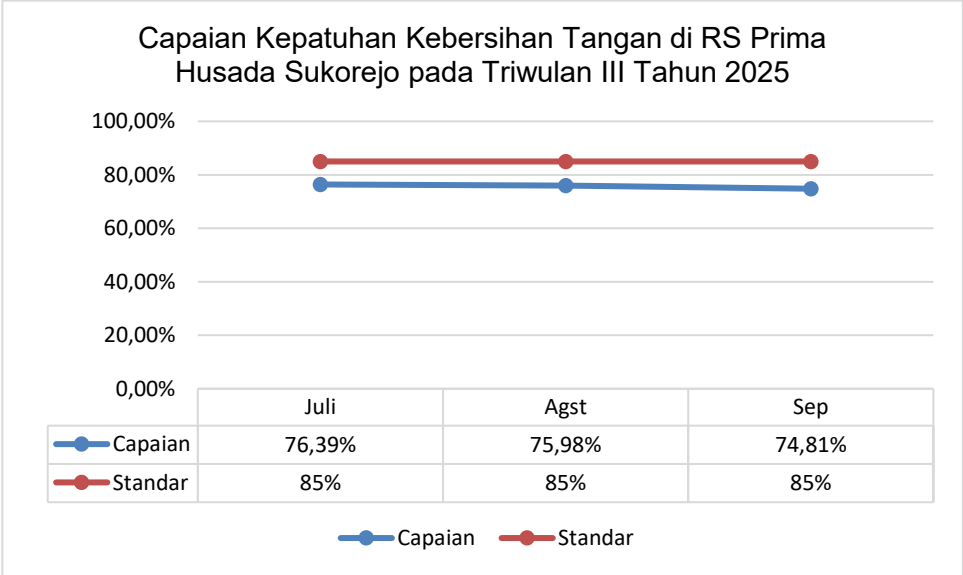
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Bulan Triwulan III Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		Juli	Agustus	September			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	76,39%	75,98%	74,81%	≥85%	75,73%	PDSA
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	92,01%	83,84%	83,55%	100%	86,47%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	99,80%	99,56%	99,68%	100%	99,68%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	100%	97,30%	100%	≥80%	99,10%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	64,29%	77,96%	61,67%	≥80%	67,97%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	3,68%	3,98%	2,36%	≤5%	3,34%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	80,09%	77,28%	76,10%	≥80%	77,82%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	99,19%	98,99%	100%	≥80%	99,39%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya	98,63%	97,68%	98,55%	100%	98,29%	PDSA

No	dul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		Juli	Agustus	ptembe r			
	Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh						
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertaha nkan
13	Kepuasan Pasien	95,00%	88,10%	93,10%	≥76.61%	92,07%	Dipertaha nkan

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan III yakni mencapai 75,73%. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu ≥85%. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan III Tahun 2025

Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Bulan Triwulan III 2025 hanya mencapai 75,73%, belum mencapai target ≥85%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: - Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target ≥85%, dengan rata-rata kepatuhan bulan Triwulan III 2025 sebesar 75,73%. - Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. - Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. 2. Tujuan: - Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan ≥85% secara konsisten selama Triwulan III (Juli – September 2025). - Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan 3. Rencana Aksi: - Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan

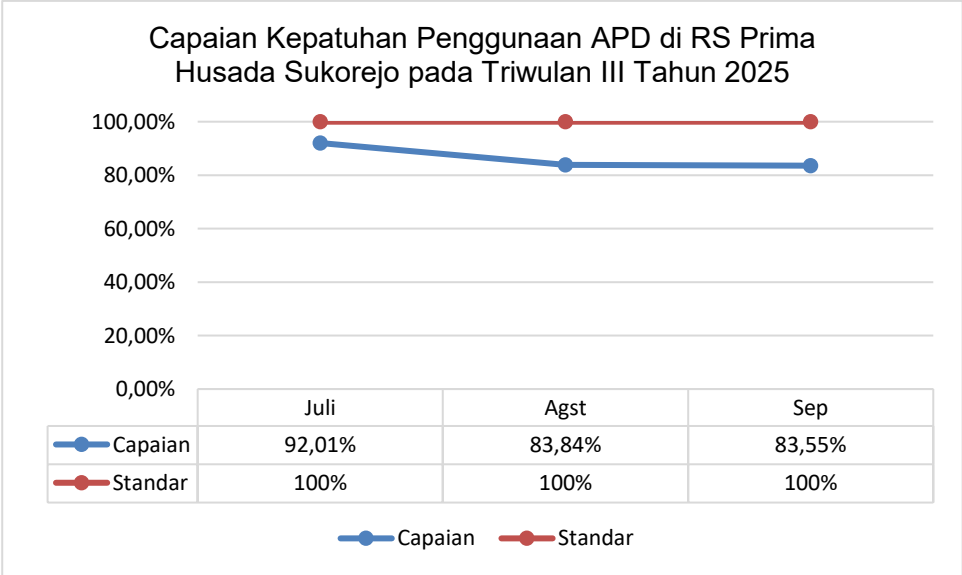
	coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). b. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. c. Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	1. IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu 2. Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. 3. Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	1. Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan III 2025 yaitu 75,73% 2. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan tertinggi yakni unit Farmasi sebesar 100% 3. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 85,19% walaupun belum mencapai standar 4. Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 <i>Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO 5. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan a) Sebelum kontak dengan pasien sebesar 58,43% b) Sebelum Tindakan aseptik sebesar 65,98% c) Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 67% d) Setelah kontak dengan pasien sebesar 66,10% e) Setelah dari lingkungan pasien sebesar 67,23%
Action	1. Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). 2. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. 3. Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan bedside coaching	Mengetahui secara langsung tingkat kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Observasi langsung oleh IPCN/IPCLN - Feedback real-time di tempat - Dokumentasi hasil audit untuk evaluasi	IPCN/IPCLN	1 kali/minggu/unit
2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung - Melaporkan kepatuhan tim tiap minggu ke manajemen	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	Penilaian berdasarkan hasil audit IPC	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan

	memiliki tingkat kepatuhan terbaik	terhadap kepatuhan kebersihan tangan		- Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi		tiap akhir bulan (September–Desember 2025)
--	------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Triwulan III yakni mencapai 86,47%. Terjadi penurunan signifikan 8% dari bulan Agustus ke Bulan Juli Tahun 2025. Tetap hasil capaian di bulan september hampir sama dengan bulan Agustus 2025. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan penggunaan APD masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan III Tahun 2025

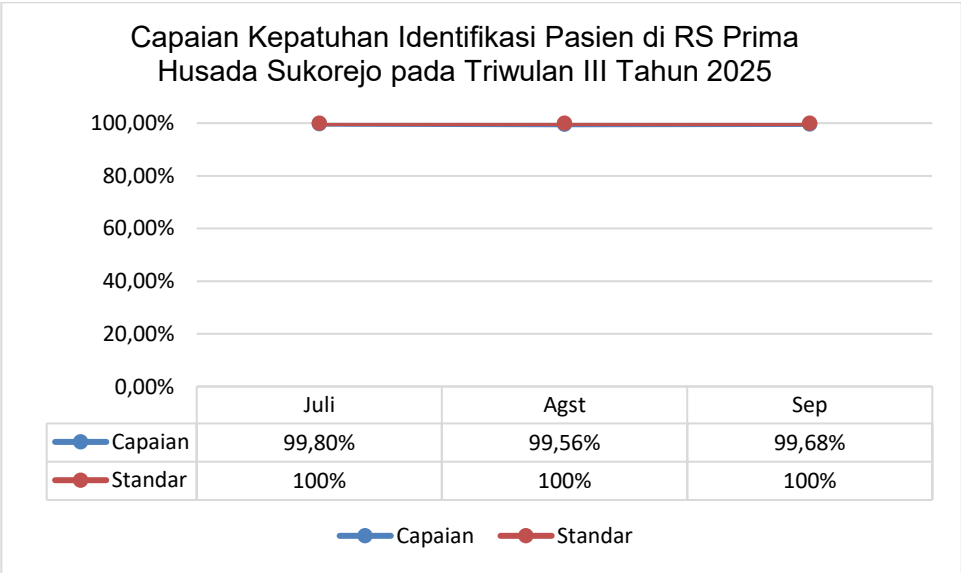
Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 86,47%. Meskipun pelatihan penggunaan APD telah dilaksanakan pada bulan Mei (untuk Pelatihan PPI seluruh staf) dan diperkuat kembali dalam pelatihan PMKP bulan Juni dan Triwulan III, tingkat kepatuhan penggunaan APD masih belum mencapai target 100%.
Step	Melakukan penguatan edukasi berkelanjutan dan monitoring langsung kepada seluruh staf, khususnya kepada kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: - Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 86,47%. - Setelah dua kali pelatihan (umum dan khusus), masih ditemukan staf yang belum konsisten dalam penggunaan APD sesuai prosedur. 2. Tujuan: - Meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan penggunaan APD hingga mencapai 100%, khususnya pada unit yang telah mendapatkan pelatihan. 3. Rencana Aksi: - Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum sebagai tindak lanjut pelatihan. - Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing.

	d. Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian.
Do	1. Melakukan observasi langsung terhadap penggunaan APD staf CS dan Unit Umum pasca pelatihan 2. Memberikan feedback dan pembinaan langsung kepada staf yang ditemukan tidak sesuai prosedur.
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 86,47% belum mencapai target 100% 2. Monitoring menunjukkan unit yang mendapat pelatihan lebih aware, namun perubahan perilaku belum konsisten. 3. Evaluasi pelatihan menunjukkan perlunya penguatan praktik langsung dan coaching on the spot, bukan hanya teori.
Action	1. Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan 2. Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf sebagai tindak lanjut pelatihan. 3. Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. 4. Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian.

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN	Mendeteksi dini ketidakpatuhan dan memberikan pembinaan langsung	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	• Observasi langsung • Pembinaan di tempat (real-time coaching) • Dokumentasi dan tindak lanjut langsung	IPCN, IPCLN	1 Bulan
2	Audit dan supervisi khusus bagi staf yang sudah mendapatkan pelatihan	Menindaklanjuti hasil pelatihan Juni, Triwulan III dan memperkuat penerapan di lapangan	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	• Audit mingguan • Supervisi oleh IPC dan Karu • Penguatan budaya kerja aman	IPCN, Karu, Supervisor CS, Koordinator Unit Umum	1 Bulan
3	Penyusunan dan distribusi SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan Non-Medis	Menyediakan panduan praktis dan mudah dipahami di area kerja	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	• SPO 1 lembar disesuaikan dengan risiko kerja • Poster visual dipasang di area kerja • Sosialisasi singkat per shift	Tim IPC, Tim PMKP, Kepala Unit	1 Bulan
4	Peningkatan peran Karu dan supervisor dalam monitoring harian	Memastikan keberlanjutan kepatuhan di level unit	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	• Format pelaporan ketidaksesuaian harian • Peningat briefing harian • Koordinasi antar shift	Kepala Ruang	1 Bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III 2025 mencapai 99,68%. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan III Tahun 2025

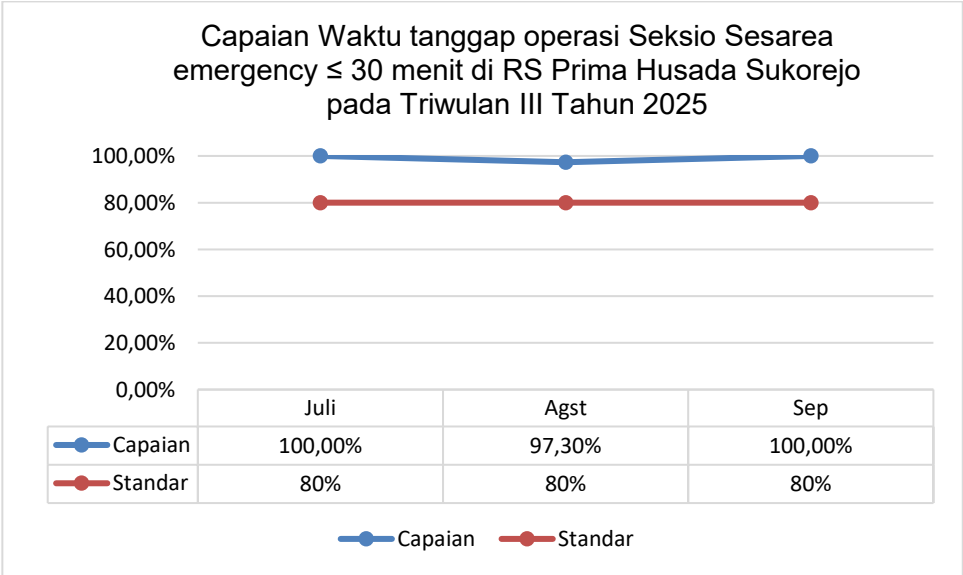
Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan III Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,68%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi. Akar Masalah yang teridentifikasi: 1. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP 2. Proses identifikasi tidak dilakukan menyeluruh (hanya tanya nama tanpa verifikasi gelang/etiket). 3. Tidak semua unit konsisten dalam pelaksanaan audit internal. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : a. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien b. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh c. Tindak lanjut hasil koordinasi untuk dilakukan pelatihan maupun refresh ulang SPO identifikasi pasien dengan PJ Tim SKP d. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi.
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan III tahun 2025 mencapai 99,68%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. How-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pendataan dan rekap nama-nama petugas yang tidak melakukan

	prosedur identifikasi pasien dengan benar selama proses observasi. 2. Menyusun jadwal koordinasi dengan masing-masing petugas yang teridentifikasi tidak patuh (Koordinasi dilakukan oleh kepala ruangan atau penanggung jawab mutu ruangan, secara individu atau kelompok kecil) 3. Tindak lanjut koordinasi dengan pelatihan dan refresh SPO dengan melibatkan Penanggung Jawab Tim Sasaran Keselamatan Pasien (PJ Tim SKP) 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
--	--

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rekap nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Mengidentifikasi petugas yang tidak menjalankan prosedur dengan benar	Petugas dari all unit pelayanan	Mengolah data observasi, membuat daftar nama & unit	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
2	Penjadwalan koordinasi dengan petugas tidak patuh	Melakukan pendekatan personal dan klarifikasi	Petugas yang terdata tidak patuh	Koordinasi secara individu atau kelompok kecil di ruangan masing - masing	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
3	Refresh training & pembahasan ulang SPO Identifikasi pasien	Memberikan pemahaman ulang terkait prosedur identifikasi dua langkah	Seluruh petugas di unit yang tidak patuh	Edukasi kelompok, diskusi SOP, simulasi sederhana	J Tim SKP, SDM Diklat, Kepala Ruangan	Satu bulan
4	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit

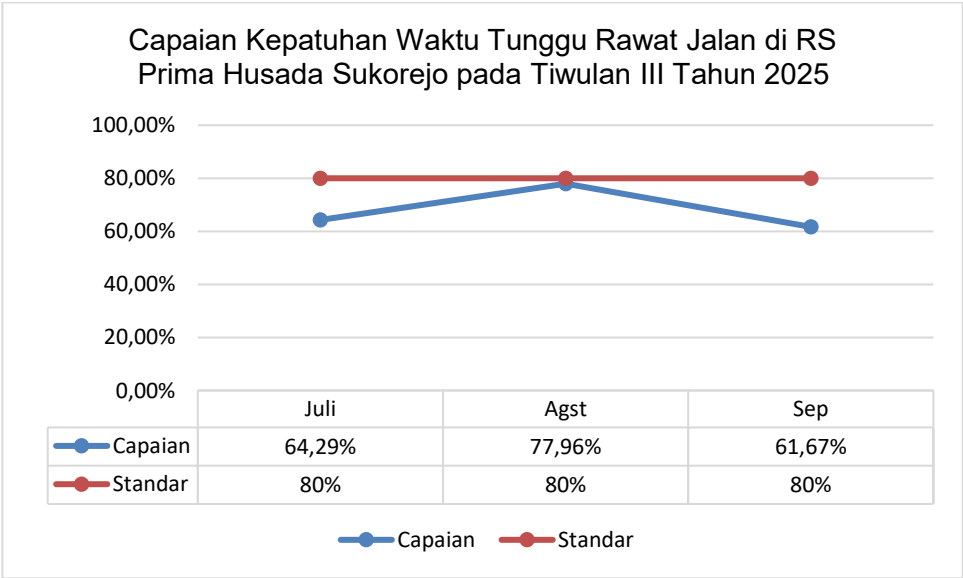


Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 99,10%. Dari 103 pasien yang diobservasi, 1 pasien yang mendapatakan pelayanan tanggap SC Emergency lebih dari 60 menit. Secara keseluruhan Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 67,97%. Capaian pada bulan September adalah yang **terendah** dari periode tiga bulan ini.

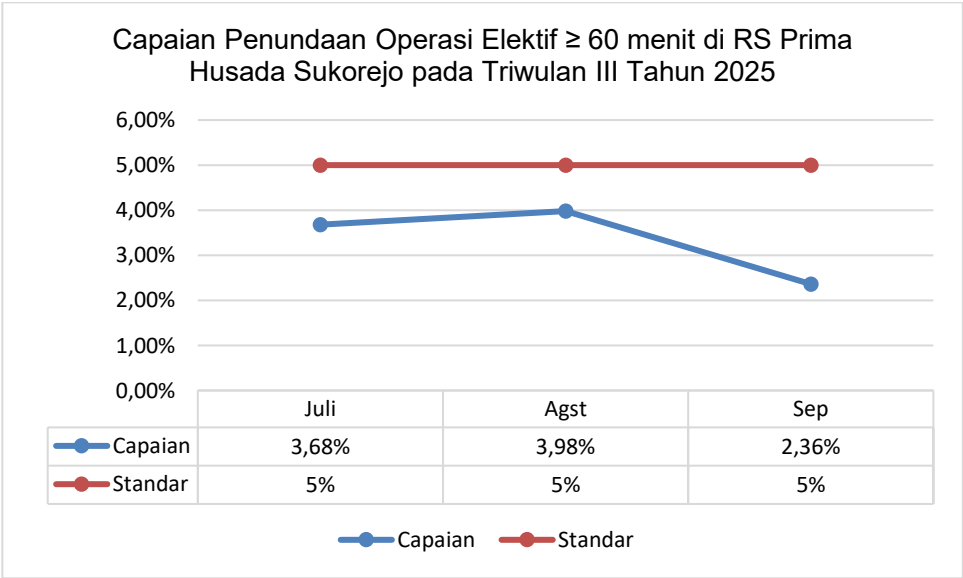
Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Triwulan III Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 67,97% dan belum mencapai target 80%. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan yakni 1 jam 7 menit melebihi standar maksimal 60 menit.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan
Plan	Masalah yang ditemukan : Rata-rata waktu tunggu rawat jalan masih tinggi, yakni 1 jam 7 menit, dengan tingkat kepatuhan terhadap standar waktu tunggu ≤ 60 menit hanya sebesar 67,97%. Tujuan : Meningkatkan persentase kepatuhan standar waktu tunggu ≤ 60 menit menjadi minimal 80% pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi: 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Memonitor waktu kedatangan dokter dan jumlah pasien menumpuk di awal waktu praktik. 2. Melakukan edukasi kepada seluruh petugas front office dan pendaftaran tentang pentingnya efisiensi waktu tunggu.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan Triwulan III yakni 67,97% belum mencapai ≥ 80%. 2. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 7 menit. Ini dikarenakan: a. Penumpukan Pasien di Awal Jam Poli b. Beberapa dokter spesialis tidak datang tepat waktu sesuai jadwal praktik yang telah ditentukan,
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan ≤60 menit yakni 67,97% belum mencapai ≥ 80%. Rata-rata keterlambatan terjadi dalam waktu 1 jam 7 menit. How-Up dan Rencana Lanjutan 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penjadwalan ulang atau pembagian tugas pasien di poli untuk DPJP	Meningkatkan pemerataan pasien per DPJP dan mengurangi waktu tunggu	Pasien rawat jalan di poli spesialis	- Review kuota pasien per DPJP - Penjadwalan slot waktu per dokter	Komite Medik, Koordinator Poli	Satu bulan
2	Monitoring kedatangan dokter dan evaluasi disiplin waktu praktik	Mengurangi waktu tunggu awal poli	Dokter Poli Rawat Jalan	Rapat koordinasi dengan Kabid Pelayanan & Komite Medik	Kabid Pelayanan & Komite Medik	Satu bulan
3	Edukasi pasien datang sesuai jadwal melalui call center/pendaftaran online	Meningkatkan kedisiplinan waktu kedatangan pasien sesuai slot waktu	Pasien rawat jalan	- Petugas call center memberi reminder jam kedatangan saat reservasi - Edukasi saat konfirmasi jadwal online	Pendaftaran & CSO	Satu bulan

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

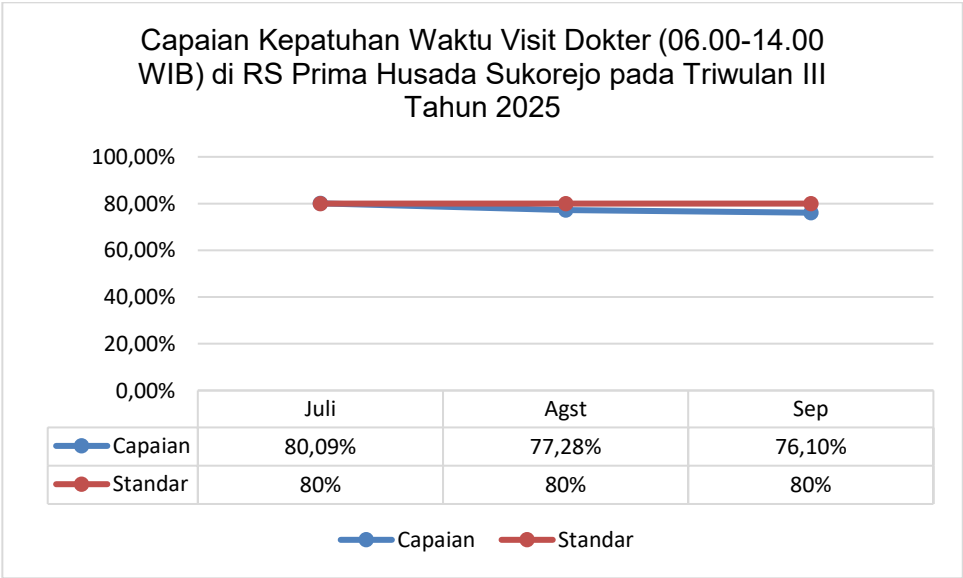


Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III tahun 2025 yakni 3,34%. Capaian ini sudah mencapai standar < 5 %.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≤ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 77,82% belum memenuhi standar minimal $\geq 80\%$. Capaian tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian dokter spesialis belum melaksanakan visite secara tepat waktu, sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Triwulan III Tahun 2025

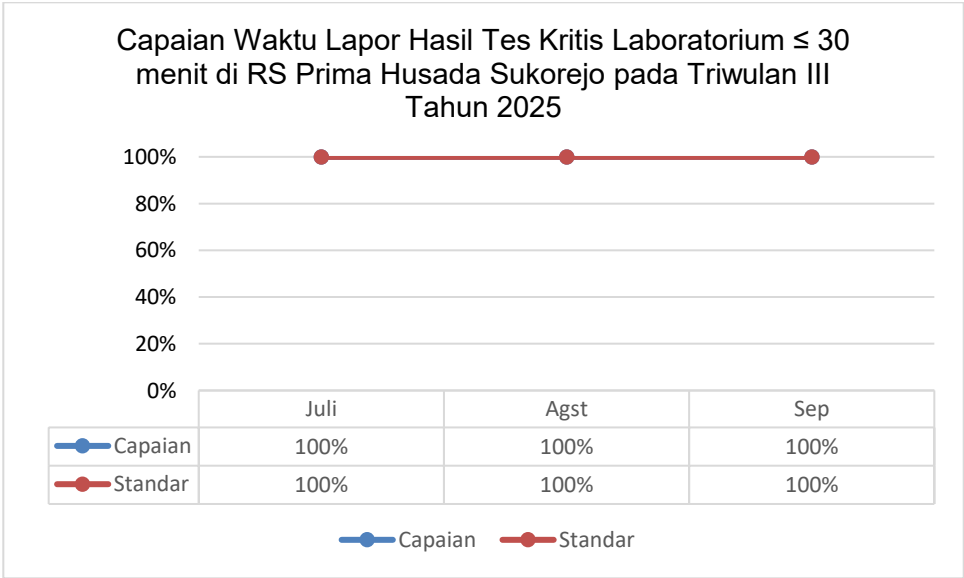
Problem	Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 77,82% belum mencapai standar 80%
Step	Analisa kepatuhan waktu visite dilakukan setiap bulan melalui monitoring dan rekap data visite dokter dari unit rawat inap, dengan membandingkan waktu kunjungan aktual terhadap waktu yang ditentukan
Plan	Identifikasi Masalah : - Beberapa dokter spesialis belum melaksanakan visite pasien tepat waktu sesuai jadwal kerja RS. - Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. - Terdapat dokter yang cuti, tapi digantikan oleh dokter jaga Tujuan : - Meningkatkan rata-rata kepatuhan visite minimal 80% Rencana Aksi: - Audit harian oleh kepala ruangan - Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter - Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). - Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? - Pelaksanaan Visit Rutin Sesuai Jam yang Ditentukan (Pagi $\leq$ 14.00 WIB) - Waktu visit dicatat dalam rekam medis dan checklist visit. - Dokumentasi kunjungan DPJP melalui tanda tangan/paraf di form visite sebagai bukti telah dilakukan.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 77,82% yang berarti telah memenuhi standar minimal $\geq 80\%$. Namun, sebagian dokter spesialis belum melaksanakan visite secara tepat waktu sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik. Ketidaktepatan waktu ini berisiko menyebabkan keterlambatan dalam: - Pengambilan keputusan medis - Pelaksanaan terapi - Perencanaan pemulangan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindak lanjut dan pengawasan rutin untuk meningkatkan mutu pelayanan medik

Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 77,82%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Flow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). 4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis
---------------	---

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit harian oleh kepala ruangan	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang datang ≥ 14.00	Rapat koordinasi dengan komite medik	Kepala Ruang	Satu bulan
2	Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Seluruh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di rumah sakit	Rapat Koordinasi dengan SDM	Komite Medik & SDM	Satu bulan
3	Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat)	Menjamin kontinuitas pelayanan medis melalui penggantian DPJP saat cuti	Dokter Penanggung jawab Pasien	Menetapkan DPJP pengganti resmi saat dokter cuti, dan mendokumentasikannya secara formal.	Kepala Bidang Pelayanan	Satu bulan
4	Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter spesialis pada pasien rawat inap khususnya pasien kritis di ICU melalui sistem koordinasi dan prioritasasi yang lebih baik.	Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan pasien kritis yang dirawat di ICU	• Menyusun daftar harian pasien kritis yang membutuhkan prioritas visite. • Melaksanakan koordinasi pagi antara perawat ICU dan DPJP sebelum jam visite	Kepala Ruang ICU, DPJP, Komite Medi	Satu bulan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 60 menit

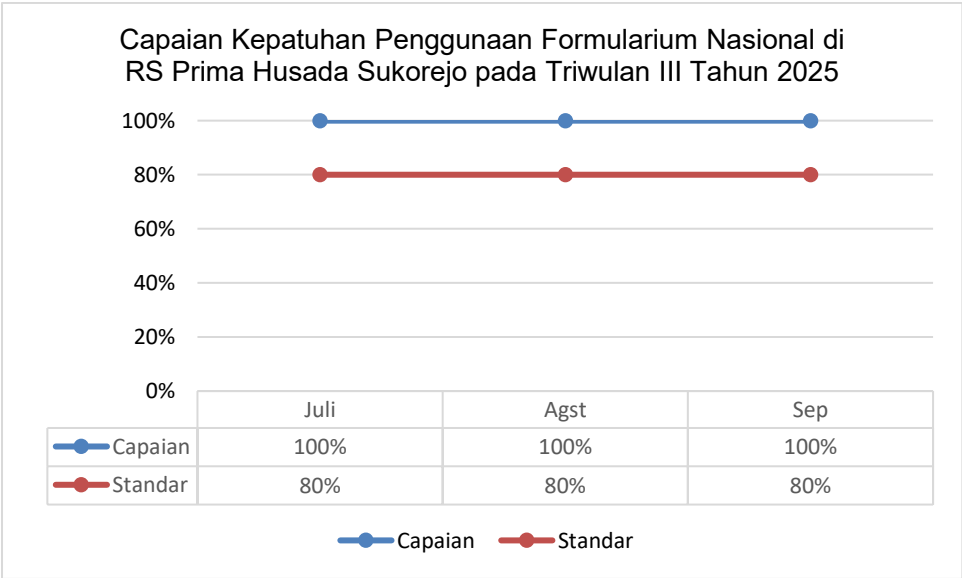


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan Triwulan III Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi, hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

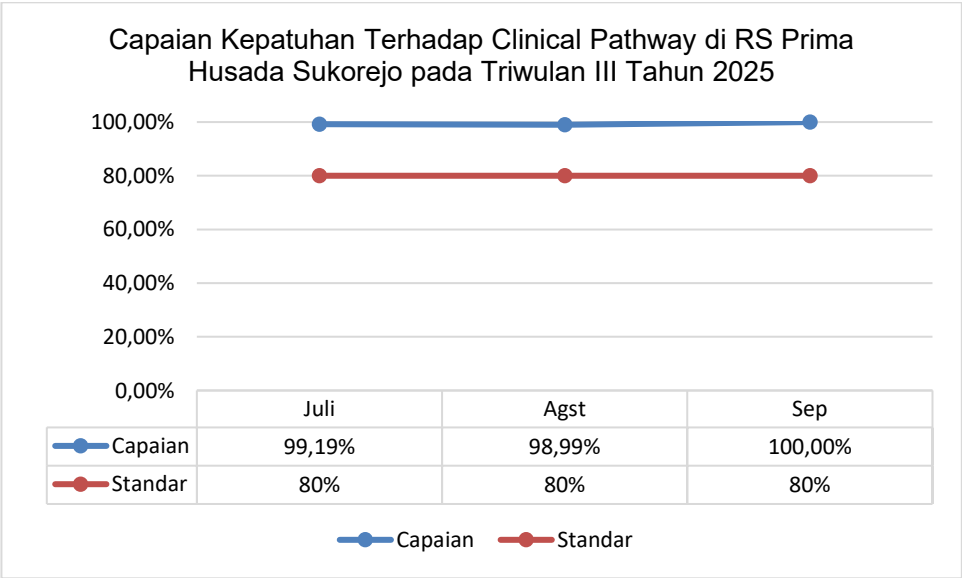


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan peresepan obat hanya dari Formularium Nasional.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

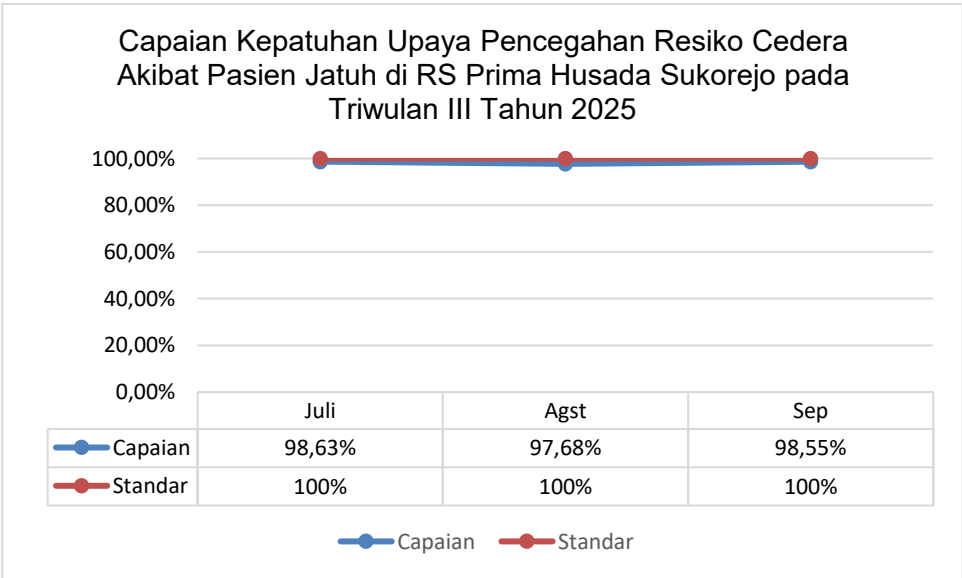


Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Triwulan III Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 99,39%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Triwulan III didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

11.Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan III tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan risiko jatuh
Plan	Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% 2. Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni dan Juli 2025, belum seluruh petugas melaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku. juan :

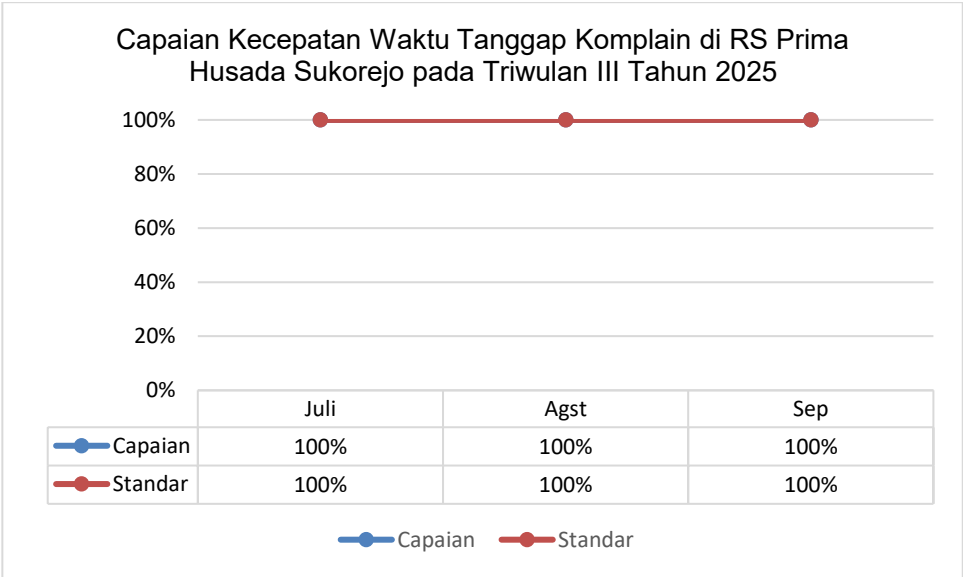
	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% 2. Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda). 3. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 4. Tidak terempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien 5. Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,29% llow-up dan Rencana Lanjutan 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP penanganan pasien risiko jatuh	Seluruh petugas di unit pelayanan yang menangani pasien risiko jatuh	Penguatan edukasi melalui briefing harian	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan
2	Memastikan hand rail terpasang di tempat tidur	Menjamin keamanan fisik pasien	Pasien risiko tinggi jatuh	• Ceklist ketersediaan hand rail per shift	Ka. Ruangan IPSRS	Satu Bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	pasien risiko jatuh			Koordinasi dengan bagian pemeliharaan		
3	Pengadaan dan penggunaan stiker serta penanda visual risiko jatuh	Meningkatkan kesadaran visual terhadap pasien berisiko	Petugas dan keluarga pasien	- Standarisasi label risiko jatuh - Distribusi ulang penanda ke tiap unit	Gudang Tim mutu	Satu Bulan
4	Audit rutin kepatuhan tindakan pencegahan risiko jatuh	Monitoring implementasi di lapangan	Setiap unit rawat inap	Observasi lapangan	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan
5	Pemberian umpan balik langsung	Meningkatkan perbaikan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh	- Laporan hasil audit dibagikan tiap unit - Tindak lanjut individu	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

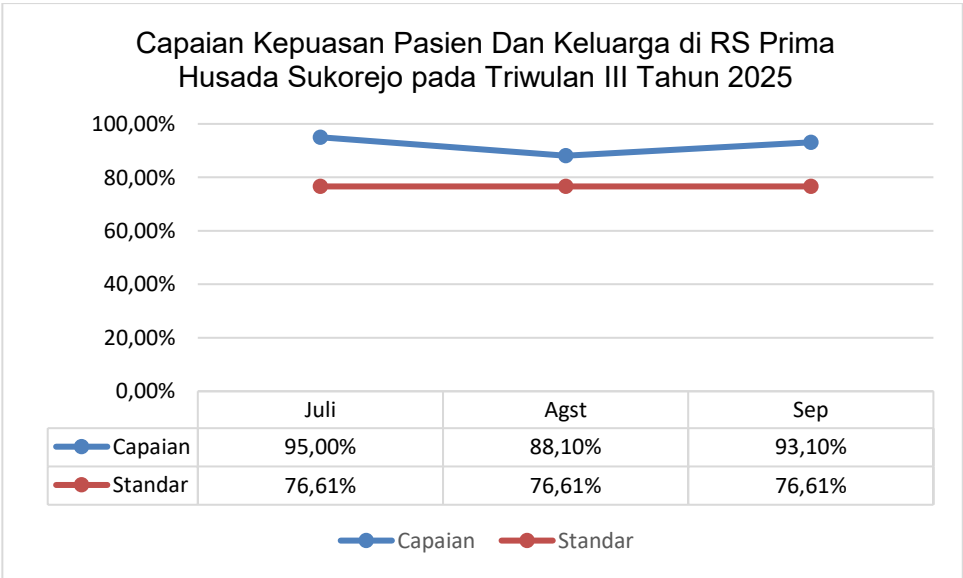


Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 92,07%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit
Tabel 3.15 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			Juli	Agustus	Septem ber			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar: a. Kepatuhan Identifikasi pasien	99,80%	99,56%	99,68%	100%	99,68%	PDSA
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	97,05%	97,82%	98,35%	100%	97,74%	PDSA
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (<i>High Alert Medications</i>): a. Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada Obat Sisa Anestesi
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		b. Kejadian tidak dilakukannya	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

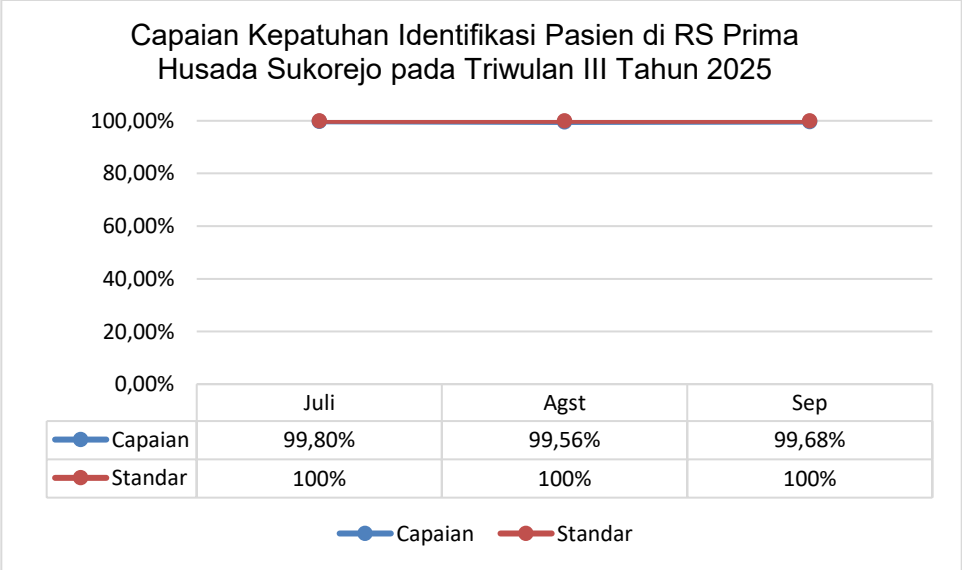
No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			Juli	Agustus	September			
		penandaan						
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: a. Kepatuhan Kebersihan Tangan	76,39%	75,98%	74,81%	100%	75,73%	PDSA
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan risiko pasien jatuh	98,63%	97,68%	98,55%	100%	98,29%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1. Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		2. Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		3. Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		Belum diisi
		4. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		Belum diisi
		5. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		Dipertahankan

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			Juli	Agustus	September			
		6. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
		7. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				≥ 70%		Belum diisi
		8. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		Belum diisi
		9. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		Belum diisi
		10. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		Belum diisi
3	Renstra RS	1. Kepuasan pasien	95,00%	88,10%	93,10%	≥ 76,61 %	92,07%	Dipertahankan
4	Perbaikan Sistem	1. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
		2. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		3. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Manajemen Resiko	1. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
		2. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

1. Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

a. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III 2025 mencapai 99,68%. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan III Tahun 2025

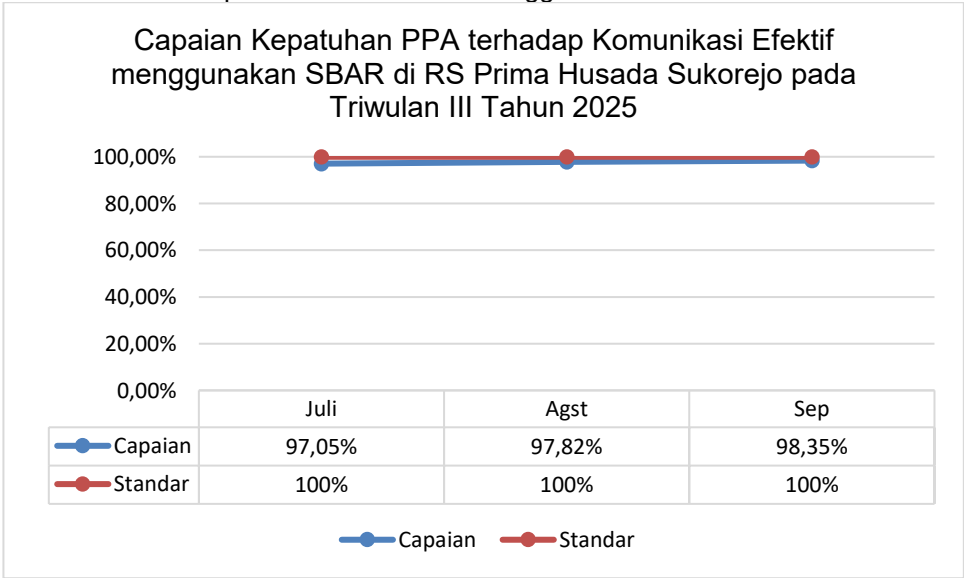
Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan III Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,68%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi. Akar Masalah yang teridentifikasi: - Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP - Proses identifikasi tidak dilakukan menyeluruh (hanya tanya nama tanpa verifikasi gelang/etiket). - Tidak semua unit konsisten dalam pelaksanaan audit internal. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : - Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien - Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh - Tindak lanjut hasil koordinasi untuk dilakukan pelatihan maupun refresh ulang SPO identifikasi pasien dengan PJ Tim SKP - Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Do	- Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien - Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh - Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). - Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi.
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan III tahun 2025

	mencapai 99,68%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Flow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pendataan dan rekap nama-nama petugas yang tidak melakukan prosedur identifikasi pasien dengan benar selama proses observasi. 2. Menyusun jadwal koordinasi dengan masing-masing petugas yang teridentifikasi tidak patuh (Koordinasi dilakukan oleh kepala ruangan atau penanggung jawab mutu ruangan, secara individu atau kelompok kecil) 3. Tindak lanjut koordinasi dengan pelatihan dan refresh SPO dengan melibatkan Penanggung Jawab Tim Sasaran Keselamatan Pasien (PJ Tim SKP) 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
--	---

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rekap nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Mengidentifikasi petugas yang tidak menjalankan prosedur dengan benar	Petugas dari all unit pelayanan	Mengolah data observasi, membuat daftar nama & unit	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
2	Penjadwalan koordinasi dengan petugas tidak patuh	Melakukan pendekatan personal dan klarifikasi	Petugas yang terdata tidak patuh	Koordinasi secara individu atau kelompok kecil di ruangan masing - masing	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
3	Refresh training & pembahasan ulang SPO Identifikasi pasien	Memberikan pemahaman ulang terkait prosedur identifikasi dua langkah	Seluruh petugas di unit yang tidak patuh	Edukasi kelompok, diskusi SOP, simulasi sederhana	J Tim SKP, SDM Diklat, Kepala Ruangan	Satu bulan
4	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 97,74%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100% Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Triwulan III Tahun 2025

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 97,74%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Identifikasi Masalah: Tingkat kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) terhadap penggunaan komunikasi efektif dengan format SBAR belum mencapai standar 100%. Hasil monitoring menunjukkan adanya variasi dalam penerapan, terutama pada bagian <i>Assessment</i> dan <i>Recommendation</i>, yang sering tidak lengkap atau tidak sesuai format. 2. Tujuan: Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap penggunaan komunikasi SBAR hingga mencapai 100% pada seluruh unit pelayanan, khususnya pada proses serah terima pasien dan komunikasi antar-profesi 3. Rencana Aksi: - Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. - Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. - Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. - Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Pengisian SBAR oleh petugas - Kepala Unit Rawat Inap melaksanakan monitoring harian terhadap dokumentasi SBAR, terutama pada saat serah terima pasien dan komunikasi antar-shift. - Tim Mutu juga membagikan formulir observasi SBAR untuk membantu mempermudah penilaian kepatuhan.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? - Rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada bulan Triwulan III Tahun 2025 yakni 97,74%. - Adapun temuan bagian yang tidak lengkap yakni : - Bagian TTD Pemberi pesan - Bagian TTD penerima pesan - Ini disebabkan karena: - SBAR disiapkan setelah tindakan dilakukan bukan sebelum komunikasi klinis - Petugas tidak memahami pentingnya informasi klinis pasien secara menyeluruh - Kelalaian teknis
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Triwulan III Tahun 2025 yakni 97,74%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100% Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR. llow-up dan Rencana Lanjutan - Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. - Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. - Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. - Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap

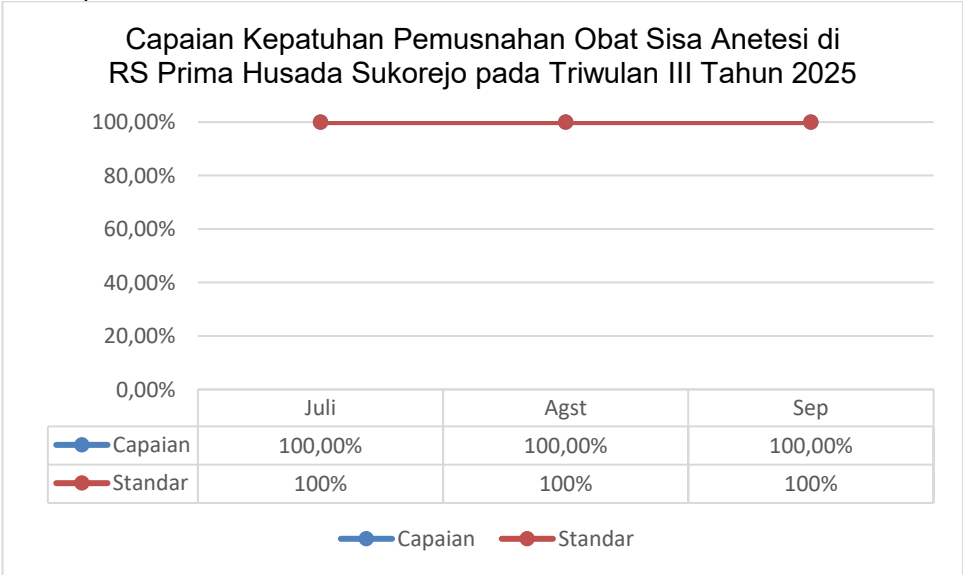
Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervisi Pelaksanaan Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya.	Supervisi, pemberian umpan balik langsung dan edukasi singkat kepada petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	PKRS, Tim SKP, dan Tim Mutu	1 minggu
2	Monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya	Monitoring dan evaluasi petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	Kepala Ruangan	1 bulan
3	Penyediaan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi SBAR melalui akses mudah terhadap contoh-contoh praktik baik (best practice) yang tersedia secara digital.	Seluruh PPA (perawat, bidan, tenaga medis) di seluruh unit pelayanan, khususnya yang melakukan serah terima pasien, komunikasi antar shift, dan komunikasi antar profesi.	Menyusun beberapa contoh SBAR yang baik dan lengkap yakni dalam bentuk dokumentasi tertulis	Tim SKP, PKRS	1 bulan
4	Feedback langsung kepada staf yang mengisi dengan lengkap	Memberikan pembinaan dan perbaikan langsung kepada tenaga kesehatan yang tidak mengisi form SBAR secara lengkap	Seluruh tenaga kesehatan (perawat, bidan, atau tenaga lainnya) yang form SBAR tidak lengkap dan pengisian SBAR tetapi tidak terdokumentasi dengan benar	4. Menunjukkan bagian yang tidak terisi dan jelaskan dampaknya terhadap keselamatan pasien. 5. Berikan contoh pengisian yang benar dan arahkan	Tim SKP, PKRS	1 bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
				untuk perbaikan ke depan		

c. Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi

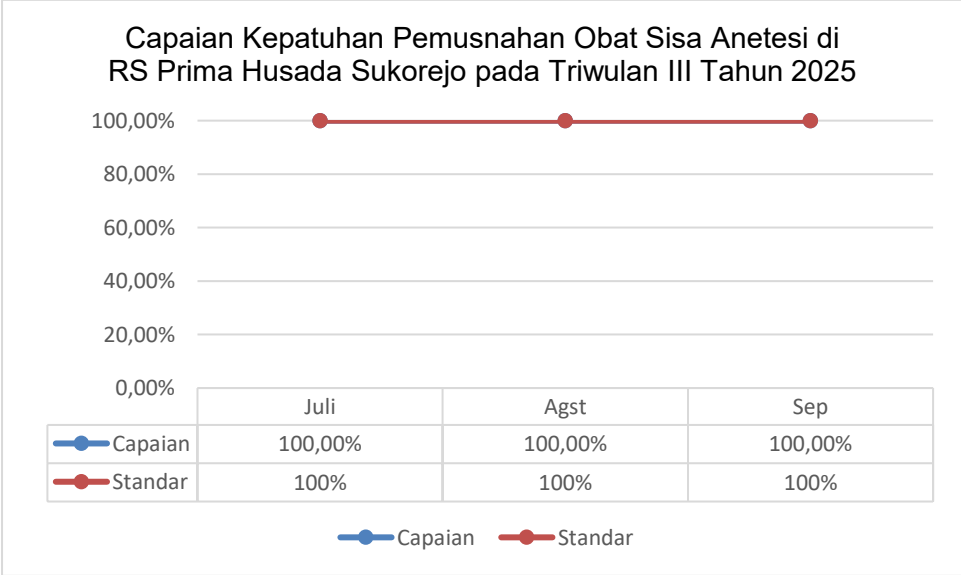


Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pemusnahan obat sisa anestesi di rumah sakit sudah berjalan sesuai prosedur, dan kontrol terhadap risiko penyalahgunaan obat-obatan anestesi sudah diterapkan secara maksimal.

d. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist

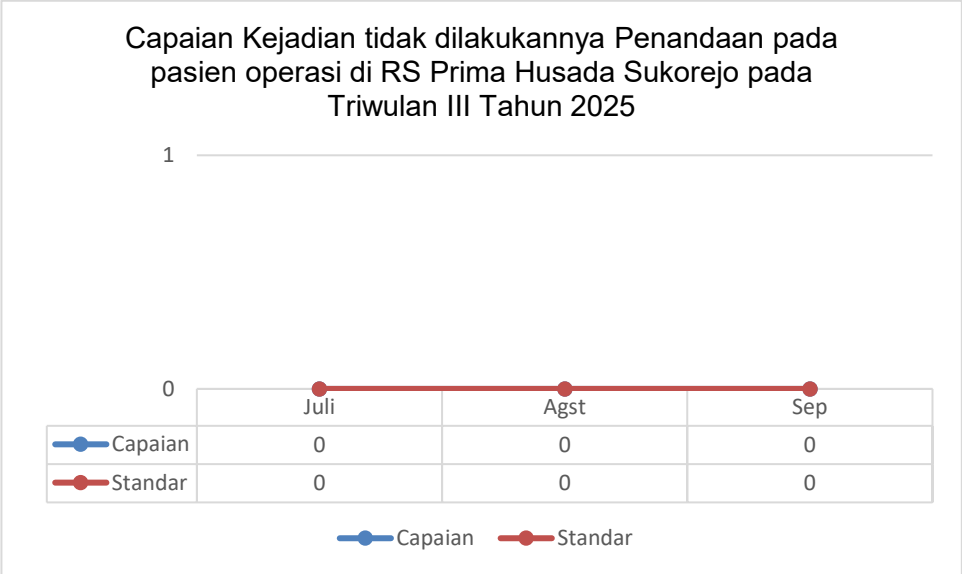


Gambar 3.18. Capaian Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Sfety Checklist di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Kepatuhan pelaksanaan Surgical Safety Checklist (SSC) mencapai angka 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur keselamatan pasien pra, saat, dan pasca operasi telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai standar WHO.

e. Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi

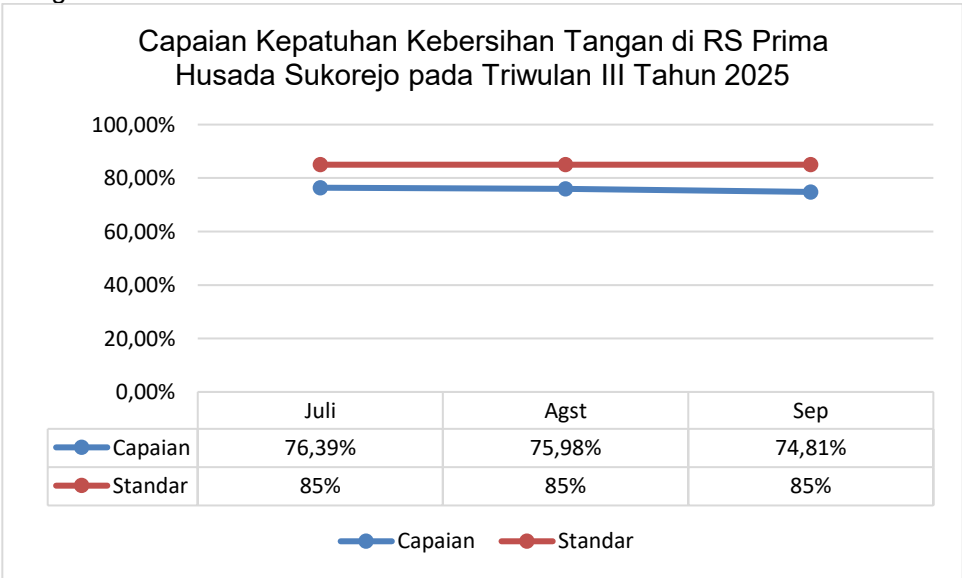


Gambar 3.19. Capaian Kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai target 0 kejadian. Angka kejadian tercatat nol (0) dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

f. Kebersihan Tangan



Gambar 3.20. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan III yakni mencapai 75,73%. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu

≥85%. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan III Tahun 2025

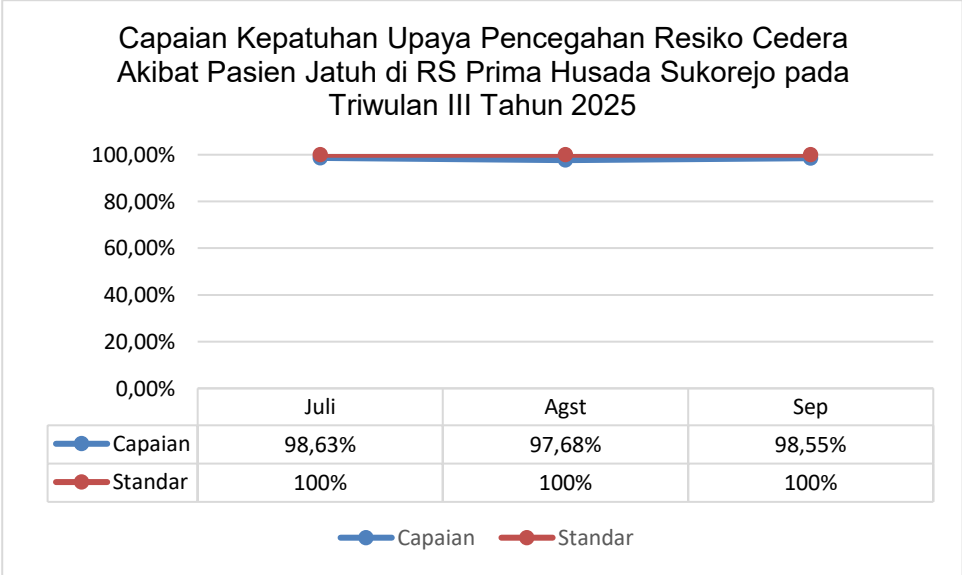
Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Bulan Triwulan III 2025 hanya mencapai 75,73%, belum mencapai target ≥85%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: a. Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target ≥85%, dengan rata-rata kepatuhan bulan Triwulan III 2025 sebesar 75,73%. b. Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. c. Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. 2. Tujuan: a. Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan ≥85% secara konsisten selama Triwulan III (Juli – September 2025). b. Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan 3. Rencana Aksi: a. Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). b. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. c. Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	1. IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu 2. Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. 3. Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	1. Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan III 2025 yaitu 75,73% 2. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan tertinggi yakni unit Farmasi sebesar 100% 3. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 85,19% walaupun belum mencapai standar 4. Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 <i>Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO 5. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan a) Sebelum kontak dengan pasien sebesar 58,43% b) Sebelum Tindakan aseptik sebesar 65,98% c) Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 67% d) Setelah kontak dengan pasien sebesar 66,10% e) Setelah dari lingkungan pasien sebesar 67,23%

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
-----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	--------

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan bedside coaching	Mengetahui secara langsung tingkat kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Observasi langsung oleh IPCN/IPCLN - Feedback real-time di tempat - Dokumentasi hasil audit untuk evaluasi	IPCN/IPCLN	1 kali/minggu/unit (Triwulan III–Sept 2025)
2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung - Melaporkan kepatuhan tim tiap minggu ke manajemen	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang memiliki tingkat kepatuhan terbaik	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif terhadap kepatuhan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	Penilaian berdasarkan hasil audit IPC - Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan tiap akhir bulan (Triwulan III–Des 2025)

g. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar 3.21. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan III tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Tabel 3.20 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

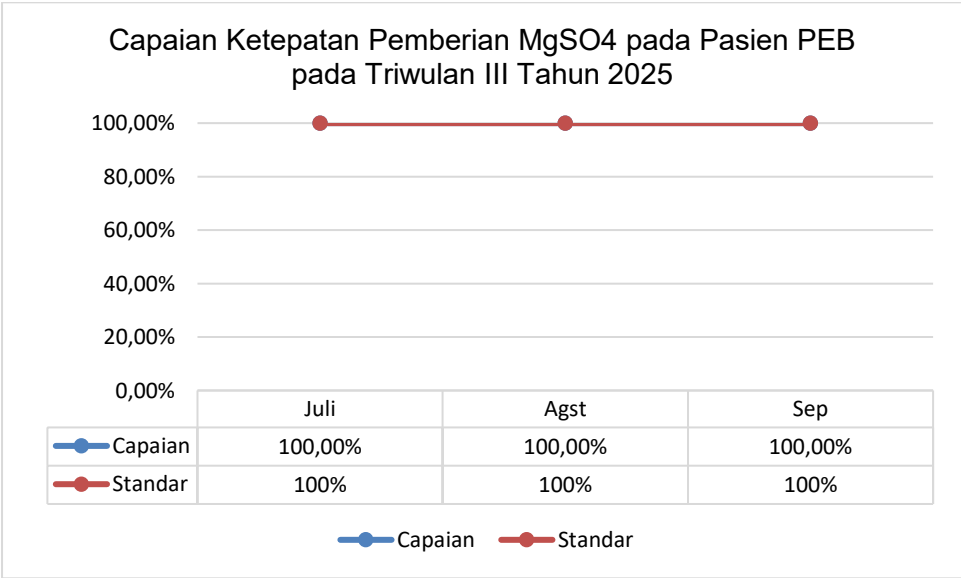
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% 2. Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni dan Juli 2025, belum seluruh petugas melaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku. juan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% 2. Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda). 3. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 4. Tidak terempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien 5. Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? ta-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,29% llow-up dan Rencana Lanjutan 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP penanganan pasien risiko jatuh	Seluruh petugas di unit pelayanan yang menangani pasien risiko jatuh	Penguatan edukasi melalui briefing harian	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan
2	Memastikan hand rail terpasang di tempat tidur pasien risiko jatuh	Menjamin keamanan fisik pasien	Pasien risiko tinggi jatuh	- Ceklist ketersediaan hand rail per shift - Koordinasi dengan bagian pemeliharaan	Ka. Ruangan IPSRS	Satu Bulan
3	Pengadaan dan penggunaan stiker serta penanda visual risiko jatuh	Meningkatkan kesadaran visual terhadap pasien berisiko	Petugas dan keluarga pasien	- Standarisasi label risiko jatuh - Distribusi ulang penanda ke tiap unit	Gudang Tim mutu	Satu Bulan
4	Audit rutin kepatuhan tindakan pencegahan risiko jatuh	Monitoring implementasi di lapangan	Setiap unit rawat inap	Observasi lapangan	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan
5	Pemberian umpan balik langsung	Meningkatkan perbaikan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh	- Laporan hasil audit dibagikan tiap unit - Tindak lanjut individu	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan

2. Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas

a. Ketepatan Pemberian MgSO₄ pada Pasien PEB

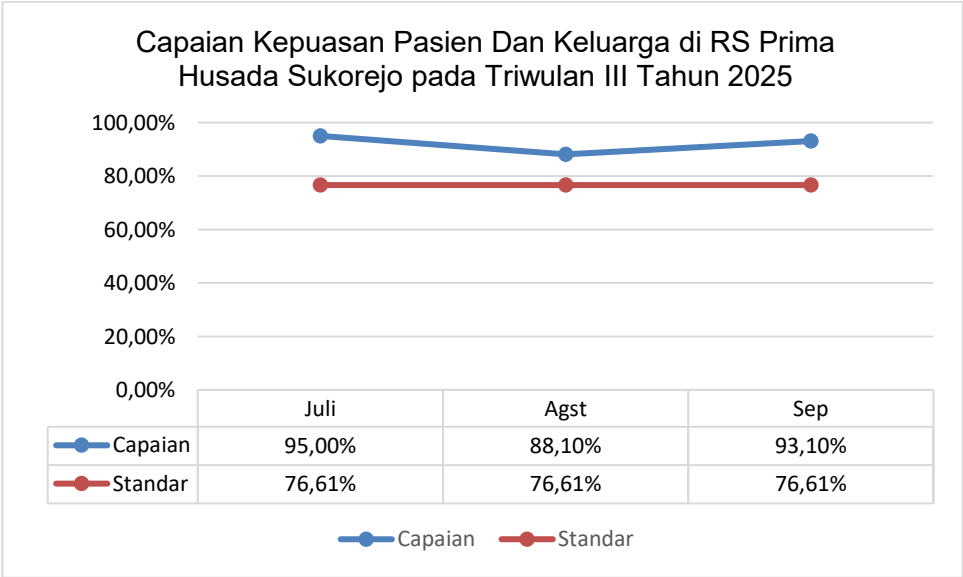


Gambar 3.22. Capaian Ketepatan Pemberian MgSO₄ pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pemberian MgSO₄ pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 yakni mencapai 100%.

- b. Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS
 - c. Pasien dengan Dengue yang Mendapatkan Pemantauan dan Intervensi Tepat Waktu untuk Mencegah Komplikasi Berat (Seperti Shock atau Perdarahan) dalam 24 Jam Pertama Setelah Diagnosis
 - d. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium
 - e. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan
 - f. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol
 - g. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%
 - h. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)
 - i. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor
 - j. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis
3. Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis RS
- a. Kepuasan Pasien

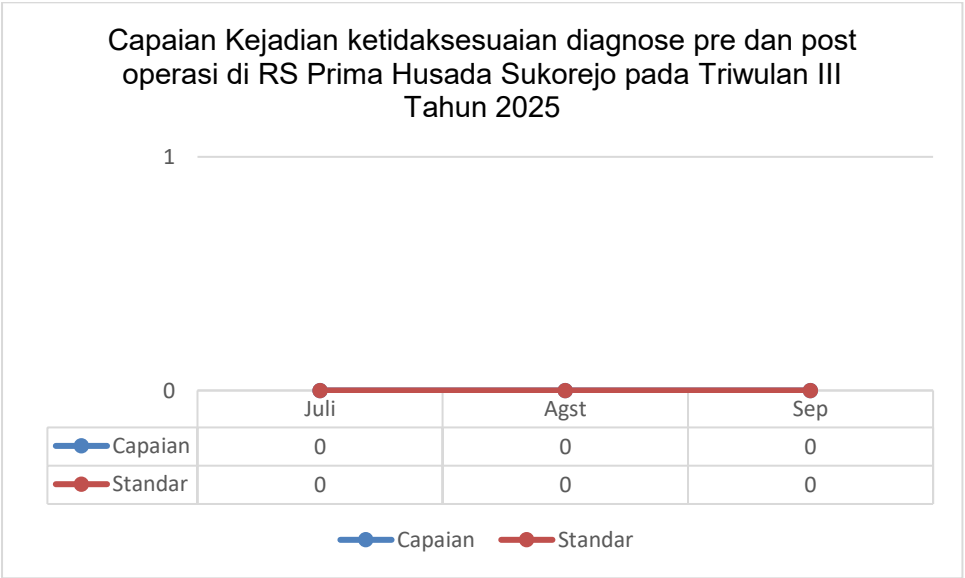


Gambar 3.23. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 92,07%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

4. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem
- a. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi

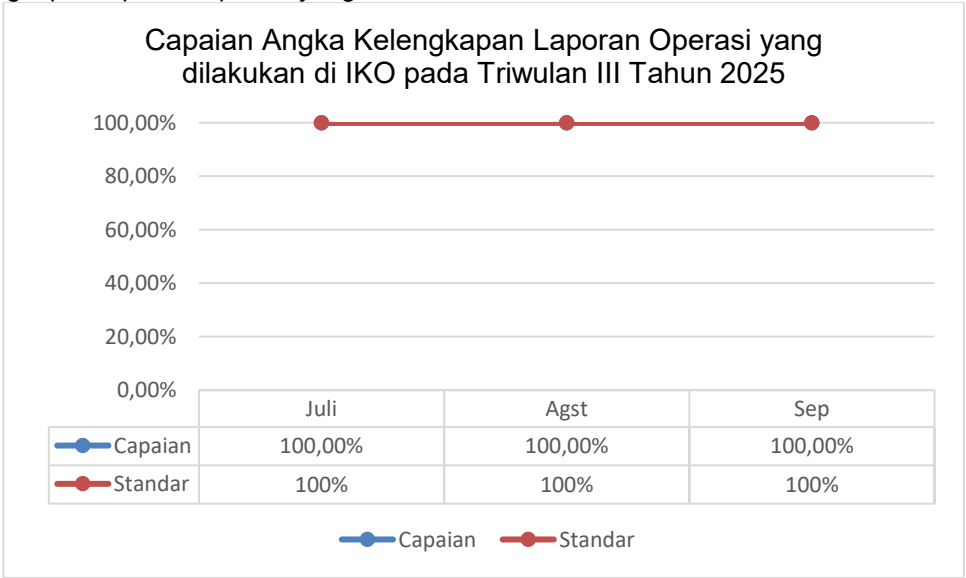


Gambar 3.33. Capaian Kejadian Ketidaksesuaian Diagnosa Pre dan Post Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Triwulan III Tahun 2025 capaian kejadian ketidaksesuaian diagnose pre & post operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Angka tersebut sudah mencapai target 0 kejadian.

b. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO

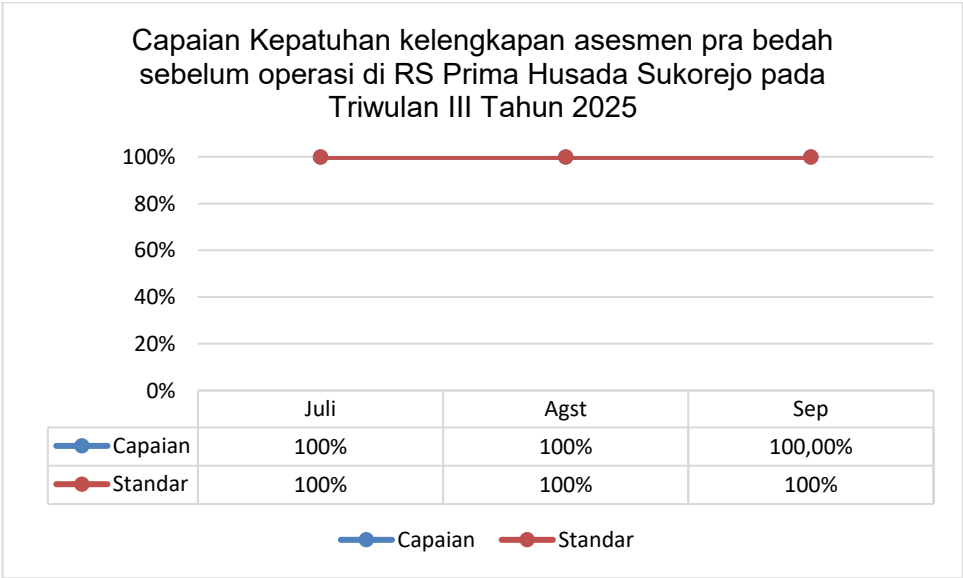


Gambar 3.34. Capaian Angka Kelengkapan Laporan Operasi yang dilakukan di IKO di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100% sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi

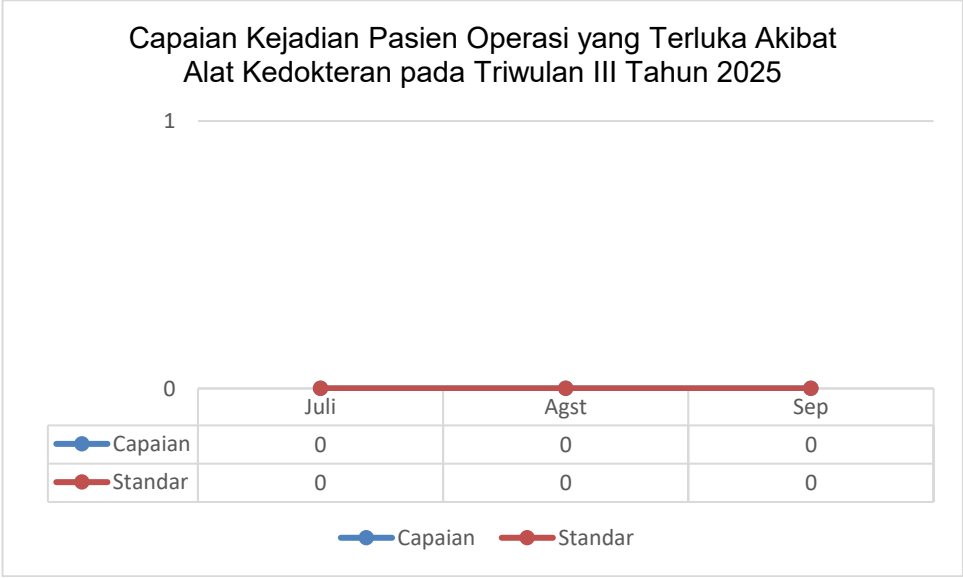


Gambar 3.35. Capaian Kepatuhan Kelengkapan Asesmen Pra Bedah Sebelum Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa prosedur asesmen pra bedah sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin yang terstandarisasi di ruang tindakan/pre-operatif.

- 5. Analisis Capaian Indikator Manajemen Resiko
 - a. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran

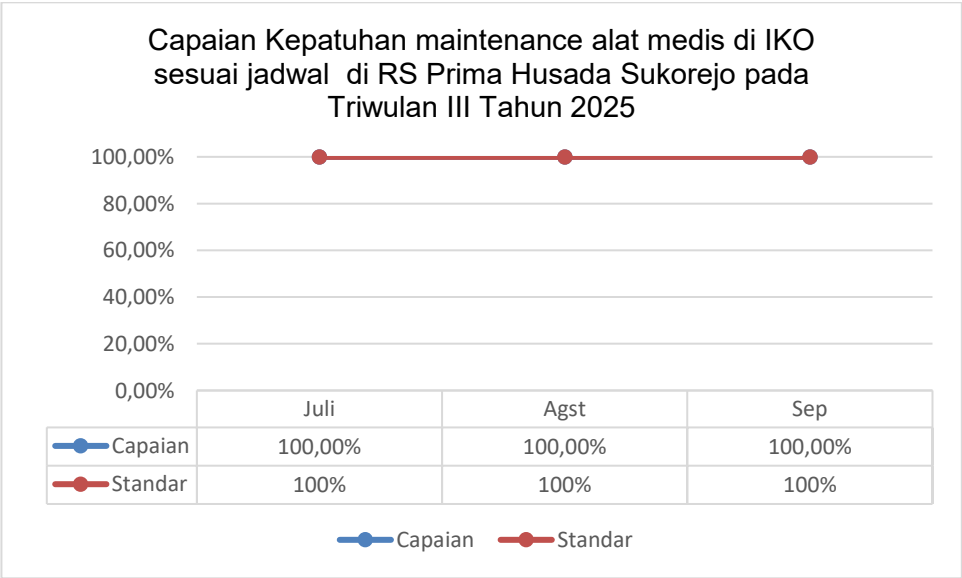


Gambar 3.36. Capaian Kejadian Pasien Operasi yang Terluka Akibat Alat Kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Pada bulan Maret 2025, telah dilakukan pergantian alat kedokteran, khususnya harum pen. Dampak positifnya pada Triwulan III Tahun 2025 yakni menurunnya risiko cedera pada pasien operasi, dan meningkatkan kinerja tim bedah dan sterilisasi karena alat sudah memenuhi standar.

- b. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal



Gambar 3.37. Capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Angka tersebut sudah mencapai target 100%. Kepatuhan 100% selama tiga bulan berturut-turut menunjukkan bahwa program maintenance alat medis di IKO berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal. Tidak ditemukan keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan preventive maintenance maupun kalibrasi alat-alat kritis

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.16 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Triwulan III Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			tandar	ata-rata	Keterangan
		Juli	gustus	eptember			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	93,55%	95,48%	100%	96,34%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	7,80%	71,43%	75%	≥ 85 %	78,08%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	100%	97,62%	94,74%	≥ 76,61 %	97,45%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	88%	100%	96,00%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	8,06%	95,48%	88,39%	100%	93.98%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anastesi	-	-	-	100%		Tidak ada obat sisa anastesi yang dimusnahkan
3	Pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Instalasi Gawat Darurat <5 menit setelah pasien datang	100%	95,48%	96,77%	100%	97,42%	PDSA
2	Kematian pasien< 24 (pindah ke	11/1000	7/1000	13/1000	≤ dua per seribu	11/1000	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan			standar	rata-rata	Keterangan
		Juli	agustus	eptember			
	elayanan rawat inap setelah 8 jam)						
3	engkanan pengisian pengkajian medis E-Rm.	9,03%	87,10%	88,39%	100%	88,17%	PDSA
4	engkanan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm.	8,06%	96,13%	97,86%	100%	93,55%	PDSA
5	engkanan pengisian LOP	8,39%	96,77%	85,81%	100%	90,32%	PDSA
6	engkanan berkas triage E-RM pada pasien IGD	100%	74,19%	90,32%	100%	88,17%	Dipertahankan
7	aktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit	3,55%	66,45%	90,32%	100%	83,44%	PDSA
8	pon time pengantaran pasien P2 & P3 ke Rawat Inap < 3 jam	100%	100%	90,32%	100%	96,78%	Dipertahankan

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 3.22 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	100%	100,00%	100%	100,00%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	71,83%	0%	0%	≥ 85 %	23,94%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	76,92%	73,33%	100%	75,13%	PDSA
4	Kepuasan pasien	-	-	-	≥ 76,61%		PDSA
5	Waktu tunggu rawat jalan	64,29%	58,46%	60,81%	≥ 80%	61,19%	PDSA
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	0%	0%	100%	33,33%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		Belum diisi
2	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
3	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				≥ 70%		Belum diisi
4	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		Dipertahankan

5	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		Belum diisi
6	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan ≥ 30 menit	-	41,72%	31,25%	0%	36,49%	PDSA
2.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal medis E-RM pasien rawat jalan	-	100%	100,00%	100%	100,00%	Dipertahankan
3.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan E-RM pasien rawat jalan	-	76,92%	100,00%	100%	88,46%	PDSA
4.	Kelengkapan Form E-RM PRMRJ Pasien	-	-	100,00%	100%	100,00%	Belum diisi

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.36 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	95,38%	96,00%	79,17%	100%	90,18%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	52,50%	69,68%	73,11%	≥ 85 %	65,10%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,92%	96,00%	96,67%	100%	96,53%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	-	91,67%	≥ 76,61 %	95,84%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	79,23%	80,80%	81,67%	≥ 80%	80,57%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,14%	73,33%	91,67%	100%	87,38%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	96,30%	94,94%	96,43%	100%	95,89%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	-		100%	100%	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam				≥ 90%		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	24 jam pertama setelah diagnosis.						
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	25%	17,65%	18,18%	≥ 70%	20,28%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,60%	2,65%	1,54%	≤ 0,24 %	1,93%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	7 kejadian	4 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	5 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	3 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	96,15%	96,00%	95,83%	100%	95,99%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	96%	96,80%	96,67%	100%	96,49	PDSA

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71%	100%	100,00%	100%	99,57%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	58,93%	69,60%	71,21%	≥ 85 %	66,58%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,13%	96,13%	93,55%	100%	95,27%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	80%	100%	≥ 76,61 %	93,33%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	76,77%	64,52%	68,39%	≥ 80%	69,89%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	81%	71,11%	72%	100%	74,70%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	93,55%	100%	96,77%	100%	96,77%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi		-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.			0,65%	≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	0%	0%	9,09%	≥ 70%	3,03%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi				≥ 90 %		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor						
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,73%	0,27%	0,82%	≤ 0,24 %	0,61%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	87,10%	100%	96,77%	100%	94,62%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	90,32%	88,39%	92,67%	100%	90,46%	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71%	98,71%	98,67%	100%	98,70%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	76,47%	69,23%	75,93%	≥ 85 %	73,88%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	97,42%	98,06%	98,00%	100%	97,83%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	88,89%	88,89%	≥ 76,61 %	92,59%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	85,81%	83,87%	82,00%	≥ 80%	83,89%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-		≥ 80%		Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	69,23%	77,27%	96,30%	100%	80,93%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	97,42%	98,06%	98,67%	100%	98,05%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang				≥ 95%		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium						
5	Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				≥ 70%		
7	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
8	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
9	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,32%	0%	0,65%	≤ 0.24 %	0,32%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	98,06%	98,06%	98,00%	100%	98,04%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.66 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,35%	96,13%	96,00%	100%	97,60%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	74,29%	69,52%	97,16%	≥ 85 %	71,62%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,77%	92,90%	94,19%	100%	95,00%	PDSA
4	Kepuasan pasien	85,71%	90,48%	83,33%	≥ 76,61 %	87,90%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	61,29%	58,06%	58,06%	≥ 80%	57,56%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)				≥ 80%		Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	76,79%	89,74%	61,90%	100%	88,84%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	93,55%	94,19%	92,90%	100%	93,69%	PDSA
2	Kepatuhan	-	-		100%		Tidak ada obat

	pemusnahan obat sisa anestesi						sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	12,50%	1,94%	0,65%	≥ 70%	5,03%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,63%	0,36%	0%	≤ 0.24 %	0,33%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	1 kejadian	5 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	82,58%	87,10%	94,84%	100%	88,17%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	97,42%	98,06%	96,67%	100%	97,38%	PDSA

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.80 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,85%	100%	99,80%	100%	99,88%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	92,00%	71,43%	≥ 85 %	81,72%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	3,68%	3,98%	2,36%	≤ 5%	3,34%	Dipertahankan
5	Kepuasan pasien	100%	-		≥ 76,61 %		Dipertahankan
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB				100%		Tidak ada pemberian MgSO4 di Ruang IKO
4	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		Dipertahankan
5	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7	Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan pembersihan ruang IKO antar jeda waktu operasi (30 menit)				100%		Belum diisi
2.	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari				100%		Belum diisi
3.	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
5.	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7.	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel 3.81 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada sisa obat anestesi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian reaksi anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian salah penempatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka efek samping selama sedasi moderat	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0%	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

8. MATERNITAS

Tabel 3.82 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	97,95%	96,09%	96,13%	100%	96,72%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	85,19%	73,91%	80,00%	≥ 85 %	79,70%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	100%	92,31%	100%	> 80%	97,44%	Dipertahankan
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	93,50%	95,15%	93,50%	≥ 80%	94,05%	Dipertahankan
7	Kepatuhan terhadap	99,19%	98,99%	100%	≥ 80%	99,39%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	alur klinis (clinical pathway)						
8	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO4 pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian pasien dengan kasus Preeklamsi berat aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kepatuhan Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala III segera setelah bayi lahir	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian korioamnionitis pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini prematur	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kepatuhan pemberian antibiotika profilaksis sebelum operasi SC < 1 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
13	Kepatuhan Pemeriksaan DJJ saat kala II	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

Tabel 3.86 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juni	Juli	Agustus			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	100%	100%	100%	> 80%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	≥ 76,61 %	-	Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	98,28%	100%	99,43%	dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	-	-	-	100%	-	Tidak ada pasien HPP di Ponek
2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh Tim ponek yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
3	Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.87 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	87,10%	91,30%	84,31%	≥ 85%	87,57%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	92,08%	97,65%	84,54%	≥ 80%	91,42%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%		Tidak ada pa dengan Diagn tunggal
7	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	≥ 76,61%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	8 kejadian	7 kejadian	12 kejadian	0 kejadian	9 kejadian	PDSA

2	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500- 2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	2 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
7	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

11. ICU

A. ICU

Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	96,55%	100%	98,85%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	81,82%	90,91%	83,33%	≥ 85%	85,35%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	76,00%	75,00%	37,93%	≥ 80%	62,98%	PDSA
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	0%	100%	100%	66,67%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol	-	-	-	≥ 95%	-	Tidak ada pasien ca mammae
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	1,96%	0%	0%	≤ 3 %	0,65%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

B. ICU ISOLASI

Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU Isolasi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	-	-	100%		Tidak Ada Pa ICU Isolasi
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	-	-	≥ 85%		Tidak Ada Pa ICU Isolasi
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	-	-	100%		Tidak Ada Pa ICU Isolasi
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	-	-	-	≥ 80%		Tidak Ada Pa ICU Isolasi
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	-	-	100%		Tidak Ada Pa ICU Isolasi
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS	-	-	-	100%		Tidak Ada Pa ICU Isolasi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Waktu Pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)	-	-	-	≥ 80%		Tidak Ada Pa ICU Isolasi
2.	Kepatuhan Pembersihan dan desinfeksi ruangan	-	-	-	≥ 95%		Tidak Ada Pa ICU Isolasi

12.RADIOLOGI

Tabel 3.94 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	-	75%	≥ 85%	75%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	99,35%	-	96,77%	100%	98,96%	PDSA
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri		0%	-	100%	-	PDSA
5	Kepuasan pasien				≥ 76,61%		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	95,48%	54,19%	96,77%	100%	82,15%	PDSA
2.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	0%	45,81%	12,00%	0%	19,27%	PDSA
3.	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	0,65%	52,90%	45,33%	0%	32,96%	PDSA
4.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	0 kejadian	155 kejadian	20 kejadian	0 kejadian	58 kejadian	PDSA

13. LABORATORIUM

Tabel 3.95 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	74,19%	70%	≥ 85%	72,10%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	-	80%	100%	80%	PDSA
4	Kepuasan pasien				≥76,61%		
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	PDSA
3	Angka Kerusakan Sampel Darah	0%	0,03%	0,03%	0%	0,02%	Dipertahankan
4	Angka ketidaklengkapan form permintaan laboratorium	4,43%	15,55%	34,86%	0%	18,28%	PDSA
5	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium CITO ≥30menit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Angka Reaksi Tranfusi Darah	0%	0%	0%	< 0,01%	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.99 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	0%	0%	≥ 85%	0%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-			≥ 76,61%		Belum ada pasien yang scan barcode
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	-	-	100%	-	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kelengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

15.FARMASI

Tabel 3.100 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	90,32%	100%	100%	96,78%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	100%	76,13%	≥ 85%	88,07%	PDSA
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	-	-	-	≥ 76,61 %		Belum diisi
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%		Tidak ada oba yang dimusnahk
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	73,33%	85,38%	92,00%	100%	83,57%	PDSA
2	waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	79,29%	70%	74,40%	100%	74,56%	PDSA
3	Kejadian kesalahan pernberian obat	0 kejadian	6 kejadian	4 Kejadian	0 kejadian	4 kejadian	PDSA
4	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	1 Kejadian	0 Kejadian	3 Kejadian	0 Kejadian	2 kejadian	PDSA
5	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik	1 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 Kejadian	PDSA

16. GIZI

Tabel 3.101 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan	100%	79,49%	74,36%	≥ 85%	84,62%	Dipertahankan

	tangan						
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	66,67%	81%	100%	82,56%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	95%	88,10%	93,10%	≥ 76,61%	92,07%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	≥ 90 %	100%	Dipertahankan
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	18%	18%	18%	≤ 20 %	18%	Dipertahankan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	0%	0%	0%	100%	0%	PDSA

17.REKAM MEDIS

Tabel 3.102 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	95%	88,10%	93,10%	76,61%	92,07%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	94,85%	96,18%	91,27%	100 %	94,10%	PDSA
2	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	55,17%	67,21%	55,56%	100 %	59,31%	PDSA
3	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	4 kejadian	4 kejadian	6 kejadian	0 kejadian	5 kejadian	PDSA
4	Kejadian SEP tidak diterbitkan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	74%	86%	95%	100%	85%	PDSA
6	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	27%	30,11%	36,67%	0%	31,26%	PDSA
7	Kelengkapan NIK di data pasien	97,15%	96,96%	96,76%	100%	96,96%	PDSA
8	Kelengkapan General Concent	97,73%	96,49%	91,11%	100%	95,11%	PDSA
9	Kelengkapan berkas E-RM IGD	21,29%	9,09%	66,15%	100%	32,18%	PDSA
10	Ketepatan laporan dengan pihak eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

18.LIMBAH – K3RS

Tabel 3.103 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Baku mutu limbah cair	a. BOD = 9,53 mg/l b. COD = 38,92 mg/l	a.BOD = 9,28 mg/l b. COD = 38,35	a. BOD = 15,22 mg/l b. COD = 50,59 mg/l	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l	a.BOD = 11,33 mg/l b. COD = 42,62 mg/l	Dipertahankan

		c. TSS = 5,72 mg/l d. PH =7,20	mg/l c. TSS = 5,6 mg/l d. PH 7,4	c. TSS < 5,80 mg/l d. PH 7,10	c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	c. TSS = 5,7 mg/l d. PH 7,2	
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	-	100%	100 %	100%	Dipertahankan
3.	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	66,15%	66,15%	66,15%	100%	66,15%	1 Tahun
4.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA

19.SDM

Tabel 3.104 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	22,22%	54,07%	58,96%	100 %	45,08%	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	0%	0%	0%	≥ 60 %	0%	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	0,88%	1,32%	1,09%	≤10% / bulan	1,10%	Dipertahankan
4.	Kejadian SIP staf habis masa berlaku	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	9,43%	8,55%	10,89%	0%	9,62%	PDSA
6.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPGD/GE LS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PICU	65,02%	65,92%	65,92%	100%	65,92%	PDSA
7.	Kepuasan karyawan	69%	69%	69%	≥ 80 %	69%	semesteran
8.	Respon time penanganan masalah karyawan ≤ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

20.KESEKRETARIATAN

Tabel 3.105 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100 %	100%	100%	100 %	100%	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariatan	100%	100%	96,67%	100%	96,67%	Dipertahankan
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	80%	98,18%	100%	100%	100%	PDSA
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

21.DRIVER

Tabel 3.106 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan	Standar	Rata-rata	Keterangan
-----	-----------	-------	---------	-----------	------------

		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan waktu pengantaran penggunaan ambulance < 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulance	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
3.	Response time driver ambulance < 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

22. PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel 3.107 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian pemulasaraan jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.108 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
ATEM							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	100%	75%	0,00%	≤ 80%	58,33%	PDSA
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical < 15 menit	-	100%	100%	100%	100%	Tidak ada alat medis kritikal
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal	-	-	5,12%	100%	5,12%	Alat di Kalibrasi Bulan September
IPSRS							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat non medis ≤ 15 menit	48,63%	15,96%	6,94%	100%	23,84%	PDSA
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset < 10 detik	100%	50%	0,00%	100%	50,00%	PDSA
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)			0,00%	100%	0,00%	Belum diisi

24. LAUNDRY

Tabel 3.109 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan penggunaan APD	70%	0%	0%	100%	23,33%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kejadian linen yang hilang	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
2.	Kejadian terdapat benda asing di linen	2 kejadian	2 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	PDSA
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat – alat pencucian linen	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

25. CSSD

Tabel 3.110 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	APD di area dekontaminasi						
2.	Kejadian kertas steam indicator tidak berubah sesuai standar 135 derajat (merubah pedoman di 2025)	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman	96,39%	95,93%	96,97%	100%	96,43%	PDSA (IGD, Poli, IRNA 2A)
4.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: 1. Breathing circuit 2. Begging 3. LMA 4. JR	100%	100%	100%	100%	100%	Hasil Swab Instrumen Negative
5.	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir cssd baik bersih dan kotor	96,99%	97,41%	98,48%	100%	97,63%	PDSA
8.	Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan CSSD (kecuali cito)	96,99%	96,76%	96,97%	100%	96,91%	PDSA
9.	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	PDSA

26.CLEANING SERVICE

Tabel 3.111 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Penggunaan APD	0%	98,35%	99,44%	100%	65,93%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan clening service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100%	99,34%	100%	100%	99,78%	PDSA
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	99,66%	100%	100%	99,89%	PDSA
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤3/4 Tempat sampah	100%	97,33%	92,86%	100%	96,73%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari	100%	100%	94,89%	100%	98,30%	Dipertahankan

Tabel 3.112 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, penggungjung dan karyawan	1 kejadian	1 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan	100%	99,25%	98,56%	100%	99,27%	PDSA
4.	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	1071 kejadian	485 kejadian	321 kejadian	0 kejadian	625 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan penggunaan id card pengunjung di area rumah sakit	98,60%	95,05%	95,22%	100%	96,29%	PDSA
7.	Kepatuhan penggunaan id card staff di area rumah sakit	85,48%	84,19%	87,11%	100%	85,59%	PDSA

Tabel 3.113 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	95,41%	94,81%	89,47%	100%	93,23%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka kepatuhan pengajuan pengadaan ke PT ≤ (lihat SPO)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

Tabel 3.114 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	76,39%	75,98%	74,81%	≥ 85%	75,73%	PDSA
2.	Kepatuhan APD	92,01%	83,84%	83,55%	≥ 100%	86,47%	PDSA
Indikator Mutu Komite PPI							
1.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	90%	90%	82,80%	60 %	87,60%	Dipertahankan
2.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75,19%	76,00%	76,00%	75 %	75,73%	Dipertahankan
3.	Angka infeksi daerah operasi	0%	0,55%	0%	≤ 1,5%	0.18%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	90%	100%	86,96%	100%	92,32%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
5.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	90%	88,85%	90%	100%	89,62%	PDSA
7.	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	94,11%	94,11%	90,71%	100%	92,98%	PDSA
8.	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	66,67%	69,58%	78,63%	100%	71,63%	PDSA
9.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	47,06%	47,06%	88,89%	100%	61,00%	PDSA

30.PKRS

Tabel 3.115 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	52,68%	61,61%	51,79%	100%	55,36%	PDSA
2.	Kepatuhan petugas dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	85,71%	51,79%	100%	79,17	PDSA
3.	Ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi	73,17%	30,36%	30,36%	100%	44,63%	PDSA
4.	Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)	52,68%	61,61%	58,04%	100%	57,44%	PDSA
5.	Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR (CPPT, HO, SBAR)	97,05%	100%	100%	100%	99,02%	PDSA
6.	Kepatuhan pembinaan komunitas berbasis RSPH (prognas dan geriatri)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

31.ASURANSI CENTER

Tabel 3.116 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	kepatuhan DPJP dalam penegakan diagnosa sesuai dengan ketentuan BPJS	93,00%	93,81%		80%		Belum diisi
2.	kelengkapan berkas penunjang klaim pelayanan	99,60%	99,74%		100%		Belum diisi
3.	Kepatuhan petugas rawat inap terhadap penyetoran rekam medis BPJS Kesehatan < 24jam	95,54%	95,18%		100%		PDSA
4.	kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	93,91%	94,74%		100%		Belum diisi

5.	Kejadian berkas pending klaim pasien BPJS	161 kejadian	1413 kejadian		0 kejadian		Belum diisi
----	---	--------------	---------------	--	------------	--	-------------

32.HUMAS & MARKETING

Tabel 3.117 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepuasan Pasien MCU	100%	0%	100%	≥ 76,61%	66,67%	PDSA
2.	Ketidakpatuhan perbaruan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kenaikan jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal	0,03%	0,03%	0,06%	10% / tahun	0,04%	Tahunan

33.CSO

Tabel 3.118 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Respon time CSO <30 mnt (WA)	12,21%	10,93%	10,49%	100%	11,21%	PDSA
2.	Ketepatan perubahan jadwal dokter spesialis	-			100%		Adanya SE tentang Penyesuaian Kebijakan Sesuai HFIS Versi 6.0

34.MOD-MPP-PIPP

Tabel 3.119 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	95%	88,10%	93,10%	≥ 76,61%	92,07%	Dipertahankan
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu MOD-MPP-PIPP							
3	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan form Dischard planning	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

35.TB di IRJA

Tabel 3.120 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien TB	100%	100%	100%	≥ 90%	100%	Dipertahankan

36.KUANGAN

Tabel 3.122 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan	Standar	Rata-	Keterangan
-----	-----------	-------	---------	-------	------------

		Juli	Agustus	September		rata	
1	Persentase selisih uang setoran kasir dengan LHK (Laporan harian kasir)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10 menit	0%	0%	0%	<5%	0%	Dipertahankan
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Jumlah piutang ≥ 60 hari				0%		Belum ada capaian

37.TIM HIV

Tabel 3.123 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV	100%	0%		≥ 90%		Belum diisi

38.KB

Tabel 3.124 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan pengisian kartu K4 KB	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Angka terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca keguguran	13,16%	18,18%	17,56%	50%	16,30%	PDSA
3.	Semua ibu melahirkan dan curretage mendapatkan KIE KB	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	86,86%	96,80%	89,73%	30%	91,13%	Dipertahankan

39.STUNTING

Tabel 3.125 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita1x dalam sebulan	0%	0%	100%	100%	33,33%	PDSA
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3bulan sekali				100%	-	Triwulanan PDSA
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

40.IT - SIM RS

Tabel 3.126 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap	100%	100%	94,44%	100%	98,14%	PDSA

	penanganan internet dan billing error < 10 mnt						
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	100%	100%	85,71%	100%	95,23%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	54,76%	47,62%	53,85%	100%	52,07%	PDSA

1.9 Kinerja Produktifitas Profil SDM

1.9.1 Ketenagaan

Distribusi SDM

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
1	Direktur	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
2	Kepala Bidang Pelayanan Medis	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
3	Kepala Bidang Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	0	1	0	0	1
4	Kepala Bidang Penunjang Medis	S1 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
5	PLT Kepala Bidang Umum & Keuangan	S1 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
6	Staf Medis	Dokter Umum IGD	10	9	1	9	0	0	0	68
		Dokter Umum MCU	7	7	0	7	0	0	0	
		Dokter Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Emergency	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anak	4	4	0	3	1	0	0	
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	6	6	0	6	0	0	0	
		Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Anak	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Plastik	2	1	1	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Neurologi	4	4	0	4	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Dokter Spesialis Paru	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Mata	3	3	0	2	1	0	0	
		Dokter Spesialis Kulit Kelamin	2	1	1	1	0	0	1	
		Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis THT	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Urologi	2	1	1	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Konservasi Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Gigi Anak	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anestesiologi	3	3	0	3	0	0	0	
7	IRNA II A	D3 Keperawatan	26	14	0	2	9	0	0	26
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		12	0	10	2	0	0	
8	IRNA II B	D3 Keperawatan	24	12	0	4	8	0	1	24
		D4 Keperawatan		2	0	2	0	0	0	
		Profesi Ners		10	0	7	3	0	0	
9	IRNA III A	D3 Keperawatan	20	12	0	4	8	0	0	20
		D4 Keperawatan		1	0	0	1	0	0	
		Profesi Ners		7	0	4	3	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
10	IRNA III B	D3 Keperawatan	21	4	0	2	2	0	0	21
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		17	0	14	3	0	0	
11	Neonatologi	D3 Keperawatan	2	2	0	1	1	0	0	2
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		0	0	0	0	0	0	
12	Maternitas	D3 Kebidanan	14	3	0	0	3	0	0	14
		D4 Kebidanan		9	0	2	7	0	0	
		S1 Kebidanan		2	0	0	2	0	0	
13	ICU	D3 Keperawatan	11	4	0	1	3	0	0	11
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		7	0	2	6	0	0	
14	NICU	D3 Keperawatan	9	5	0	1	4	0	0	9
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		4	0	0	4	0	0	
15	IGD	D3 Keperawatan	26	7	0	3	4	0	0	26
		D3 Kebidanan		3	0	1	2	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		2	0	1	1	0	0	
		Profesi Ners		14	0	11	3	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
16	IKO	D3 Keperawatan	13	10	0	6	4	0	0	13
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		3	2	1	2	0	0	
17	IRJA	D3 Keperawatan	25	13	0	2	11	0	0	25
		D3 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		D4 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kebidanan		1	1	0	1	0	0	
		Profesi Ners		6	0	3	3	0	0	
18	Rehab Medik	D3 Fisioterapi	5	1	0	1	0	0	0	5
		D4/S1 Fisioterapi		4	0	4	0	0	0	
19	HD	D3 Keperawatan	5	2	0	0	2	0	0	5
		S1 Profesi Ners		3	0	1	2	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
20	Perawat MCU & Klinik Perusahaan	D3 Keperawatan	8	5	0	4	1	1	0	6
		S1 Profesi Ners		1	2	1	0	0	0	
		S2 Psikolog	1	1	0	1	0	0	0	1
21	Farmasi	SMA/ SMK Farmasi	3	3	0	2	1	0	0	46
		S1 Admin Farmasi	2	2	0	1	1	0	0	
		D3 Farmasi	24	23	0	17	5	0	0	
		D3 Analis Farmasi	1	1	0	1	0	0	0	
		S1 Farmasi	4	4	0	4	0	0	0	
		Apoteker	12	12	0	5	7	0	0	
22	Rekam Medis	D3 RMIK	9	8	0	5	3	0	0	9
		D4 RMIK		1	2	0	1	0	0	
23	Pendaftaran	SMA/SMK	18	1	0	0	3	0	0	19
		D1		1	0	1	0	0	0	
		D3		7	0	3	4	0	0	
		D4		2	0	1	1	0	0	
		S1		7	0	4	3	0	0	
24	Laboratorium	D3 Analis Kesehatan	12	10	0	2	8	0	0	12
		D4 Analis Kesehatan		2	0	1	1	0	0	
25	Radiologi	SMA/SMK	8	0	0	0	0	0	0	7
		D3 Radiologi		7	1	5	2	0	0	
26	CSSD	SMA/SMK	4	3	0	1	2	0	0	4
		D3 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	0	1	0	0	
27	Laundry	SMA/SMK	6	5	0	2	3	0	0	6
		D1		1	0	1	0	0	0	
28	Ahli Gizi	D3 Gizi	5	3	0	3	0	0	0	6
		D4 Gizi		2	0	0	2	0	0	
		S1 Gizi		1	0	0	1	0	0	
29	Dapur & Pantry	SMA/SMK	15	15	0	6	9	0	0	15
30	Keuangan & Akuntansi	SMA/SMK	10	0	0	0	0	0	0	10
		D1		1	0	0	1	0	0	
		D3		0	0	0	0	0	0	
		S1		9	0	2	7	0	0	
31	SDM & Diklat	S1 Psikologi	2	1	0	1	0	0	0	2
		S1 Manajemen		0	0	0	0	0	0	
		S1 Kesehatan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Lainnya		0	0	0	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
32	Asuransi Center	SMA/SMK	13	0	0	0	0	0	0	13
		D3 RMIK		7	0	5	2	0	0	
		D3 Asuransi Kesehatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 RMIK		1	0	0	1	0	0	
		D4 Asuransi Kesehatn		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kesehatan / Lainnya		4	0	1	3	0	0	
33	Humas Marketing	S2 Manajemen Kesehatan	1	0	0	0	0	0	0	1
		S1 Marketing		0	0	0	0	0	0	
		D3 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
34	Sekretariat	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
35	Security	SMA/SMK	11	11	0	4	7	0	0	11
36	Parkir	SMA/SMK	12	11	0	11	0	0	0	12
		S1 Lainnya		1	0	1	0	0	0	
37	Driver	SMA/SMK	7	7	0	0	7	0	0	7
38	Cleaning Service	SMA/SMK	42	40	0	13	28	0	0	42
		D3		1	0	0	1	0	0	
39	Tukang Kebun PHL	SMA/SMK	3	1	0	0	1	0	0	3
		SMP		2	0	2	0	0	0	
		SD		0	0	0	0	0	0	
40	IPSRs	SMA/SMK	4	4	0	3	1	0	0	6
		D3 ATEM	2	2	0	2	0	0	0	
		Admin IPSRS	0	0	0	0	0	0	0	
41	Gudang Umum	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
42	IT & SIMRS	D4 Teknologi Informasi	3	0	0	0	0	0	0	3
		S1 Teknologi Informatika		2	0	2	0	0	0	
		S1 Lainnya		1	0	0	1	0	0	
43	PKRS	DIV Promosi Kesehatan	1	1	0	1	0	0	0	1
44	Mutu	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	1	0	0	0	1
45	PPI	S1 Profesi Keperawatan	1	1	0	0	1	0	0	1
46	K3RS	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	0	1	0	0	1
47	MOD/MPP	D3 Keperawatan	5	2	0	0	2	0	0	5
		D3 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		Profesi Ners		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
TOTAL			532	522	13	275	245	2	3	526

Keterangan : Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Bulan September 2025 terdapat jumlah staf sebanyak 528 orang dari total kebutuhan sejumlah 532 orang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah kekurangan staf sejumlah 13 orang dengan jumlah staf resign sejumlah 3 orang dari 1 Dokter Spesialis Kulit, 1 Dokter Ruangan, 1 Staf Perawt. Selain 3 orang staf yang resign pada Bulan Agustus 2025, terdapat 4 tenaga klinis baru yaitu 2 orang TTK dan 2 orang perawat.

Update SIP dan NED 6 Bulan

No.	Nama	Profesi	Nomor SIP	Tanggal Berlaku SIP	Masa Berlaku
Terproses					
1	Amilia Dwi Lismawati, A.Md.Farm	TTK	NR35142507014088	28 Juli 2025	25 Desember 2030
2	dr. Ahmad Akbar Ridho Mustawa	Dokter Umum	MR35142507013289	23 Juli 2025	22 Juli 2030
3	dr. Magda Budi Pramistyowati	Dokter Umum	MR35142507009286	23 Juli 2025	25 Mei 2030
4	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT.	Dokter Spesialis Ortopedi	MR35142508009361	27 Agustus 2025	04 Oktober 2030
5	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG	Dokter Spesialis Obgyn	MR35142509000683	01 September 2025	10 Desember 2030
6	dr. Arianto Prabowo, Sp. OT	Dokter Spesialis Ortopedi	MR35142509018957	30 September 2025	09 November 2030
7	Zjakiatul Wahyuning Rima, Amd. Kep	Perawat	NR35142506000058	02 Juni 2025	08 September 2030
8	Al Alief Banat Amanda, S.Tr.Keb	Bidan	NR35142506004264	10 Juni 2025	29 September 2030
9	Lillo Palupi Armaidah, A.Md.Kep	Perawat	NR 35142509006244	09 September 2025	21 Oktober 2030
10	Robikatul Adawiyah, A.Md.Keb	Bidan	NR35142508013852	27 Agustus 2025	23 Oktober 2030
Masa Berlaku Kurang dari 6 Bulan					
1	Fiski Purantoro, Sp.OT	Dokter Spesialis Ortopedi	46/SIP-DS/75/424.072/2022	3 Juni 2022	12 Desember 2025
2	dr. Ferry Limantara, Sp.EM	Dokter Spesialis Emergency	46/SIP-DS/27/424.072/2021	13 April 2021	4 Januari 2026
3	Yekti Mumpuni, Sp.KJ.	Dokter Spesialis Jiwa	46/SIP-DS/59/424.072/2020	0 November 2020	8 Januari 2026
4	Muhammad Bagus Khafidti, Amd Kep	Perawat	03/023/SIP-P/II/424.086/2022	28 Januari 2022	0 Oktober 2025
5	Syarif Hidayatullah, A.Md.Kep	Perawat	46/SIK-P/100/424.072/2021	15 Februari 2021	21 November 2025
6	Irawati., Amd Kep		46/SIK-P/261/424.072/2021	9 Juni 2021	0 Januari 2026
7	Muhammad Galih Adiwibowo, S.Kep.,Ns		46/SIK-P/335/424.072/2021	15 Juli 2021	2 Januari 2026
8	ni Masruroh., Amd Kep		03/182/SIP-P/IV/424.086/2022	11 Mei 2022	4 Januari 2026
9	Daniel Pradana Putra, S.Kep., Ns		03/210/SIP-P/IV/424.086/2023	28 April 2023	0 Januari 2026
10	usnita Faradiba., S.Kep Ns		03/190/SIP-P/IV/424.086/2022	11 Mei 2022	0 Januari 2026
11	Hesty Putri Wulandari, S.Tr.Kes		503/031/SIP-ATLM/B-VII/424.086/2021	29 Juli 2021	0 Januari 2026
12	Muhammad Abil., Amd Kep		03/227/SIP-P/IV/424.086/2022	27 Mei 2022	Februari 2026
13	Bella Fitra Mardatillah, S.Kep., Ns		03/068/SIP-P/II/424.086/2023	13 Februari 2023	Februari 2026
14	ebby Hidayati., Amd Kep		46/SIK-P/235/424.072/2021	20 Mei 2021	Februari 2026

o.	Nama	Profesi	Nomor SIP	anggal Berlaku SIP	asa Berlaku
	Sp.EM	Spesialis Emergency			
6	Yekti Mumpuni, Sp.KJ.	Dokter Spesialis Jiwa	46/SIP-DS/59/424.072/2020	0 November 2020	Januari 2026
7	Zjakiatul Wahyuning Rima, Amd. Kep	Perawat	446/SIP/346/424.072/2020	7 Desember 2020	8 September 2025
8	l Alief Banat Amanda, S.Tr.Keb	Bidan	46/SIK-B/030/424.072/2021	25 Maret 2021	8 September 2025
9	Muhammad Bagus Khafidti, Amd Kep	Perawat	03/023/SIP-P/II/424.086/2022	28 Januari 2022	Oktober 2025
10	illo Palupi Armaidah, A.Md.Kep	Perawat	46/SIK-P/103/424.072/2021	5 Februari 2021	Oktober 2025
11	Robikatul Adawiyah, A.Md.Keb	Bidan	03/018/SIP-B/II/424.086/2023	17 Januari 2023	Oktober 2025
12	Gilda Fathia Azizi, A.Md.Kep	Perawat	3/690/SIP-P/XII/424.086/2023	2 Desember 2023	November 2025
13	Syarif Hidayatullah, A.Md.Kep	Perawat	46/SIK-P/100/424.072/2021	5 Februari 2021	November 2025

Tabel 3. Mutasi/Rotasi SDM Unit

No	Nama	Jabatan/Unit Asal	Jabatan/Unit Tujuan	Tanggal Mutasi/rotasi
1	Ayu Widayanti, S.Kep., Ns	IRNA II B	IGD	01/09/2025
2	Ned' Dianti Septika, S.Kep., Ns	IGD	IRJA	01/09/2025
3	Maulana Anang Ramadhan, S.Kep., Ns	ICU	IRNA II B	01/09/2025
4	Aisyah Pembayun Al-Zahid, A.Md.RMIK	Asuransi Center	Rekam Medis	01/09/2025
5	Maya Agustina, A.Md.Kes	Rekam Medis	Asuransi Center	01/09/2025
6	Bagas Surya Purwono, A.Md.Kep	Kepala Ruang IRNA II B	Kepala Ruang IRJA	01/09/2025
7	Siti Maysaroh, A.Md.Kep	Kepala Bidang Keperawatan	Kepala Ruang IRNA II A	01/09/2025

Keterangan : Pada Bulan September 2025 terdapat 7 staf yang dirotasi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan unit yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

1.9.2 Pendidikan dan Pelatihan

Pada Bulan September Tahun 2025 terdapat 1 diklat yang terlaksana, dengan rincian 1 diklat internal dan 1 diklat eksternal.
Tabel Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM (Diklat) Karyawan di RSPH Sukorejo Bulan September Tahun 2025

Diklat Internal

N O	Tema DIKLAT /WS/SEM/ WB	Sasara n	JUMLAH PESERTA			Tanggal	Pr e te s	Pos t Tes	Evaluasi Penyelenggar an diklat (cek list ada nilai standard)	Efektifit as Media	Efektifit as Metode	Sertifik at		Hasil evalua si dalam kinerja sehari-hari (lapora n karu)
			Un d	Hadi r	Abse n							sdh	blm	
1	KE	Klinis dan	431	278	278	16, 22, 24, 26			Pesentasi pelaksanaan	Praktik	Praktik		√	

		Non Klinis				Septemb er 2025			diklat tersebut sejumlah 64,5 %					
--	--	---------------	--	--	--	--------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Diklat Eksternal

No.	Nama Diklat	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1.	latihan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)	Luring	4 Agustus – 5 November 2025

1.10 Kemajuan Piutang

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
											0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	
		a	b	c	(a-b-c= d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h						Total
	PERIODE SEPTEMBER 2025 :															
1	Asuransi	633.837.152	415.840.123	2.827.667	215.169.362	442.006.372	120.479.515	3.548.389	317.978.468	533.147.830	455.655.056	69.302.240	-	6.506.761	1.683.774	533.147.830
2	Perusahaan	507.579.900	411.320.633	8.144.880	88.114.387	540.858.154	31.764.040	1.149.725	507.944.388	596.058.775	564.685.154	3.311.491	18.263.563	-	9.798.567	596.058.775
3	Mandiri Inhealth	137.090.206	64.819.715	1.276.765	70.993.726	27.636.842	-	-	27.636.842	98.630.569	63.642.937	33.370.823	1.616.808	-	-	98.630.569
4	Jasa Raharja	350.462.625	329.749.413	2.238.449	18.474.763	318.210.065	173.843.737	0	144.366.328	162.841.090	150.326.092	6.987.550	4.379.368	-	1.148.081	162.841.091
5	Kantin	12.318.350	3.519.950	- 100	8.798.500	17.866.800	-	-	17.866.800	26.665.300	19.932.950	670.400	-	3.270.400	2.791.550	26.665.300
6	BPJS Ketenagakerjaan	829.130.097	718.894.040	3.851.556	106.384.501	739.048.242	-	-	739.048.242	845.432.742	843.340.549	931.369	-	-	1.160.824	845.432.742
JUMLAH PIUTANG										2.262.776.307	2.097.582.738	114.573.873	24.259.739	9.777.161	16.582.796	2.262.776.307

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

RS Prima Husada Sukorejo yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Letak Geografis yang strategis dekat dengan banyak Perusahaan mengharuskan RS Prima Husada Sukorejo berinovasi memberikan pelayanan yang prima dan diminati kalangan sekitar.

Pemanfaatan Gedung semaksimal mungkin ditujukan untuk dapat memberikan pelayanan yang nyaman untuk Masyarakat daerah Pasuruan. Pemenuhan layanan-layanan Kesehatan juga dijadikan daya Tarik dalam mencapai pasar. Pengembangan layanan penunjang dimaksimalkan untuk menambah daya Tarik rumah sakit.

Penambahan pelayanan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang ada. Melakukan update kebijakan sesuai standart dan peraturan yang terbaru serta pengupayaan berupa refresh pelatihan berkala menjadi agenda rumah sakit. Ketersediaan pemenuhan jabatan diharap akan berdampak positif dalam peningkatan kegiatan supervise berjenjang.

4.2 SARAN

- 4.2.1.1 Meningkatkan pelayanan yang prima kepada stakeholder rumah sakit
- 4.2.1.2 Meningkatkan kepatuhan DPJP terkait peraturan terbaru rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan
- 4.2.1.3 Meningkatkan monitoring evaluasi berjenjang untuk memastikan pelayanan sesuai standart dan visi misi rumah sakit
- 4.2.1.4 Menambah layanan rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat

BAB V PENUTUP

Demikian laporan Bulan September ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Sukorejo, 05 Oktober 2025

Plt Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep